La crueldad hecha rutina:

La criminalización del aborto en el Perú

proyecta igualdad

Justicia Verde

PODRÍA SER YO

POR UNA SALUD SIN MIEDOS

Título:
La crueldad hecha rutina: Criminalización del aborto en el Perú 2012-2022

Derechos de edición:

Proyecta Igualdad
Av. Alberto del Campo 411, piso 10, San Isidro, Lima, Perú.

Justicia Verde
Clínica legal por el derecho a decidir
justiciaverdeperu.org
Av. Alberto del Campo 411, piso 10, San Isidro, Lima, Perú.

Responsables del estudio:
Brenda Ibette Alvarez Alvarez
Ella Goñez Fernandez
Carolina Neyra Sevilla
Francesca Graciela Encalada Yong
Eurídice Lizeth Vargas Velarde
Mariana Isabel Gallo Alarcón
Lucero Carolina Cuba Varas

Coordinación Editorial:
Brenda Ibette Alvarez Alvarez

Diseño de portada:
Meduclau - Claudia Fernanda Flores Calderón

Diagramación:
FCV - Publicaciones y comunicaciones

Impresión:
IMPRESIONES ART & COLOR EIRL
Jr. Huancavelica 873 - 103 Lima 1.

ISBN:

Año de publicación: Primera edición, abril 2025

Tiraje: 300 ejemplares
Lima, Perú.

Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2025-03146

Esta investigación se desarrolló en el marco de la iniciativa regional "Podría ser yo, por una salud sin miedos", cuyo objetivo es documentar cómo el sistema de justicia penal ha abordado los casos de presuntos abortos voluntarios en seis países de América Latina y el Caribe entre 2012 y 2022. La iniciativa es co-liderada por la abogada Ximena Casas Isaza y Ríos, una organización comprometida con la justicia social a través del uso estratégico del derecho.

Índice

Introducción 9

CAPÍTULO 1.
Contexto y objetivos de la investigación 11

CAPÍTULO 2.
Metodología 14

2.1. Análisis de estadísticas de entidades públicas 17

2.2. Análisis de expedientes y sentencias 17

2.3. Entrevistas a actores clave: personas criminalizadas, funcionariado y activistas 22

CAPÍTULO 3.
Marco normativo que criminaliza el aborto en el Perú 23

3.1. La regulación penal del aborto en Perú 24

3.2.El deber de confidencialidad, intimidad, secreto profesional y la obligación de denuncia en casos de aborto criminal 26

3.2.1. La obligación de denuncia 26

3.2.2. El secreto profesional, el deber de confidencialidad y la protección de la intimidad 27

3.3. La regulación del aborto en el DIDH: normativa aplicable al Perú 28

3.3.1. Estándares internacionales sobre el aborto 29

3.3.2. Estándares sobre el aborto en el Sistema Universal de Derechos Humanos 31

3.3.3. Conclusión general 36

CAPÍTULO 4.
La criminalización del aborto en cifras 37

4.1. Denuncias ingresadas en la Policía Nacional del Perú 40

4.2. Delitos de aborto en fiscalías....42
4.3. Defensa pública: Patrocinios a personas acusadas....45
4.4. Procesos judiciales por aborto....46
4.5. Población penal por delito de aborto....47
4.6. Población adolescente en Centros Juveniles....49
4.7. Tasa de criminalización del aborto en el Perú....50

CAPÍTULO 5.
¿Cuáles son las características de las personas imputadas?....54

5.1 Edad de las imputadas....56
5.2. Condición económica de las personas imputadas....57
5.3. Grado de instrucción de las MPG....60
5.4. Factores de vulnerabilidad identificados....61
5.5. Otras características de las MPG....64
5.6. Características de las experiencias de aborto....66
5.7. Motivaciones para abortar....71

CAPÍTULO 6.
¿Cuáles son las características de los procesos penales?....72

6.1. Regulación de los procesos penales en el Perú....73
6.2. ¿Dónde inicia la criminalización del aborto?....74
6.2.1. Los establecimientos públicos de salud....74
6.2.2. Intervención policial: operativos a consultorios....77
6.2.3. Ministerio Público: La fiscalía también inicia procesos....78
6.3. ¿Cómo se conducen y analizan los procesos penales iniciados por los delitos de aborto?....79
6.4. La ruta de la criminalización....92

CAPÍTULO 7.
¿Cuál es el impacto que los procesos penales tuvieron y tienen sobre las personas imputadas?.....94

7.1. Impacto emocional.....96

7.2. La criminalización como evento traumático.....97

7.3. Secuelas a largo plazo: proyecto de vida.....98

7.4. Silenciamiento y aislamiento social.....99

CAPÍTULO 8.
¿Qué factores inciden en efectos más o menos graves para las personas imputadas?.....100

8.1. Seguridad del procedimiento.....101

8.2. Información y autonomía reproductiva.....102

8.3. Nivel socioeconómico y etnicidad.....102

8.4. Enfoque de la defensa legal.....104

8.5. Nivel de soporte del entorno cercano.....105

8.6. Nivel de prejuicios en operadores públicos.....105

CAPÍTULO 9.
Vulneraciones a los derechos humanos y garantías procesales identificadas.....107

9.1. Vulneraciones Identificadas en los establecimientos de salud.....109

9.1.1. Derecho al secreto profesional y el deber de confidencialidad.....109

9.1.2. Garantías procesales.....111

9.1.3. Derecho a la integridad personal y violencia obstétrica.....114

9.1.4. Derecho a la libertad personal.....116

9.2. Vulneraciones al debido proceso identificadas en el proceso penal.....117

9.2.1. Derecho a probar y controlar la prueba.....117

9.2.2. Derecho a la defensa.....119

9.2.3. Privación de libertad.....121

9.2.4. Plazo razonable.....122
9.2.5. Solicitudes de conclusión anticipada del juicio.....123
9.3. Vulneraciones identificadas en las decisiones judiciales.....125
9.3.1. Estereotipos de género: detonador de múltiples vulneraciones.....126
Conclusiones.....132
Recomendaciones.....135
Bibliografía.....141
Anexos.....146

Glosario

El siguiente glosario se basa en la metodología de la Iniciativa Regional sobre Criminalización del Aborto (IRCA). Sobre esta base, se han agregado y/o ajustado algunos términos relevantes para el análisis realizado en el contexto peruano.

Criminalización: fenómeno amplio que involucra prácticas y normas coercitivas en relación al aborto y en función de una persona individualizada a la que se la acusa de ese crimen o de un delito conexo con él. En general involucra a las fuerzas de seguridad y el orden, al poder judicial, a veces al sistema penitenciario y potencialmente, incluso, al sistema sanitario cuando la denuncia surge de clínicas y hospitales en violación al secreto profesional y el deber de confidencialidad(IRCA, 2023, p.19). La criminalización del aborto implica la imposición de sanciones legales, estigmatización social, violencia obstétrica y discriminación hacia quienes experimentan un aborto o evento obstétrico, lo que afecta su salud mental, bienestar y derechos humanos[1].

Aborto espontáneo: casos en los cuales la interrupción del embarazo no es provocada (World Health Organization, 1995, p. 19).

Aborto inducido: casos en los cuales se realizan acciones deliberadas para interrumpir un embarazo. Incluyen aquellos realizados conforme a la ley o no, y pueden ser con consentimiento de la persona gestante (abortos voluntarios) o sin su consentimiento (involuntarios)(World Health Organization, 1995, p. 19).

Aborto no forzado[2]: Para efectos de solicitar y analizar datos de entidades públicas sobre procesos vinculados a los delitos de aborto consignados en el Código Penal, hemos construido la categoría *Aborto no forzado* para agrupar aquellos tipos penales en los que se podría presumir que la decisión de interrumpir el embarazo no ha sido forzada por terceros. Así, esta categoría agrupa a los artículos 114º (Autoaborto), 115º (Aborto consentido), 117º (Aborto por la calidad del sujeto), 119º (Aborto terapéutico) y 120º (Aborto sentimental o eugenésico). Es decir, se excluyeron los tipos penales 118º (Aborto preterintencional) y 116º (Aborto sin consentimiento), en los que explícitamente la voluntad de la persona gestante es vulnerada.

Evento obstétrico: puede ser un aborto voluntario, un aborto espontáneo, una cesárea, un parto, o cualquier otro evento que finaliza el embarazo. En esta investigación, cuando nos referimos a evento obstétrico, entendemos aborto inducido voluntariamente o involuntariamente (por ejemplo, provocado por un tercero en una situación de violencia), aborto espontáneo, o embarazo a término con feto muerto (Zavala-García, Ortiz-Reyes, Salomon-Kuri, Padilla-Amigo, & Preciado Ruiz, 2018).

Estereotipos de género: Creencias preconcebidas y generalizadas sobre cómo deben ser y actuar las personas en función de su género asignado al nacer. Los estereotipos están arraigados en normas sociales y culturales que asignan roles específicos a hombres y mujeres, limitando así la libertad individual y perpetuando desigualdades de género. Al ser generalizados, los estereotipos de género influyen en diversas áreas de la vida, como en el ámbito laboral, familiar, educativo y legal, y suelen tener un impacto negativo en la autonomía y derechos de las personas (Cook & Cusack, 2010).

1. Definición construida a partir de la reflexión colectiva de las autoras y autores.
2. Definición construida a partir de la reflexión colectiva de las autoras y autores.

Interseccionalidad: es un concepto acuñado dentro de la teoría crítica de la raza, que refiere al fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Es decir, que la pluralidad de componentes tales como el género, la raza, la clase, la edad, la discapacidad (o no), la condición de migrante (o no), entre otras, confluyen ya sea multiplicando las desventajas y discriminaciones o las ventajas y privilegios; y cada factor alterna su relevancia o prevalencia según el contexto y la interacción concreta[3] (IRCA, 2023, p.20).

Denuncia: acto mediante el cual se pone en conocimiento de las autoridades un delito cometido[4].

Sobreseimiento: Resolución firme que emana del órgano jurisdiccional competente, mediante la cual se pone fin a un procedimiento penal iniciado (Salinas Siccha, 2006).

Archivo: cierre de un proceso penal por inexistencia de delito o imposibilidad de proceder con la investigación (IRCA, 2023, p.21).

Terminación anticipada: proceso especial en virtud del cual el imputado y el fiscal solicita al juez de la investigación preparatoria, que, tras el reconocimiento de la responsabilidad penal por el delito, imponga una pena prevista en el Código Penal reducida en una sexta parte (San Martín, 2020, p.1142)

Sentencia: pronunciamiento definitivo (no preliminar) de un órgano jurisdiccional respecto de la culpabilidad o no del imputade, en la forma de condena o absolución(IRCA, 2023, p.21).

3. Definición construida a partir Crenshaw, Kimberlé, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color", en Stanford Law Review, vol. 43, nº 6, Palo Alto, 1991, págs. 1241-1299; Corte IDH, caso "Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador", Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 1 de septiembre de 2015.
4. Definición construida a partir de la reflexión colectiva de las autoras y autores.

Introducción

*"Muchas veces hemos llamado la atención sobre un fenómeno denominado **la crueldad hecha rutina**. Ese fenómeno, aparentemente invisible para muchas personas que trabajan en la justicia, produce los peores efectos (...). La persecución penal funciona, muchas veces, como parte de mecanismos disciplinadores del propio Estado, reproduciendo sesgos y discriminaciones que están presentes en nuestra cultura"*

(Guía para la defensa en el litigio penal de casos de criminalización de emergencias obstétricas en la provincia de Buenos Aires, 2023: pp. 6-8)

El presente estudio analiza la criminalización del aborto en el Perú y la consecuente vulneración de los derechos de las mujeres y personas gestantes imputadas (MPG, en adelante). Como parte de la Iniciativa Regional sobre Criminalización del Aborto (IRCA, en adelante), este proyecto, aplicado al contexto peruano, contribuye a la labor conjunta de varios países latinoamericanos (República Dominicana, Brasil, Perú, Chile y Uruguay) de caracterizar los procesos penales por aborto e identificar patrones de vulneración de los derechos humanos y garantías procesales de MPG criminalizadas.

Para llevar a cabo esta investigación se combinaron métodos cuantitativos y cualitativos que incluyen (i) el análisis de estadísticas de 45 entidades públicas, (ii) el análisis cuantitativo y cualitativo de 100 sentencias y 15 expedientes judiciales, (iii) la aplicación y análisis de entrevistas semiestructuradas a 17 MPG y actoras clave y (iv) el análisis de noticias de 65 medios a nivel nacional. Todo ello para abordar de manera integral la criminalización del aborto en Perú y analizar sus implicaciones en los derechos humanos y la autonomía reproductiva de las MPG en el país.

Nuestro estudio da cuenta de cómo, cuando hablamos de aborto en el Perú, la discusión inicia en un sistema de salud que ha hecho suya la inquisición del aborto. Los hospitales públicos, en particular, han demostrado ser la puerta de entrada al sistema penal para las MPG que llegan a solicitar atención en situaciones de postaborto o con una emergencia obstétrica. Con ello, se marca el inicio de un proceso caracterizado por vulnerar derechos y garantías procesales, al presentar vicios que convierten los procesos en arbitrarios e inciertos para las MPG sometidas a proceso. Además, intervienen múltiples actores como personal de salud, Policía Nacional del Perú (PNP, en adelante), Ministerio Público – Fiscalía de la Nación (MPFN, en adelante) y Poder Judicial, contribuyendo de manera significativa a la revictimización de las MPG y sus redes de apoyo.

La criminalización del aborto tiene efectos profundos en las personas imputadas, generando altos niveles de miedo, ansiedad y estrés, así como secuelas emocionales a largo plazo (cuadros depresivos y estrés postraumático). Además, conduce a un aislamiento multidimensional, provocando la ruptura de relaciones interpersonales, limitando oportunidades laborales y económicas, y generando un impacto negativo en la calidad de vida de las personas involucradas.

Esto es particularmente grave, pues las personas más vulnerables a la criminalización suelen ser mujeres empobrecidas provenientes de entornos estigmatizados, con poca autonomía reproductiva y limitado acceso a información y capital cultural. Además, destaca el impacto diferenciado por etnia y nivel socioeconómico, donde las regiones con mayores índices de judicialización de abortos son habitadas mayoritariamente por mujeres quechuas y de bajos recursos económicos. Dentro de ellas, destacan los casos de Apurímac y Ayacucho, donde existe una mayor persecución en hospitales públicos y se exacerba su vulnerabilidad.

Este informe se divide en siete capítulos. Los capítulos 1 y 2 presentan el contexto, objetivos y metodología del estudio. Los capítulos 3 y 4 ofrecen información clave para enmarcar el fenómeno: mientras que el capítulo 3 desarrolla el marco legal de la regulación del aborto en el Perú, el capítulo 4 contextualiza a través de cifras el estado actual de la persecución del aborto en el país con un instrumento que denominamos "tasa de criminalización" como herramienta para identificar zonas con mayor o menor criminalización.

El capítulo 5 desarrolla la caracterización de las personas imputadas por aborto, desde un enfoque de análisis de las múltiples vulnerabilidades. El capítulo 6 se enfoca en las características de los procesos penales, y se identifica una ruta de la criminalización común.

El capítulo 7 aborda los impactos que tienen los procesos de criminalización en las personas imputadas, con un énfasis en los efectos en el bienestar y proyecto de vida. El capítulo 8 presenta aquellos factores de riesgo o que inciden en efectos más graves para las personas imputadas, así como los factores protectores o que inciden en efectos menos graves para las personas imputadas.

Con un lenguaje de derechos humanos, el capítulo 9 ofrece un análisis exhaustivo de las vulneraciones a las garantías procesales y derechos de las MPG que son perseguidas penalmente por la justicia peruana. Concluimos que las violaciones cometidas no son de dominio de una sola institución o etapa del proceso penal. Por el contrario, pueden ser identificadas desde el ingreso al establecimiento de salud hasta la adopción de una decisión final. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio.

Desde Proyecta Igualdad esperamos que esta investigación contribuya a desterrar la creencia de que las sanciones penales al aborto en el Perú son solo simbólicas. Así también, a dimensionar el impacto de la criminalización del aborto en la vida y sueños de las MPG que son perseguidas por una emergencia obstétrica. Niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes que, además de enfrentarse al desdén de un Estado que les niega el acceso a un servicio de salud seguro y de calidad, se enfrentan a un sistema de salud y justicia que ha institucionalizado una cultura de la crueldad a través del castigo penal. Pero, además, esperamos que este estudio mueva corazones y mentes para la construcción de una sociedad más consciente y empática de la realidad de quienes experimentan abortos voluntarios o involuntarios.

Nuestros hallazgos, además, ponen de manifiesto la urgente necesidad de impulsar reformas estructurales en la legislación penal, tanto en el ámbito de salud como en la justicia para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y las garantías procesales de todas las personas, especialmente de quienes enfrentan una mayor vulnerabilidad como las relacionadas con eventos obstétricos.

CAPÍTULO 1

Contexto y objetivo de la investigación

La criminalización del aborto en el Perú no se limita únicamente al ámbito penal ni se reduce a las mujeres que enfrentan condenas por el delito de aborto. Cuando nos referimos a la criminalización del aborto, estamos hablando de un fenómeno en el cual los actores de instituciones públicas y privadas consideran como un acto criminal la interrupción del embarazo por parte de la MPG, lo que afecta al 19% de las mujeres en edad reproductiva, según datos del IOP-PUCP (2019).

A pesar de que el Código Penal peruano, en general, tipifica como delito la interrupción del embarazo, exceptuando el aborto terapéutico, al hablar de criminalización en este texto también hacemos referencia a un conjunto de prácticas violentas y discriminatorias dirigidas hacia MPG que experimentan un aborto, sin importar si fue inducido o no, ni si tenían la intención de hacerlo. De esta manera, la criminalización afecta diversas dimensiones de la experiencia de las personas gestantes: la personal, social y económica. En este punto, es importante señalar que el Perú es uno de los países en los que la opinión pública es más sancionadora respecto a las mujeres que deciden abortar: según una encuesta global de IPSOS (2023) en 29 países, el 54% de peruanos consideró que las mujeres que se realizan un aborto deberían enfrentar una sanción, cifra más alta de la región (Colombia = 49%; Chile = 45%; Argentina = 37%; Brasil = 35%).

De acuerdo con el estudio de Cuba et al. (2022), desde 2016 hasta 2021, se han registrado más de 262,000 casos de aborto que han sido atendidos en establecimientos de salud públicos. Entre estos casos, un número significativo, específicamente 13,825, involucra a niñas y adolescentes.

Ascarza y Torres (2022) señalaron que 42 mujeres fueron sometidas a investigaciones por haber realizado un aborto o intentado hacerlo entre los años 2011 y 2021. Estas investigaciones tuvieron lugar en once tribunales ubicados en Arequipa, Puno, Tacna, Cajamarca, Huancavelica, Lima y Callao. Las autoras identificaron estas historias a través de un análisis de 131 sentencias relacionadas con casos de aborto obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información pública. La recopilación de estas resoluciones judiciales pone de manifiesto cómo, tanto los sistemas de atención médica como los sistemas judiciales, persiguen y ejercen violencia contra las mujeres que no cumplen con las expectativas sociales impuestas sobre ellas en relación con la maternidad.

El presente estudio hace parte de la Iniciativa Regional sobre criminalización del aborto (IRCA). En el contexto peruano, este proyecto contribuye a la labor conjunta de varios países latinoamericanos que elaborarán informes nacionales sobre la mencionada problemática. La coalición de países y organizaciones participantes en esta iniciativa incluye a República Dominicana (Cladem), Brasil (Anis), Perú (Proyecta Igualdad), Chile (Corporación Miles) y Uruguay (Mysu).

Los criterios de selección de estos países obedecen a tres cuestiones fundamentales: primero, asegurar una diversidad geográfica representativa; segundo, abordar diferentes modelos de regulación del aborto; y tercero, fortalecer la evidencia existente para impulsar estrategias de incidencia en aquellos lugares que ya cuentan con investigaciones -publicadas o no- sobre la criminalización del aborto. En consecuencia, el resultado principal de este estudio será un informe nacional que a su vez se integrará a un informe regional, consolidando las tendencias y patrones relativos a las violaciones a los derechos humanos y al costo humano derivado de leyes y políticas abusivas que penalizan el aborto.

La generación de evidencia empírica sobre la criminalización del aborto y otros eventos obstétricos a nivel regional tiene como propósito identificar patrones de vulneración a derechos humanos que

afectan a todas las personas criminalizadas y, de manera desproporcionada, a quienes están en situaciones de vulnerabilidad por razones socio-económicas, de etnia, raza, identidad de género, ruralidad, entre otras, al buscar acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, como el aborto. Con base a la evidencia, se espera contribuir al cambio de paradigma de la respuesta jurídica con relación al aborto para eliminar progresivamente o, al menos, disminuir significativamente el uso del derecho penal en este ámbito[5].

En esta línea, las preguntas guía que orientaron la investigación fueron:

¿Cuáles son las características de los procesos penales?

¿Cuáles son las características de las personas imputadas?

¿Cuál es el impacto que los procesos penales tuvieron sobre las personas imputadas?

¿Qué factores inciden en la persecución penal del aborto y otros eventos obstétricos y/o determinan resultados exitosos o especialmente gravosos para las personas imputadas?

5. Ver por ejemplo, Organización Mundial de la Salud (OMS), WHO-2019-nCoV-Advocacy_brief-Gender-2020.1spa.pdf

CAPÍTULO 2

Metodología

La metodología empleada para la recopilación y análisis de la información se caracteriza por su enfoque mixto. Considerando el contexto peruano y las preguntas guía, se formularon los siguientes objetivos específicos que orientaron la adaptación de los instrumentos de recojo de información:

Tabla 2.1. Objetivos de investigación e instrumentos empleados

Objetivos específicos de investigación	Instrumentos / Estrategia
Identificar las características de los procesos penales por abortos y otros eventos obstétricos	• Información estadística de acceso público solicitado al portal de transparencia de diversas entidades del Estado. • Revisión de expedientes obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información pública. • Entrevistas semiestructuradas a personas gestantes que atravesaron criminalización por un aborto, familiares criminalizados por participar del aborto, proveedores de salud, acompañantes, abogadas(es) y defensores de casos seleccionados. • Entrevistas semiestructuradas sobre el contexto a funcionarios/as del Poder Judicial, personal de salud y activistas. • Matriz de sistematización de sentencias y expedientes.
Caracterizar a las personas imputadas por delitos relacionados con el aborto y otros eventos obstétricos	• Información estadística de acceso público solicitado al portal de transparencia de diversas entidades del Estado. • Revisión de expedientes obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información pública. • Entrevistas semiestructuradas personas gestantes que atravesaron criminalización por un aborto, familiares criminalizados por participar del aborto, proveedores de salud, acompañantes, abogadas(es) y defensores de casos seleccionados. • Entrevistas semiestructuradas sobre el contexto a funcionarios/as del Poder Judicial, personal de salud y activistas. • Matriz de sistematización de sentencias y expedientes.
Comprender los efectos de los procesos penales en la vida de las personas imputadas por delitos relacionados con el aborto y otros eventos obstétricos	• Entrevistas semiestructuradas personas gestantes que atravesaron criminalización por un aborto, familiares criminalizados por participar del aborto, proveedores de salud, acompañantes, abogadas(es) y defensores de casos seleccionados. • Entrevistas semiestructuradas sobre el contexto a funcionarios/as del Poder Judicial, personal de salud y activistas. • Matriz de sistematización de sentencias y expedientes.
Identificar los factores que inciden en los resultados de los procesos de persecución penal del aborto y otros eventos obstétricos	• Entrevistas semiestructuradas personas gestantes que atravesaron criminalización por un aborto, familiares criminalizados por participar del aborto, proveedores de salud, acompañantes, abogadas(es) y defensores de casos seleccionados. • Entrevistas semiestructuradas sobre el contexto a funcionarios/as del Poder Judicial, personal de salud y activistas. • Matriz de sistematización de sentencias y expedientes.

Figura 2.1. Diseño metodológico

En primer lugar, se integra una fase de análisis cuantitativo. Como parte de ésta, se realizó una revisión y análisis de estadísticas a partir de solicitar información a 45 entidades públicas (ver Anexo 2) y de 100 sentencias[6] **y 15** expedientes proporcionados por 22 de los 34 Distritos Judiciales del Poder Judicial, como respuesta a 72 solicitudes de acceso a la información pública presentadas[7].

Por otro lado, el estudio también comprende una fase cualitativa, cuyo enfoque busca comprender y describir los fenómenos sociales desde adentro a partir del análisis de los procesos sociales que atraviesan los individuos. Esta fase cualitativa consistió en entrevistas semiestructuradas a 17 actores clave, y un estudio documental de 100 sentencias y 15 expedientes de casos sobre aborto.

Por otro lado, en esta investigación se tuvieron en cuenta aspectos éticos. El equipo mantuvo el compromiso de proteger el bienestar y los derechos de las poblaciones involucradas, reflexionando sobre su actuar y previniendo situaciones de daño consciente o inconsciente, como dinámicas propias de relaciones de poder (paternalismo, revictimización, entre otros). Asimismo, se incorporó un protocolo de contención emocional y un consentimiento informado que protegía el derecho a la privacidad, la voluntariedad, la confidencialidad, el derecho a retirarse de la entrevista y el derecho a abstenerse de contestar alguna pregunta. El consentimiento informado se adaptó a un formato oral y se enviaron los documentos a sus correos electrónicos en caso de entrevistas a través de videollamadas.

Aunque no hubo participantes que no leyeran el idioma español o tuvieran dificultades con la lectura y/o escritura, se les ofreció la opción de dar su consentimiento de forma oral. Es importante señalar que el equipo investigador ya contaba con experiencia en la realización de entrevistas en temas relativos a la violencia de género.

6. Para este estudio, el universo de sentencias analizadas comprende a todas las sentencias individuales que se pueden encontrar en una misma decisión. Y es que, en una sola decisión, puede haber más de una sentencia dependiendo del número de personas juzgadas.
7. Debido a la falta de respuesta a una primera solicitud de acceso a la información pública dirigida a la Corte Suprema, al Poder Judicial Central y a los 34 Distritos Judiciales, se ingresaron 36 solicitudes adicionales para reiterar el pedido.

A continuación, se explica en qué consistió cada elemento de la metodología de investigación.

2.1. Análisis de estadísticas de entidades públicas

Para la recolección de datos cuantitativos, se solicitó acceso a información pública sobre casos de aborto registrados entre 2012 y 2022 a diversas entidades del Estado, incluyendo la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público/Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Justicia, PRONACEJ[8] del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial del Perú, el Instituto Nacional Penitenciario, la Policía Nacional del Perú (PNP), DIRINCRI[9]-PNP, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud y ESSALUD[10]. Las solicitudes buscaban caracterizar a las personas imputadas por distintos tipos de delito de aborto, aunque sin hacer referencia explícita a la información privada de los investigados.

Inicialmente, se realizaron 45 solicitudes de acceso a información pública sobre delitos de aborto, homicidios, infanticidios y abandono de personas. La mayoría de las respuestas fueron incompletas o limitadas, y algunas entidades informaron no tener la información solicitada, recomendando derivar las solicitudes a otras instituciones. Para los delitos de homicidios y abandono de personas, se recibió información general que no cumplía con las condiciones necesarias para el análisis del estudio.

Para abordar las carencias en la información sobre delitos de aborto no forzado, se realizaron nuevas solicitudes y apelaciones ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estas apelaciones fueron dirigidas a entidades que no habían respondido dentro del plazo legal o cuyas respuestas fueron ambiguas o incompletas.

En general, el proceso de solicitud de información enfrentó varios obstáculos, incluyendo aplazamientos en los tiempos de respuesta, ausencia de respuestas, y poca información disponible en los portales de transparencia[11]. Finalmente, el procesamiento de la información recibida incluyó una limpieza inicial de las bases de datos para extraer la información relevante, organización de las tablas según región, tipo de delito, género y edad, y análisis descriptivos y gráficos para cada variable. Estos pasos fueron esenciales para evaluar la contribución de los datos al objetivo de la investigación.

2.2. Análisis de expedientes y sentencias

A fin de caracterizar y comprender el funcionamiento del sistema de justicia en casos de aborto, así como identificar a las MPG que son sujetas a proceso, resultaba fundamental analizar tanto las sentencias como los expedientes. Por ello, se realizó un estudio que combinó el análisis cuantitativo y cualitativo.

8. Programa Nacional de Centros Juveniles
9. Dirección de Investigación Criminal de la PNP
10. Seguro Social de Salud - EsSalud
11. Considerando este escenario, como aprendizaje, se sugiere solicitar información puntual y, si es posible, anexar tablas modelo para reducir el margen de interpretación del pedido y hacerlo menos complejo.

Tabla 2.2. Instrumentos para el análisis de expedientes y sentencias

Instrumento	Objetivos	Documentos
Matriz de sistematización de sentencias	• Conocer las características de los procesos penales por aborto y otros eventos obstétricos, el tipo de decisión final, el rol de la defensa pública, la actuación de la fiscalía y si se impuso una pena y/o reparación civil • Caracterizar a las personas criminalizadas, las motivaciones para abortar y las circunstancias alrededor de la interrupción del embarazo. • Evaluar -a grandes rasgos- el cumplimiento de las garantías procesales y los derechos de las personas criminalizadas durante el proceso penal.	100 decisiones finales sobre casos de aborto que hayan concluido entre el 2012 y 2022.
Matriz de sistematización de expedientes	• Verificar la presencia de estereotipos de género en los argumentos utilizados por operadores de justicia. • Evaluar el cumplimiento de las garantías procesales y los derechos de las personas criminalizadas durante el proceso penal.	15 expedientes concluidos de casos de aborto que hayan concluido entre el 2012 y 2022

Para la recolección y procesamiento de la data cuantitativa de las sentencias se construyó una matriz de sistematización que incorpora las decisiones finales de casos de aborto entre 2012 y 2022. Con ella, se analizaron los procesos penales por aborto, incluyendo sus características, decisiones, roles de la defensa pública, actuación fiscal, imposición de penas o reparaciones civiles. Asimismo, se caracterizaron a las MPG, sus motivaciones y circunstancias, así como se evaluó el cumplimiento de garantías procesales y derechos durante el proceso penal.

Para el análisis cualitativo también se utilizó una matriz de sistematización. En este caso, el insumo principal fueron los expedientes archivados entre 2012 y 2022. A comparación de las decisiones finales, los expedientes brindan mayor información sobre cada momento del proceso penal. Así, esta matriz tuvo como objetivo evaluar, a mayor profundidad, el cumplimiento de las garantías procesales y el respeto a diversos derechos fundamentales de las MPG durante el proceso penal. De igual manera, se analizaron los argumentos utilizados por los operadores de justicia a lo largo del proceso y verificar la presencia de estereotipos de género.

Sobre el proceso de recolección de sentencias y expedientes

De acuerdo con el inciso 3 del artículo 39 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sistemas de justicia -como el Poder Judicial- tienen la obligación de publicar en sus portales de transparencia[12].

A marzo de 2024, el Poder Judicial aún no ha cumplido con dicho mandato legal. En efecto, no existe un repositorio que garantice a la ciudadanía el acceso libre y gratuito a todas las sentencias judicia-

12. Todas las sentencias judiciales, dictámenes fiscales y jurisprudencia sistematizada de fácil acceso por materias, con una sumilla en lenguaje sencillo y amigable, conforme a los lineamientos y directrices establecidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, y en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público.

les de una manera sistematizada por materia. Precisamente, fue en el marco de esta investigación que advertimos el incumplimiento de dicho mandato al realizar la búsqueda de sentencias sobre abortos en tres repositorios institucionales sin obtener éxito alguno[13].

En vista de la ausencia de una plataforma virtual accesible y completa, el equipo se vio obligado a solicitar al Poder Judicial y al MINJUSDH la entrega de sentencias y expedientes vinculados a los delitos de aborto mediante solicitudes de acceso a la información pública.

Aunque se logró acceder a un total de 100 sentencias de 22 Distritos Judiciales vinculados, principalmente, a la persecución del delito de auto-aborto, el proceso de solicitud y acceso a los mismos no fue una tarea sencilla. De manera similar al proceso de recolección de estadísticas de entidades públicas, la solicitud de sentencias se realizó en dos momentos distintos: momento 1 (28/06/2023) y momento 2 (02/08/2023). Los expedientes fueron solicitados luego de acceder a las sentencias, cuyo proceso es descrito párrafos más abajo.

El 28 de julio de 2023 (momento 1) se enviaron tres solicitudes de acceso a la información por medios virtuales. Las dos primeras fueron enviadas al Poder Judicial, específicamente a la Corte Suprema y a los 34 Distritos Judiciales. Mientras que la tercera se dirigió al MINJUSDH, en virtud del servicio de defensa pública que brinda. En las tres solicitudes se requirió el acceso en formato digital a todas las sentencias (absolutorias, condenatorias, etc.) que hayan sido emitidas entre el 2012 y 2022 por los siguientes delitos:

1. Aborto (Art. 114 al Art. 120 del Código Penal).
2. Homicidio simple / homicidio calificado / homicidio culposo / infanticidio / parricidio cuando la víctima fuera un recién nacido y la imputada su progenitora (Art. 106, Art. 108, Art. 111, Art. 110 y Art. 107 del Código Penal, correspondientemente).

Exposición o abandono de persona seguido de muerte cuando la víctima fuera un recién nacido y la imputada su progenitora (art. 129 del Código Penal).

Solo en el caso del MINJUSDH se solicitó también las estadísticas de los casos defendidos por los delitos de aborto (Art. 114 al Art. 120 del Código Penal) desde el 2012 hasta el 2022. Se requirió, además, que dicha data estuviera desagregada por año, juzgado o sala, las características de la persona patrocinada (edad, capacidad, raza, etnia, condición de migrante, nivel educativo, ocupación, lugar de residencia, si tiene o no hijos/as) y demás datos estadísticos disponibles.

Frente al silencio de las entidades, se interpusieron apelaciones ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del MINJUSDH. Todas fueron declaradas fundadas por la misma[14], pero ninguna fue respondida.

El 2 de agosto de 2023 (momento 2) se realizó por segunda vez el pedido de acceso a la información. Esta vez, sin embargo, se ingresaron las solicitudes de forma presencial y se redujo la información

13. Este estudio comenzó haciendo una búsqueda en los siguientes tres repositorios:
Jurisprudencia de la Comisión de Justicia de Género: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/genero/s_jgen/as_jurisprudencia
Observatorio judicial: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ObservatorioPJ/s_ojpj/as_resoluciones/
Jurisprudencia Nacional Sistematizada: https://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/resultado.xhtml#no-back-button
14. A pesar del logro en las tres apelaciones enviadas y de la pertinente argumentación del tribunal, en la práctica las decisiones no mostraron un impacto real. De hecho, las entidades no apelaron las resoluciones ni terminaron por cumplir con lo dictaminado.

solicitada a sentencias (absolutorias, condenatorias, etc.) que hayan sido emitidas entre el 2012 y 2022 por el delito de auto-aborto (Art. 114 del Código Penal). Además, limitamos la solicitud a la Corte Suprema y los 34 Distritos Judiciales del Perú[15].

Fue sólo a partir de este segundo intento que recibimos respuestas por parte de algunas Cortes Superiores, aunque sólo pocas enviaron desde un inicio las sentencias en formato digital. En la mayoría de los casos se adjuntó un oficio con el listado de expedientes por el delito de auto-aborto, frente a lo cual se indicó que dicha información no respondía a nuestra solicitud. Algunas cortes no respondieron a nuestra reiteración, mientras que otras lo hicieron con retardo o enviaron la resolución -de 1 cara- que declara "consentida" la decisión final. De hecho, a pesar de que la solicitud fue notificada el 3 de agosto de 2023 a los 34 Distritos Judiciales, aun a marzo de 2024 continuamos recibiendo respuesta de algunas Cortes Superiores[16]. Es importante destacar que, debido a las restricciones de tiempo del estudio, la fecha de corte para el ingreso de las sentencias en la matriz fue el 6 de noviembre de 2023.

De esta manera, el universo de sentencias que logramos obtener alcanzan a 22 de los 34 Distritos Judiciales, los cuales abarcan las regiones de la costa, sierra y selva.

Tabla 2.3. Sentencias condenatorias en casos de MPG procesadas según distritos judiciales

DISTRITO JUDICIAL	CANTIDAD DE SENTENCIAS	CANTIDAD DE SENTENCIAS CONDENATORIAS
Amazonas	3	2
Apurímac	3	2
Arequipa	11	**10**
Ayacucho	10	**5**
Cajamarca	2	2
Callao	12	4
Cusco	3	3
Huancavelica	6	2
Huaura	3	3
Junín	1	1
Lambayeque	6	1
Lima Centro	5	3
Lima Este	1	-
Lima Sur	3	2
Loreto	14	**6**
Puente Piedra - Ventanilla	2	1
Puno	3	3
Selva Central	1	-
Sullana	2	2
Tacna	2	2
Tumbes	3	2
Ucayali	4	0
Total	**100**	**56**

Elaboración propia. Fuente: Poder Judicial

En cuanto al periodo abarcado, este comprendió los años 2012 a 2022, destacando dentro de ellos el 2013 y 2015.

15. La solicitud dirigida a los 34 Distritos Judiciales fue presentada ante la Gerencia General del Poder Judicial, la cual se encargó de remitir los documentos de manera oportuna a cada uno de las Cortes Superiores.
16. De acuerdo con el artículo 11.b del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las instituciones cuentan con 10 días hábiles para dar respuesta al requerimiento.

Figura 2.2. Sentencias en casos contra MPG según año de la decisión final

Elaboración propia. Fuente: Poder Judicial

También, vale la pena señalar que el promedio de páginas de las 100 sentencias analizadas es de 5,77 páginas, siendo la más extensa de 20 hojas y la más corta de 1. Este dato no solo muestra lo sucinta que puede ser una decisión sobre aborto, sino también del esfuerzo por recuperar toda la información que fue registrada, pero también omitida.

Sobre el proceso de recolección de expedientes

Luego de acceder a las sentencias, logramos iniciar el proceso de solicitud de los expedientes, obteniendo un total de 15. Similar al proceso de solicitud de sentencias, la búsqueda y acceso a los expedientes judiciales también resultó en un proceso retador al demostrar la discrecionalidad que existe en torno a los criterios para finalmente decidir si se hace entrega de las copias o la lectura de los expedientes solicitados[17]. En algunas respuestas, se mencionó que, al no tener participación en el proceso en cuestión, el expediente no podía ser proporcionado. En otros casos, se argumentó que la naturaleza del caso era considerada "íntima" o "privada", a pesar de que, desde una perspectiva penal, estos delitos no se clasifican como tales.

17. En todos los casos, los expedientes se encontraban archivados.

2.3. Entrevistas a actores clave: personas criminalizadas, funcionariado y activistas

En lo relativo a la aplicación de las guías de entrevista, es importante mencionar que el levantamiento de información fue realizado de acuerdo con la disponibilidad de las personas que tienen la intención de participar en el estudio. En ese sentido, se trató de un muestreo intencional a partir de determinados criterios.

Para la selección de casos de estudio, se ha priorizado la búsqueda de "lugares ricos en datos", donde se pudiera obtener información, a partir de contextos y personas, que se encuentran en contacto directo con el fenómeno estudiado (Flick, 2022). Por lo tanto, en este estudio se ha seleccionado a distintos actores inmersos en la problemática de la criminalización, tales como las mismas MPG que han atravesado un proceso de criminalización por interrumpir su embarazo; los familiares de la MPG; abogados/as defensoras, funcionarios/as del Poder Judicial, del MPFN y de la PNP; personas que acompañan en casos de interrupción del embarazo y activistas. El alcance geográfico del recojo comprende todo el territorio nacional, aunque las personas participantes fueron, en su gran mayoría, de Lima.

Las entrevistas fueron realizadas por videollamada. Previo a cada entrevista, se aplicaron los protocolos establecidos para obtener el consentimiento informado. Asimismo, se explicitaron los criterios éticos a considerar como parte de la investigación. Es importante mencionar que se cuenta con un protocolo de contención emocional para mantener el cuidado de las y los participantes durante las entrevistas.

Con el objetivo de garantizar un recojo de información de calidad y en cumplimiento de los protocolos, se realizó un proceso de capacitación al personal de campo, previo al inicio de la fase de entrevistas con respecto al tema, las particularidades de cada instrumento y la aplicación de los protocolos éticos. Además, se consideraron los posibles riesgos para los investigadores. Cada uno/a contó con un seguro de salud durante su trabajo de campo, contactos en casos de emergencia y espacios de contención emocional con una profesional de la salud mental, debido a las emociones que pudiese generar el tema. En el Anexo 3 se detallan los objetivos específicos que tuvieron las guías de entrevistas construidas para cada perfil específico.

Con respecto al procesamiento de la información, una vez realizadas, las entrevistas pasaron a ser transcritas de forma literal. Posterior a ello, se seleccionaron los datos relevantes y que aportan al objetivo de la investigación para que puedan ser volcados en una matriz de codificación. Previamente, se establecieron las categorías y subcategorías que contribuyeron en la creación de temas para el informe de resultados.Sin embargo, estas fueron complementadas con las categorías que emergieron durante el procesamiento. Por último, se tomaron los datos sistematizados para identificar hallazgos relevantes y las relaciones entre sí, para elaborar las conclusiones.

CAPÍTULO 3

Marco normativo que criminaliza el aborto en el Perú

Tanto en el contexto legal como social peruano, la regulación del aborto ha estado sujeta a constantes debates en los que se han discutido normativas que buscan garantizar e impedir su acceso. La adopción de enfoques penales y sanitarios ha contribuido además al desarrollo de un marco normativo complejo que refleja diversas posturas en torno a este tema. A partir de un análisis de las normas adoptadas históricamente sobre el aborto, esta sección analiza aquellas regulaciones que impactan directamente en su criminalización, revelando así los desafíos aún presentes en la protección de los derechos a la salud reproductiva de las MPG en el Perú

3.1. La regulación penal del aborto en Perú

A la fecha se conocen cuatro sistemas de regulación penal del aborto: (i) modelo de penalización total, (ii) modelo de causales, indicaciones o excepciones, (iii) modelo de plazos y (iv) modelo mixto. Como indica su nombre, el primero criminaliza el aborto sin ninguna excepción. El segundo reconoce algunos supuestos de despenalización, siendo los más comunes los casos de protección a la vida y salud de la persona gestante, embarazos producto de violaciones sexuales y malformaciones fetales incompatibles con la vida. Por su parte, el tercero descriminaliza el aborto a demanda dependiendo del tiempo de gestación, siendo el primer trimestre el principal periodo tutelado. Por último, el modelo mixto considera tanto el criterio de causales como el de plazos.

En el contexto peruano, el modelo actual de (des)penalización se rige por el de "causales", siendo el aborto terapéutico la única excepción contemplada en el Código Penal desde 1924. En ella se reconoce la legalidad del aborto cuando se tenga como fin "salvar la vida de la gestante o prevenir un mal grave y permanente en su salud".

Al 2024, la regulación penal del aborto se encuentra comprendida entre los artículos 114 y 120 del Capítulo II del Código Penal, correspondiente al Título I referido a los "Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud"[18]. En estos siete delitos se han establecido penas privativas a la libertad y prestaciones de servicio comunitario para (i) MPG, (ii) profesionales de la salud y (iii) terceras personas que causen un aborto. Sólo en el caso del personal sanitario se contempla también su inhabilitación profesional. A continuación, se presenta una tabla que resume la regulación penal del aborto en el Perú.

18. El Nuevo Código Procesal Penal regula el "Examen en caso de aborto" en su artículo 200 estableciendo que "En caso de aborto, se hará comprobar la preexistencia del embarazo, los signos demostrativos de la interrupción del mismo, las causas que lo determinaron, los probables autores y las circunstancias que sirvan para la determinación del carácter y gravedad del hecho.".

Tabla 3.1. La regulación del aborto en el Código Penal peruano

Artículo del Código Penal	Tipo penal	Persona criminalizada	Sanción (penal o servicio comunitario)
Autoaborto[19] (Art. 114)	La mujer que causa su aborto, o consiente que otro le practique	MPG	Pena privativa de libertad no mayor a dos años **(X ≤ 2 años)** O entre 52 a 104 jornadas de servicio comunitario
Aborto consentido[20] (Art. 115)	El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante	Profesional sanitario y terceras personas	Pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años **(1 año ≤ X ≤ 4 años)**
	Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado	Profesional sanitario y terceras personas	Pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años **(2 años ≤ X ≤ 5 años)**
Aborto sin consentimiento[21] (Art. 116)	El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento	Profesional sanitario y terceras personas	Pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años **(3 años ≤ X ≤ 5 años)**
	Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado	Profesional sanitario y terceras personas	Pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de diez años **(5 años ≤ X ≤ 10 años)**
Agravación de la pena por la calidad del sujeto[22] (Art. 117)	El médico, obstetra, farmacéutico, o cualquier profesional sanitario, que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto	Profesional sanitario	Pena de los artículos 115 y 116 e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 4 y 8.
Aborto preterintencional[23] (Art. 118)	El que, con violencia, ocasiona un aborto, sin haber tenido el propósito de causarlo, siendo notorio o constándole el embarazo	Terceras personas	Pena privativa de libertad no mayor de dos años o entre 52 a 104 jornadas de servicio comunitario **(X ≤ 2 años)**
Aborto terapéutico[24] (Art. 119)	No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente	-	-

19. Artículo 114.- La mujer que causa su aborto, o consiente que otro le practique, será reprimida con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio comunitario de cincuentidós a ciento cuatro jornadas.
20. Artículo 115.- El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
21. Artículo 116.- El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.Si sobreviene la muerte de la mujer y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de cinco ni mayor de diez años.
22. Artículo 117.- El médico, obstetra, farmacéutico, o cualquier profesional sanitario, que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto, será reprimido con la pena de los artículos 115 y 116 e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 4 y 8.
23. Artículo 118.- El que, con violencia, ocasiona un aborto, sin haber tenido el propósito de causarlo, siendo notorio o constándole el embarazo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años, o con prestación de servicio comunitario de cincuentidós a ciento cuatro jornadas.
24. Artículo 119.- No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su represen-

Aborto sentimental[25] (Inciso 1 Art. 120)	Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente	MPG	Pena privativa de libertad no mayor de 3 meses **(X ≤ 3 meses)**
Aborto eugenésico[26] (Inciso 2 Art. 120)	Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico	MPG	Pena privativa de libertad no mayor de 3 meses **(X ≤ 3 meses)**

Elaboración propia

3.2. El deber de confidencialidad, intimidad, secreto profesional y la obligación de denuncia en casos de aborto criminal

En el Perú, el estudio de la criminalización del aborto y otros eventos obstétricos abarca el análisis de la vulneración de la confidencialidad de la atención médica y del secreto profesional por parte del personal de salud. Profesionales que, a menudo, se convierten en los principales denunciantes de las MPG que solicitan atención postaborto o debido a emergencias obstétricas. A continuación, se presentará el marco normativo que regula la obligación de denunciar el "aborto criminal", así como las normas relativas al secreto profesional y al deber de confidencialidad.

3.2.1. La obligación de denuncia

El artículo 30 de la Ley No. 26942, Ley General de Salud, establece la obligación de denunciar a la persona que presente indicios de "aborto criminal":

> *El médico que brinda atención médica (...) cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente. [Resaltado agregado]*

Esta norma, aprobada en 1997, faculta al personal médico a informar a las autoridades sobre atenciones de emergencias obstétricas que, a su juicio, presenten "indicios de aborto criminal". Como se aprecia, la norma otorga amplia discrecionalidad al médico o médica para la notificación de los hechos. Esto es aún más llamativo debido a que la categoría "indicios de aborto criminal" no ha sido definida ni en la misma norma ni en una de rango infralegal, lo que, en términos prácticos, faculta a que cualquier sangrado pueda ser reportado como un presunto delito, incluso en casos en los que no haya embarazo, tal como veremos en las sentencias analizadas en esta investigación.

tante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.

25. Artículo 120.- El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres meses: 1.Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente;

26. Artículo 120.- El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres meses: 2. Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico.

Como se desarrollará más adelante, esta norma no sólo colisiona con otros derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú y en marco jurídico internacional de protección a los derechos humanos, sino que además entorpece el trabajo del personal de salud y limita el acceso a servicios de salud en situaciones de emergencias obstétricas.

3.2.2. El secreto profesional, el deber de confidencialidad y la protección de la intimidad

En el Perú, el secreto profesional se reconoce tanto como un derecho fundamental y un deber ético, respaldado por la Constitución y desarrollado tanto en la jurisprudencia como en la legislación. A pesar de su importancia, su regulación no está exenta de controversia a nivel legislativo y reglamentario, como vimos en el apartado anterior.

El artículo 2° inciso 18 de la Constitución Política del Perú establece el derecho de toda persona a "guardar el secreto profesional", imponiendo a profesionales como abogados, notarios, médicos y periodistas la obligación de mantener confidencial cualquier información recibida en el ejercicio de su profesión. En su reciente sentencia, el Tribunal Constitucional ha señalado que, "en cuanto a derecho, reconoce al titular de tales secretos el que sean celosamente guardados por los profesionales a quienes se les confía de modo directo, o que tuvieran acceso a información confidencial en razón de su ejercicio profesional. De modo similar, protege a esos profesionales, para que puedan oponerse a que los poderes públicos o cualquier persona o autoridad pretenda obligarlos a confesar esos secretos poniendo en riesgo su preservación en el ejercicio de su profesión" (Sentencia Nº 04382-2023-PA/TC; fundamento jurídico 15).

En ese sentido, se define el secreto profesional como una salvaguarda indispensable para el ejercicio de ciertas ocupaciones, protegiendo la información confidencial de ser revelada sin el consentimiento de la persona afectada. Según el Tribunal, el contenido del secreto profesional abarca toda clase de datos, informaciones, hechos, así como análisis o deducciones derivadas de la práctica profesional en diversas disciplinas que hayan sido conocidas u obtenidas a consecuencia del ejercicio de una determinada profesión (Sentencia Nº 0134-2003-HD/TC; fundamento jurídico 3; Sentencia Nº 04382-2023-PA/TC; fundamento jurídico 14).

El alcance de esta protección se extiende a toda la información obtenida en el ejercicio de la profesión, abarcando tanto la salvaguarda de los secretos a favor de las personas involucradas como la defensa de las personas profesionales ante cualquier intento de vulnerar esta confidencialidad (Tribunal Constitucional, 2005, Sentencia Nº 7811-2005-PA/TC, fundamento jurídico 7). Esta salvaguarda está estrechamente ligada al derecho fundamental a la intimidad personal, reconocido en el artículo 2 inciso 7 de la Constitución.

En el ámbito de la salud, el Tribunal ha reafirmado que "la información sobre la salud de una persona (...) está comprendida dentro del ámbito de la intimidad personal" (2003, Sentencia N° 1480-2003-HD/TC, fundamento jurídico 3).Además, el secreto profesional protege también a las propias personas profesionales, quienes pueden verse invocradas en cualquier situación donde se pretenda violar su deber de confidencialidad o poner en riesgo la protección de la información confidencial (Tribunal Constitucional, 2005, Sentencia Nº 7811-2005-PA/TC, fundamento jurídico. 7).

A nivel legal, El Código Penal, en su artículo 165[27], penaliza la violación al secreto profesional. En la misma línea, el Nuevo Código Procesal Penal del 2004 también introduce mecanismos de protección al secreto profesional. En su artículo 327[28], se establece una excepción a la obligación de denunciar en casos donde "el conocimiento de los hechos esté amparado por el secreto profesional". Sin embargo, la normativa también contempla disposiciones adicionales, como el artículo 165[29], numeral 2, que, si bien protege a quienes están vinculados por el secreto profesional de revelar información obtenida en el ejercicio de su profesión, permite excepcionalmente hacerlo en dos circunstancias: primero, cuando están obligados a hacerlo ante una autoridad judicial, y segundo, cuando cuentan con el consentimiento de la persona titular de la información.

Las disposiciones constitucionales y legales que protegen el secreto profesional y la confidencialidad de la atención coexisten con el artículo 30 de la Ley General de Salud mencionado anteriormente. Esta situación tiene implicaciones negativas para la protección de los derechos de las personas, como se analizará en los siguientes capítulos. A pesar de que la Corte Interamericana examinó la normativa nacional sobre la vulneración del secreto profesional en el ámbito médico y concluyó que la falta de protección de este derecho era inconvencional en el caso De La Cruz Flores vs. Perú, emitido en 2004, hasta la fecha este conflicto no ha sido abordado ni por el poder legislativo ni por el poder judicial.

Aunque el Tribunal Constitucional ha establecido que el secreto profesional impone al Estado un deber especial de garantizar su cumplimiento eficaz (Sentencia Nº 04382-2023-PA/TC, fundamento jurídico 15), hasta la fecha, este deber de protección no ha sido asumido por los poderes del Estado responsables de su cumplimiento.

3.3. La regulación del aborto en el DIDH: normativa aplicable al Perú

En el papel, el Perú figura como un Estado comprometido con los derechos humanos al haber ratificado ampliamente diversos tratados de derechos humanos. A nivel de Naciones Unidas, por ejemplo, el Perú ha ratificado los principales instrumentos jurídicos de los nueve órganos de super-

27. Artículo 165.- El que, teniendo información por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o ministerio, de secretos cuya publicación pueda causar daño, los revela sin consentimiento del interesado, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a ciento veinte días-multa.
28. Artículo 327 No obligados a denunciar.-

    1. Nadie está obligado a formular denuncia contra su cónyuge y parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

    2. Tampoco existe esta obligación cuando el conocimiento de los hechos está amparado por el secreto profesional.
29. Artículo 165 Abstención para rendir testimonio.-(...)

    2. Deberán abstenerse de declarar, con las precisiones que se detallarán, quienes según la Ley deban guardar secreto profesional o de Estado:

    a) Los vinculados por el secreto profesional no podrán ser obligados a declarar sobre lo conocido por razón del ejercicio de su profesión, salvo los casos en los cuales tengan la obligación de relatarlo a la autoridad judicial. Entre ellos se encuentran los abogados, ministros de cultos religiosos, notarios, médicos y personal sanitario, periodistas u otros profesionales dispensados por Ley expresa. Sin embargo, estas personas, con excepción de ministros de cultos religiosos, no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. (...)

visión de tratados[30]. De igual manera ha sucedido en el Sistema Interamericano[31]. A nivel material, sin embargo, la historia es radicalmente distinta. Al 2024, los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes no se encuentran ampliamente garantizados, lo que ha despertado la preocupación de distintos organismos internacionales e incluso de otros Estados.

Cabe considerar además que en el Perú los tratados de derechos humanos se encuentran regulados en la Constitución Política[32]. En su artículo 55 se reconoce que "Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional". Por su parte, la IV Disposición Final y Transitoria sostiene que los derechos y libertades de la constitución deben ser interpretados a la luz de los tratados de derechos humanos. El Tribunal Constitucional ha reconocido además el rango constitucional de los tratados de derechos humanos (2006, Sentencia N° 047-2004-AI/TC, fj. 61) así como el deber de ejercer un control de convencionalidad en sus decisiones (Sentencia N° 04617-2012-PA/TC, 2014, fj. 5).

3.3.1. Estándares internacionales sobre el aborto

En el derecho internacional, diversos mecanismos de protección han evaluado la criminalización del aborto y las leyes restrictivas al respecto a la luz de los principales tratados internacionales de derechos humanos. A partir de este análisis, tanto en el sistema universal como en el interamericano, existe un consenso sobre el impacto negativo de la criminalización y la falta de acceso al aborto en los derechos de las mujeres, especialmente en situaciones de riesgo para la vida y/o la salud de la mujer, inviabilidad fetal, y violación o incesto (excepciones o causales). Además, ambos sistemas le han recomendado a los Estados modificar las leyes y políticas que criminalicen o castiguen el aborto más allá de las excepciones o causales.

En las Naciones Unidas, tanto los órganos de tratados como los procedimientos especiales coinciden en que, como parte de sus obligaciones internacionales, los Estados deben revisar su legislación para garantizar el acceso a servicios de aborto legales y seguros en casos de riesgo para la vida y/o la salud de la mujer, inviabilidad fetal y violación o incesto[33]. Entre otras cuestiones, esto requiere (i)

30. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado en 1978); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado en 1978); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ratificada en 1978); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (ratificada en 1982); Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (ratificada en 1988); Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada en 1990); Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares (ratificada en 2005); Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada en 2008) y Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (adherida en 2012).
31. Convención Americana Sobre Derechos Humanos (ratificada en 1978); Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (ratificada en 1991); Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" (ratificado en 1995); "Convención de Belém do Pará". Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (ratificada en 1996); Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (ratificada en 2001); Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (ratificada en 2002) y Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (ratificada en 2021). De esta manera, al cierre del presente informe, el Estado peruano no ha ratificado ni la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia ni contra el Racismo ni la Convención Interamericana la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
32. Los detalles en torno al procedimiento de aprobación de los tratados se encuentran regulados en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política del Perú. Por otro lado, el Artículo VIII del Código Procesal Constitucional establece que frente a una incompatibilidad entre una normativa doméstica e internacional se deberá elegir la más garantista, mientras que su Artículo IX se pronuncia sobre la aplicación supletoria e integración de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
33. Véase, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos. Observación general núm. 36 (2019) sobre el derecho a la vida. CCPR/C/GC/36 (3 de septiembre de 2019), párr. 8.

derogar o reformar las leyes que penalizan el aborto, al menos en casos extremos[34], (ii) abstenerse de aplicar sanciones penales a quienes se someten a un aborto[35], (iii) establecer marcos jurídicos que eliminen las barreras de acceso a este servicio y garanticen la necesaria seguridad jurídica[36], y (iv) en general, procurar que las leyes al respecto no lleven a las mujeres a buscar abortos peligrosos o inseguros[37]. Los desarrollos de los comités de tratados se han dado en el marco de sus observaciones generales[38] y al examinar comunicaciones individuales[39]. Durante los últimos veinte años, han señalado que la criminalización y la falta de acceso al aborto pueden constituir una violación a las obligaciones de respetar, proteger y cumplir los derechos protegidos por los tratados respectivos. En general, los comités han fundamentado esta postura en los derechos a la vida, a la igualdad y no discriminación, a la privacidad, a la prohibición de tortura y a la salud.

Los mandatos de procedimientos especiales también han desincentivado el uso del derecho penal en lo que respecta al aborto, destacando los impactos de las leyes restrictivas del aborto, incluyendo la elevada mortalidad y morbilidad materna como consecuencia de los abortos en situaciones de riesgo[40].También han explicado que el uso del derecho penal no es una herramienta eficaz para regular la salud sexual y reproductiva, por lo que no puede considerarse una intervención de salud pública idónea[41]. En ese contexto, han exhortado a los Estados a derogar el delito de aborto y las leyes conexas[42].

En el caso del sistema interamericano de derechos humanos, a través de sus informes anuales[43], de

34. Véase, por ejemplo, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general núm. 22 (2016), relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva. E/C.12/GC/22 (2 de mayo de 2016), párr. 41.
35. Véase, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos. Observación general núm. 36 (2019) sobre el derecho a la vida. CCPR/C/GC/36 (3 de septiembre de 2019), párr. 8.
36. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. L.C. c. Perú, comunicación núm. 22/2009. CEDAW/C/50/D/22/2009 (17 de octubre de 2011), párrs. 8.16 y 8.17.
37. Comité de Derechos Humanos. Observación general núm. 36 (2019) sobre el derecho a la vida. CCPR/C/GC/36 (3 de septiembre de 2019), párr. 8.
38. Las observaciones en las que se han abordado cuestiones vinculadas al aborto, su criminalización y otros obstáculos para su acceso incluyen: Comité de Derechos Humanos. Observación general núm. 28 (2000) sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (29 de marzo de 2000); Comité de Derechos Humanos. Observación general núm. 36 (2019) sobre el derecho a la vida. CCPR/C/GC/36 (3 de septiembre de 2019); Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general núm. 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. E/C.12/2000/4 (11 de agosto de 2000); Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general núm. 22 (2016), relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva. E/C.12/GC/22 (2 de mayo de 2016); Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general núm. 24 (2017) sobre las obligaciones de los Estados en el contexto de las actividades empresariales. E/C.12/GC/24 (10 de agosto de 2017); Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer. Recomendación general núm. 24 (1999) sobre la mujer y la salud. A/54/38/Rev.1, cap. I (2 de febrero de 1999); Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer. Recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género contra la mujer. CEDAW/C/GC/35 (26 de julio de 2017); Comité de los Derechos del Niño. Observación general núm. 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. CRC/C/GC/15 (17 de abril de 2013); Comité de los Derechos del Niño. Observación general núm. 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia. CRC/C/GC/20 (6 de diciembre de 2016).
39. Las comunicaciones individuales en las que se han abordado obstáculos de acceso al aborto oportuno y seguro, generalmente derivados de leyes restrictivas, son: Comité de Derechos Humanos. Llantoy Huamán c. Perú, comunicación núm. 1153/2003. CCPR/C/85/D/1153/2003. (22 de noviembre de 2005); Comité de Derechos Humanos. L.M.R. c. Argentina, comunicación núm. 1608/2007. CCPR/C/101/D/1608/2007 (28 de abril de 2011); Comité de Derechos Humanos. Mellet c. Irlanda, comunicación núm. 2324/2013. CCPR/C/116/D/2324/2013 (17 de noviembre de 2016); Comité de Derechos Humanos. Whelan c. Irlanda, comunicación núm. 2425/2014. CCPR/C/119/D/2425/2014 (11 de julio de 2017); Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. L.C. c. Perú, comunicación núm. 22/2009. CEDAW/C/50/D/22/2009 (17 de octubre de 2011); Comité de los Derechos del Niño. Caso Camila c. Perú, comunicación núm. 136/2021. CRC/C/93/D/136/2021 (13 de junio de 2023).
40. Véase, por ejemplo, Asamblea General. Informe provisional del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. A/66/254 (3 de agosto de 2011), párrs. 21 y 27.
41. Véase, por ejemplo, Asamblea General. Informe provisional del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. A/66/254 (3 de agosto de 2011), párr. 20.
42. Véase, por ejemplo, Asamblea General. Informe provisional del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. A/66/254 (3 de agosto de 2011), párr. 20; Asamblea General. Informe de la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El racismo y el derecho a la salud. A/77/197 (22 de julio de 2022), párr. 92.
43. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2018, capítulo IV.B (Nicaragua), párr. 219; Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2018, capítulo V (República Dominicana), párrs. 91-94.

país[44] y temáticos[45], la CIDH ha analizado los impactos de la criminalización del aborto, destacando que puedeconstituir una vulneración a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes[46]. La Comisión ha explicado cómo la criminalización absoluta crea un contexto facilitador de abortos inseguros e impone una carga desproporcionada sobre los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a una vida libre de violencia y discriminación de las mujeres y niñas[47].

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) está pendiente de decidir su primer caso de aborto en la región. Se trata del caso Beatriz vs. El Salvador, relativo a la denegación de un aborto en un contexto tanto de inviabilidad como de riesgo a la salud y vida de la víctima.

3.3.2. Estándares sobre el aborto en el Sistema Universal de Derechos Humanos

En el último siglo, el Estado peruano ha recibido diversas observaciones finales de los órganos de supervisión de tratado de Naciones Unidas, así como de los procedimientos especiales en materia de derechos sexuales y reproductivos. En algunos de ellos, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité CEDAW y el Comité de los Derechos del Niño[48], incluso ha sido declarado responsable internacionalmente por la vulneración a los derechos humanos de una adolescente y dos niñas.

Asimismo, al 2024, cinco comités ya han manifestado sus preocupaciones sobre el impacto de la casi absoluta prohibición del aborto y las barreras que enfrentan niñas, adolescente, mujeres y personas gestantes para acceder a un aborto terapéutico (Comité CEDAW, 2007, párr. 24; Comité DESC, 2012, párr. 21; Comité contra la Tortura, 2013, párr. 15; Comité de los Derechos del Niño, 2016, párr. 55.b; Comité contra la Tortura, 2018, párr. 40). De igual manera, se han pronunciado sobre los obstáculos legales y fácticos para acceder al AOE (Comité de Derechos Humanos, 2013, párr. 14.c; Comité CEDAW, 2014, párr. 36.e).

Comité de Derechos Humanos

En noviembre de 2005 el Comité de Derechos Humanos concluyó que el Perú era responsable por las violaciones cometidas en perjuicio de *K.L.*, una adolescente de 17 años quien fue obligada a llevar a término un embarazo que ponía en peligro su vida y salud mental. En su decisión, el comité concluyó que *K.L.* no contó con un recurso adecuado para acceder a un aborto terapéutico. Para el comité, además, esta situación la llevó a experimentar un sufrimiento psicológico equivalente a hechos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes (2005 párrs. 6.3 y 8).

44. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de derechos humanos en El Salvador (14 de octubre de 2021), párrs. 198-205; Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de derechos humanos en Honduras (24 de marzo de 2024), párrs. 380-387.
45. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América Latina y el Caribe (14 de noviembre de 2019), párrs. 200-210.
46. Véase, por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América Latina y el Caribe (14 de noviembre de 2019), párr. 210; Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2018, capítulo IV.B (Nicaragua), párr. 219; Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de derechos humanos en El Salvador (14 de octubre de 2021), párr. 205.
47. Véase, por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América Latina y el Caribe (14 de noviembre de 2019), párr. 202.
48. Al respecto se hace referencia a los casos de K.L., L.C. y Camila, resueltos por cada comité, respectivamente. Tanto los hechos como la decisión de cada caso son desarrolladas brevemente en las siguientes páginas.

En 2013 el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por "la falta de un protocolo nacional que regule la práctica del aborto terapéutico" (2013, párr. 14). En virtud de ello, instó al Estado peruano a adoptar un protocolo o guía que regule el acceso a dicho servicio sanitario. De igual manera, manifestó su preocupación "por el hecho de que siga considerándose delito el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de una violación" (2013, párr. 14) en el Perú. En tal sentido, recomendó al Estado revisar "su legislación sobre el aborto y **prevea excepciones adicionales en los casos en que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto**" (2013, párr. 14.a).

En esa misma observación, el comité también "lament[ó] la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de prohibir la distribución gratuita de anticonceptivos orales de emergencia" (Comité de Derechos Humanos, 2013, párr. 14). Por ello, exhortó al Estado peruano a garantizar "la prestación, en todas las regiones del país, de servicios adecuados de salud sexual y reproductiva que incluyan los anticonceptivos orales de emergencia" con el objetivo de "reducir los embarazos de adolescentes y la mortalidad materna, en particular en las zonas rurales" (Comité de Derechos Humanos, 2013, párr. 14.c).

Comité CEDAW

En 2007, el Comité CEDAW se pronunció sobre las barreras que existen en el Perú para acceder a un aborto terapéutico. Al respecto, señaló que:

> *[…]* **la interpretación restringida que hace el Estado Parte del aborto terapéutico, que es legal, puede inducir a las mujeres a hacer que se practiquen abortos ilegales en condiciones de riesgo.** *Al Comité le preocupa además que el Estado Parte no aplicó las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos formuladas en relación con el caso K.L. contra Perú. (2007, párr. 24)*[49]

Como consecuencia, el comité instó al Estado peruano a (i) garantizar a niñas, adolescentes y mujeres el acceso a servicios de calidad para la atención de las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones de riesgo a fin de reducir la tasa de mortalidad materna y (ii) examinar su interpretación restringida sobre el aborto terapéutico. Asimismo, instó al Perú a cumplir con las disposiciones establecidas en el caso K.L., las cuales para ese momento aún no habían sido atendidas.

En noviembre de 2011, el Comité CEDAW concluyó que el Estado peruano había vulnerado los derechos humanos de *L.C.* tras haberle impedido acceder a un aborto terapéutico, a pesar de que su vida y salud se encontraban en grave riesgo. Y es que, tras conocer que se encontraba embarazada producto de las múltiples violaciones sexuales que había sufrido, *L.C.* intentó quitarse la vida arrojándose desde un edificio. El comité afirmó que la niña "no tuvo acceso a un procedimiento eficaz y accesible que le permitiese establecer su derecho a los servicios de atención médica que su estado de salud física y mental requería". A ello añadió que dicho vacío jurídico favorecía la ocurrencia de actos arbitrarios por parte de los hospitales (2009, párrs. 8.15, 8.16 y 8.17). En virtud de ello, recomendó al Estado peruano "Revisar su legislación para despenalizar el aborto cuando el embarazo tenga como causa una violación o un abuso sexual" (2009, párr. 9.2.a).

49. Resaltado agregado.

En 2014, el Comité CEDAW reiteró que el Perú debía extender la legalización del aborto a los casos de violación, incesto o malformación fetal severa (2014, párr. 36.a). Ello debido a que los abortos en condiciones de riesgo son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna (2014, párr. 36). Asimismo, exhortó a las autoridades peruanas a asegurar "que el ejercicio de la objeción de conciencia por los profesionales de la salud no impida el acceso efectivo de las mujeres a los servicios de salud reproductiva, incluido el aborto y la atención posterior" (2014, párr. 36.d). Es más, el comité se pronunció -aunque sutilmente- sobre la obligación impuesta al personal de salud de denunciar "abortos criminales". Al respecto, exhortó al Estado peruano que:

> *Elimine las medidas punitivas contra las mujeres que abortan, entre otras cosas adoptando las medidas necesarias para armonizar la Ley General de Salud y el Código de Procedimiento Penal con el derecho constitucional a la intimidad. (2014, párr. 36.c)*

En esa misma observación, el Comité CEDAW reiteró las preocupaciones expresadas por el Comité de Derechos Humanos ante la decisión del Tribunal Constitucional peruano sobre el AOE. Por ello, recomendó al Perú que "adopte todas las medidas necesarias para distribuir gratuitamente anticonceptivos de emergencia en el sistema de salud pública, en particular a las mujeres y niñas víctimas de abusos sexuales" (2014, párr. 36.e).

En su última observación del 2022, el comité manifestó su preocupación respecto de las disposiciones que criminalizan a niñas, adolescentes y mujeres por acceder a abortos no terapéuticos. De acuerdo con el Comité CEDAW, dicha situación las obliga a recurrir a abortos riesgosos para su vida y salud. Por ello, instó al Estado peruano a legalizar:

> *[...] el aborto en casos de violación, incesto, amenaza para la vida o la salud de la embarazada o malformación grave del feto, lo despenalice en todos los demás casos y ofrezca a las mujeres servicios seguros de aborto y cuidados integrales posteriores al aborto, sobre todo cuando se presenten complicaciones a raíz de abortos practicados en condiciones de riesgo. (2022, párr. 38.a)*

Asimismo, exhortó al Estado peruano a elaborar y aprobar una norma técnica sanitaria exclusiva para la atención integral diferenciada de las niñas embarazadas como consecuencia de una violación sexual, el cual además debe cumplir con los estándares sobre derechos humanos de la infancia y adolescencia (Comite CEDAW, 2022, párr. 38.b).

Comité contra la Tortura

En 2013, el Comité contra la Tortura expresó estar "particularmente inquieto por la penalización del aborto en caso de violación o de incesto" (2013, párr. 15). Por ello, instó al Estado peruano a revisar su legislación a fin de "[m]odificar la prohibición general del aborto de forma que se autoricen [...] el aborto en los casos en que el embarazo sea resultado de violación o de incesto" (2013, párr. 15.a).

Cinco años más tarde, en 2018, reiteró su preocupación por la ausencia de garantías para acceder a un aborto terapéutico cuando el embarazo resulta de una violación. Frente a ello, sostuvo que:

> **El Estado parte debería revisar su legislación a fin de hacer extensiva la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo a los casos de violación,** *incesto y malformación fetal severa. Debería también revisar su legislación a fin de no criminalizar la atención médica que prestan los profesionales de la salud a las mujeres que la requieren como consecuencia de afecciones derivadas de abortos clandestinos. (Comité contra la Tortura, 2018, párr. 41)*[50]

Comité de los Derechos del Niños

En 2016, el Comité de los Derechos del Niño manifestó su preocupación sobre el "hecho de que el aborto sea ilegal en casos de violación o incesto y [sobre] la interpretación restrictiva del aborto terapéutico, situación que obliga a las niñas a recurrir a abortos peligrosos con riesgo para su salud y para su vida" (2016, párr. 55.b). Por ello, instó a las autoridades a que "[d]espenalice el aborto en todas las circunstancias, garantice el acceso de las niñas a servicios de aborto sin peligro y de atención posterior al aborto por lo menos en los casos de violación, incesto y graves malformaciones del feto y en los casos de riesgo para la vida y la salud de la madre" (2016, párr. 56.b).

Sumado a lo anterior, reiteró que las autoridades peruanas tienen la obligación de garantizar que las opiniones de las niñas embarazadas sean escuchadas y respetadas en todas las decisiones que adopten sobre el aborto, además de proporcionar orientaciones claras a los profesionales sanitarios e información a los adolescentes sobre el aborto sin peligro y la atención después del aborto.

Las preocupaciones del comité también se extendieron a la falta de acceso a anticonceptivos por lo que instó a garantizar "formas modernas de anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos gratuitos de emergencia" (Comité de los Derechos del Niño, 2016, párr. 56.c).

En 2023, el Comité de los Derechos del Niño se convirtió en el tercer órgano de supervisión de tratado en declarar responsable al Estado peruano por haber impedido el acceso a un aborto terapéutico a una niña de 13 años que salió embarazada producto de las múltiples violaciones sexuales que sufrió a manos de su padre. Camila fue además perseguida por el sistema de justicia tras haber experimentado un aborto espontáneo. El comité concluyó que la falta de acceso al aborto terapéutico constituyó una forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante (2023, párr. 8.12). Asimismo, recomendó al Perú despenalizar el aborto en casos de embarazo infantil, garantizar el acceso a servicios de aborto seguro y modificar la normativa para asegurar consideraciones específicas para niñas y adolescentes, entre otras medidas (2023, párr. 9).

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Comité DESC")

Considerando la alta tasa de embarazos y la falta de servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, en 2012 el Comité DESC manifestó encontrarse preocupado porque "los abortos en casos de embarazos resultantes de violaciones estén penalizados (art. 12)" (2012, párr. 21). En virtud

50. Resaltado agregado.

de lo anterior, recomendó al Estado peruano modificar el Código Penal para así despenalizar "los abortos en los casos de embarazos resultantes de violaciones" (2012, párr. 21). De igual manera, instó a redoblar los esfuerzos para garantizar la accesibilidad y disponibilidad de los anticonceptivos de emergencia (2012, párr. 21).

Examen Periódico Universal

El Perú también ha recibido comentarios de otros Estados en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos, cuyas expresiones de preocupación abarcaron la penalización del aborto y el acceso a anticonceptivos de emergencia.

En 2012, durante el 2do ciclo del EPU, el Estado peruano recibió los comentarios de dos Estados. Por un lado, Eslovenia instó al Estado peruano a "despenalizar el aborto en los casos de violación, según lo recomendado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer" (Consejo de Derechos Humanos, 2012, 119.8). Mientras que Noruega exhortó a "[e]stablecer protocolos nacionales sobre el aborto de acuerdo con la conclusión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2005, como medida para mejorar la protección de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer" (2012, 119.9).

En 2017, , durante el 3er ciclo del EPU, cinco Estados se pronunciaron sobre la despenalización de otras causales de aborto. Eslovenia instó al Estado peruano a despenalizar el aborto "en casos de violación, incesto y malformación grave del feto" (Consejo de Derechos Humanos, 2017, párr. 111.95). De igual manera, Canadá exhortó a "despenalizar el aborto en los casos de violación, incesto, peligro para la viabilidad del feto y para la salud de la madre" (2017, párr. 111.98). Con mayor amplitud, Islandia recomendó al Estado peruano:

> *Despenalizar el aborto en todas las circunstancias y garantizar que las mujeres y las niñas puedan acceder a un aborto sin riesgo y legal, y garantizar el acceso a los servicios médicos para las víctimas de la violencia sexual. (2017, párr. 111.102)*

En esa línea, Suiza instó al Perú a adoptar las medidas necesarias, incluidas las legales, "para garantizar que las mujeres y las niñas no puedan en ningún caso ser enjuiciadas penalmente por solicitar o someterse a un aborto" (2017, párr. 111.96). Por último, Finlandia exhortó a "[g]arantizar el acceso a los servicios médicos, incluidos un aborto sin riesgo y legal, a las víctimas de la violencia sexual" (2017, párr. 111.99).

En relación con la accesibilidad del AOE, Canadá instó al Perú a "[a]doptar políticas públicas para aumentar el acceso a la planificación familiar y los anticonceptivos de emergencia" (2017, párr. 111.98).

Por último, en el marco del 4to ciclo del EPU, en 2023 el Estado peruano ha continuado recibiendo los comentarios de otros Estados sobre la penalización casi absoluta del aborto y las barreras para su acceso. En esta oportunidad fueron siete los Estados que expresaron su preocupación. Por un lado, Finlandia, Noruega, Grecia, Islandia y Alemania recomendaron despenalizar el aborto (2023, párrs. 111.89, 111.97, 111.123, 111.124 y 111.152). Por su parte, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estonia recomendó garantizar el acceso a un aborto seguro y legal (2023, párr. 111.116).

3.3.3. Conclusión general

Para este punto, resulta bastante claro que en el Perú la criminalización del aborto es casi absoluta, siendo el aborto terapéutico la única causal despenalizada desde hace un siglo. A lo largo de los años, han existido múltiples intentos legislativos, tanto para ampliar como para restringir las excepciones bajo las cuales se permite el aborto. Sin embargo, ninguno de los proyectos para liberalizar las causales ha sido aprobado, lo que refleja una tendencia a mantener la penalización del aborto en la mayoría de los casos. Esta postura se ve reforzada por la imposición de penas significativas, no solo a las MPG que buscan abortar, sino también a los profesionales de la salud y a terceras personas que participen en la práctica del aborto.

La obligación de los profesionales médicos de denunciar los casos de "aborto criminal" agrava la situación, ya que esta norma limita las posibilidades de acceso a una atención postaborto en los establecimientos de salud (en adelante, EE.SS), debido a que las MPG pueden ser denunciadas por quienes atienden sus necesidades de salud. Además, esta norma no define claramente qué constituye un "aborto criminal", lo que puede llevar a denuncias arbitrarias y a una mayor vulneración de los derechos de las personas gestantes.

En el ámbito internacional, el Perú ha recibido reiteradas observaciones por parte de diversos organismos de derechos humanos, que han señalado que la restricción severa del acceso al aborto afecta negativamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Organismos como el Comité de Derechos Humanos y el Comité CEDAW han instado al Perú a revisar su legislación para ampliar las causales de aborto, asegurar el acceso a servicios de salud reproductiva adecuados y garantizar protección del secreto profesional en las atenciones de emergencias obstétricas a través de la modificación legislativa. Estas recomendaciones reflejan una preocupación por la salud y el bienestar de las personas gestantes, quienes a menudo se ven obligadas a recurrir a abortos inseguros, así como a evitar acudir a los EE.SS. por temor a ser denunciadas.

A pesar de los compromisos del Perú con tratados internacionales de derechos humanos y la protección constitucional vigente, la legislación interna sigue siendo restrictiva, lo que evidencia una desconexión entre las obligaciones internacionales y constitucionales y la práctica legislativa y judicial nacional.

CAPÍTULO 4

La criminalización del aborto en cifras

Este apartado ofrece un análisis detallado sobre la situación de los abortos no forzados en el Perú, abordando aspectos como la distribución regional de casos, las denuncias ingresadas a la Policía Nacional, la defensa legal de personas acusadas por este delito, la carga fiscal por grupos de fiscalías, el estado de los casos en el sistema judicial y características sociodemográficas de las personas involucradas. Se destaca la concentración de casos en regiones de la sierra y costa, el aumento y descenso de denuncias a lo largo de los años, la prevalencia de modalidades como el autoaborto y el aborto consentido, así como la barrera de acceso al aborto terapéutico. Además, se analiza la distribución de casos por tipo penal, la proporción de procesos judiciales ejecutados/archivados y la relación entre nivel educativo y tipo de delito.

La Tabla 4.1 ofrece una visión amplia de la situación legal y judicial en torno a los delitos de aborto en el período analizado, mostrando la actividad reportada por las autoridades policiales, fiscales y judiciales, así como las consecuencias legales y penales resultantes de estos casos.

Tabla 4.1. Resumen de cifras sobre persecución del aborto, 2012-2022

	Año	Cantidad de denuncias recibidas (PNP)	Carga fiscal ingresada*** (MPFN)	Cantidad de procesos penales iniciados (Poder Judicial)	Cantidad de personas encarceladas (INPE)	Cantidad de adolescentes sancionadas** (PRONACEJ)
Casos por delitos de aborto no forzado	2012	EE*	1089	69	9	EE*
	2013		990	43	8	
	2014		878	66	3	
	2015		1044	96	2	
	2016	184	1081	70	2	
	2017	244	1249	90	0	
	2018	290	1460	70	1	2
	2019	347	1530	82	3	7
	2020	252	1118	37	2	2
	2021	237	1186	78	0	5
	2022	270	1234	50	0	6
Total		1824	12,859	751	30	22

*Nota 1. En espera de la información: nuevas solicitudes y/o apelaciones realizadas a las entidades para obtener la información respectiva (en caso las tengan).

** Nota 2. Información no solicitada según la metodología de la IRCA, pero incluida por ser de especial interés para el estudio.

Fuente: SIDPOL PNP, Sistema Integral Judicial Centralizado del Poder Judicial, Unidad de Gestión de Medida Socioeducativa del PRONACEJ.

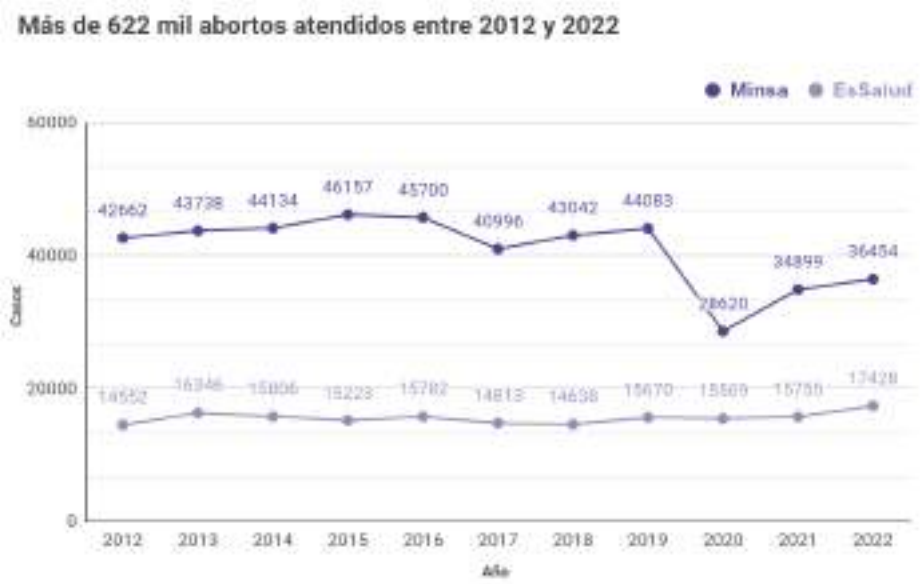
*** Es la carga que comprende a todos los documentos que han ingresado en Fiscalías, donde en el caso de la denuncia, cada una de ellas generará una carpeta fiscal (Física y en el Sistema de Gestión Fiscal -SGF) a la cual se le asigna un número de caso. La cual será examinada y estudiada para su solución.

Contexto: abortos atendidos en establecimientos de salud del Estado

En el Perú, desde el 2012 hasta el 2022, se han registrado un total de 622,007 casos de abortos practicados y atendidos en EE. SS. del MINSA[51] y en las Redes de Salud de EsSalud[52]ambos forman parte del sistema público de salud. Es decir, **más de medio millón** de casos en un rango de 11 años.

En la Figura 4.1 se presenta dicha información detallada por años y por sistema de salud. Se observa que **los mayores registros provienen del MINSA**, indicando una mayor accesibilidad de este sistema de salud en comparación con EsSalud, cuyos registros son considerablemente menores debido a requisitos de afiliación laboral.

Figura 4.1. Abortos atendidos en establecimientos del MINSA y EsSalud, 2012

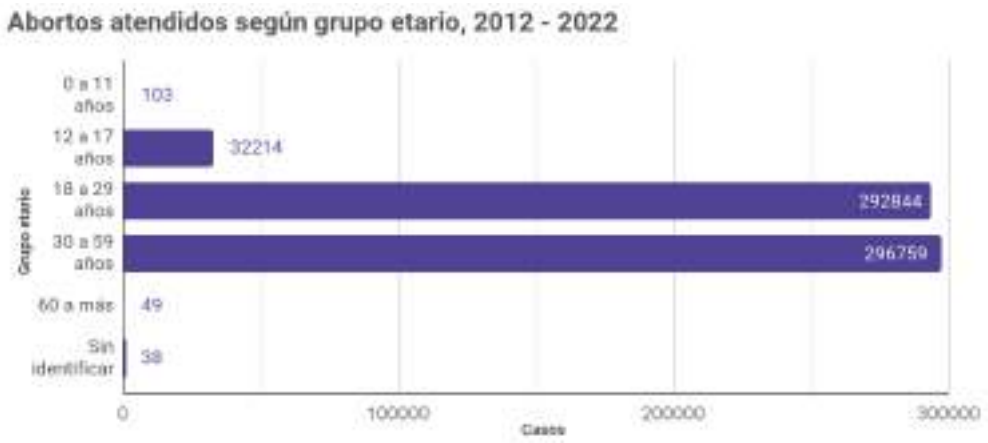


Elaboración propia. Fuente: Oficina de Gestión de la Información (Minsa), Sistema de Gestión Hospitalaria y Sistema de Gestión de Servicios de Salud (EsSalud).

51. El rector en materia de Salud del Perú, conduce el Sistema Nacional de Salud basado en Redes Integradas de Salud, la política para el aseguramiento universal en salud, y las políticas y acciones intersectoriales sobre los determinantes sociales; en beneficio de la salud y el bienestar de la población.
52. Es un organismo público adscrito al Ministerio de Trabajo, que brinda cobertura a los asegurados y sus derechohabientes mediante prestaciones de salud, económicas y sociales, en el régimen contributivo de la Seguridad Social y otros seguros de riesgos humanos.

En la Figura 4.2. se observan las atenciones por aborto considerando el grupo etario de las personas. Destaca que la mayoría de pacientes o mujeres atendidas por aborto son adultas y adultas jóvenes en edad reproductiva. Llama la atención que **más de 32 mil son niñas y adolescentes atendidas por aborto en EE. SS. públicos**.

Figura 4.2. Abortos atendidos según grupo etario, 2012 - 2022



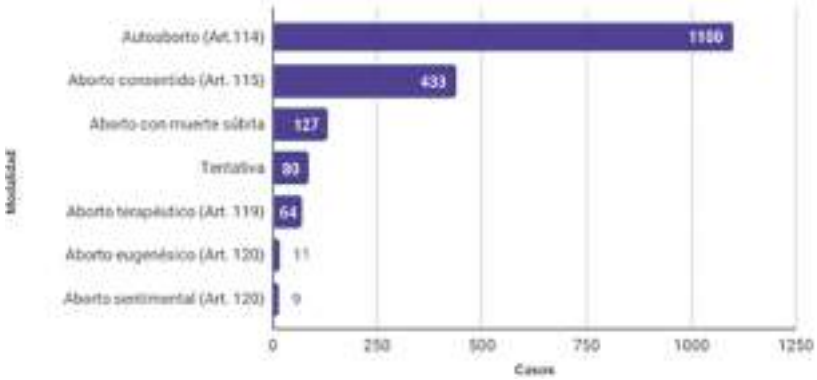
Elaboración propia. Fuente: Oficina de Gestión de la Información (Minsa), Sistema de Gestión Hospitalaria y Sistema de Gestión de Servicios de Salud (EsSalud).

4.1. Denuncias ingresadas en la Policía Nacional del Perú

De acuerdo con la información proporcionada por la PNP, **entre el 2016 y 2022**[53] **se reportaron un total de** 1824 **denuncias por aborto en el territorio nacional**, con un aumento hasta 2019 y un posterior descenso seguido de un repunte en los últimos dos años.

En la Figura 4.3 se muestra la distribución de denuncias por modalidades del delito, destacando el *Autoaborto* y el *Aborto consentido* como los más frecuentes, seguido por casos de *Aborto con muerte súbita* y *Tentativa*. Resulta llamativo que **se consignaron 64 casos de Aborto terapéutico, pese a ser legal.** Este último aspecto resulta alarmante, ya que representa una barrera para el acceso al aborto terapéutico, el cual cuenta incluso con una guía para su aplicación por el sistema de salud.

Figura 4.3. Denuncias por delito de aborto no forzado según modalidad, 2016 - 2022



Elaboración propia. Fuente: SIDPOL PNP.

53. No se consignan datos del 2012 al 2015 debido a que la entidad no disponía de dicha información.

En cuanto a la distribución regional de las denuncias, se observa que la mayoría se concentra en las regiones costeras y de la sierra del país, siendo **Lima la región con más denuncias, seguida por Cusco y Arequipa**, mientras que regiones como Madre de Dios, Ucayali y Amazonas presentan menos denuncias (ver Figura 4.4). Además, Lima, Callao y Cusco son las regiones con más denuncias por Aborto terapéutico, mientras que Arequipa y Piura son las que presentan más registros por el Artículo 120, que incluye aborto sentimental y eugenésico.

Figura 4.4. Denuncias por delito de aborto no forzado según región, 2016 - 2022

4.2. Delitos de aborto en fiscalías

El Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPFN) de Perú registró un total de 12.859 casos relacionados con delitos de aborto entre los años 2012 y 2022. La carga fiscal por año muestra tres momentos distintos: un período de menor cantidad entre 2012 y 2016, un aumento hasta alcanzar un máximo de 1530 registros en 2019 entre 2016 y 2019, y un descenso a partir de 2019 con una tendencia al alza desde 2021 (1186 y 1234 casos en 2021 y 2022, respectivamente).

Figura 4.5. Carga fiscal registrada por delito de aborto no forzado, 2012 - 2022

Elaboración propia. Fuente: Sistema de Gestión Fiscal (SGF), Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF) y la Bandeja Fiscal.

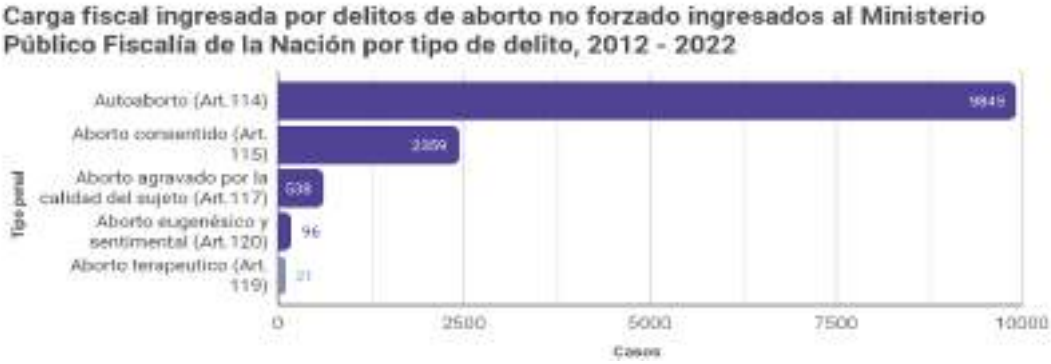
La distribución de casos por región[54] presenta similitudes con los datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), concentrándose principalmente en distritos fiscales de la costa y sierra del país. De las 5 regiones que abarcan más del 50% del total, 4 son de la sierra (Lima, Cusco, Arequipa, Ayacucho y Junín). Las regiones con menor incidencia son Pasco (48 registros), Madre de Dios (61), Tacna (121), Moquegua (126), Tumbes (132) y Puno (137).

54. La mayoría de distritos fiscales se corresponden a una sola región, en el caso de las regiones que abarcan dos o más distritos fiscales, los valores fueron sumados para alcanzar un total por la región a la cual pertenecen.

Figura 4.6. Carga fiscal registrada por delito de aborto no forzado según región, 2012 - 2022

El autoaborto es el tipo de delito con mayor cantidad de registros en el MPFN, con 9845 casos entre 2012 y 2022, lo cual representa un promedio anual de 820 denuncias. Le sigue el aborto consentido con 2359 registros. Es importante destacar la presencia de 21 casos de aborto terapéutico, a pesar de no ser un tipo penalizado en el país, lo que evidencia una criminalización indebida.

Figura 4.7. Carga fiscal ingresada por delito de aborto no forzado según tipo penal, 2012 - 2022



Elaboración propia. Fuente: Sistema de Gestión Fiscal (SGF), Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF) y la Bandeja Fiscal.

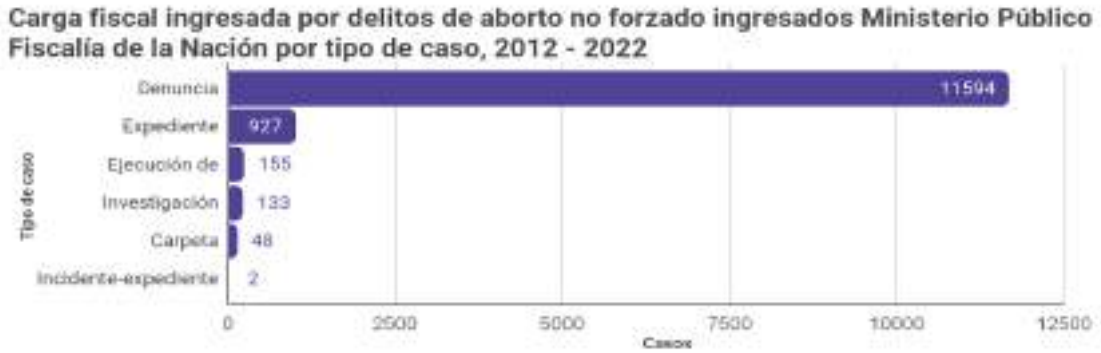
Las Fiscalías Penales concentran la mayor carga fiscal por delitos de aborto no forzado, con 9077 casos. En segundo lugar, se encuentran las Fiscalías Civil y de Familia, con 1921 casos enfocados en niñas, niños y adolescentes, y las Fiscalías Mixtas con 1861 casos.

Figura 4.8. Carga fiscal ingresada por delito de aborto no forzado según grupo fiscalía, 2012 - 2022

Elaboración propia. Fuente: Sistema de Gestión Fiscal (SGF), Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF) y la Bandeja Fiscal.

Más del 90% de la carga fiscal (11594 casos) se encuentra en estado de denuncia. Un 7% (927) cuenta con expediente, mientras que 155 casos han llegado a la ejecución de una sentencia y 133 se encuentran en proceso de investigación.

Figura 4.9. Carga fiscal ingresada por delito de aborto no forzado según tipo de caso, 2012 - 2022

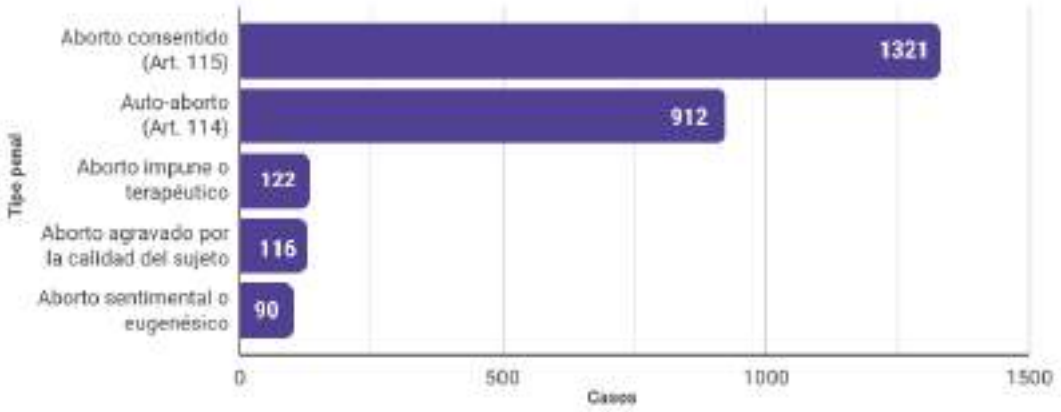


Elaboración propia. Fuente: Sistema de Gestión Fiscal (SGF), Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF) y la Bandeja Fiscal.

4.3. Defensa pública: patrocinios a personas acusadas

Entre el 2012 y 2022, se registraron **2561 patrocinios** en Defensa Legal por el delito de aborto, según el MINJUSDH. En la Figura 4.10, se muestra que los casos patrocinados son, en su mayoría, por el delito de *aborto* consentido (Art. 115) con 1321 registros, seguido por el delito de autoaborto (Art. 118) con 912 casos, aborto terapéutico (Art. 119) con 122 casos, aborto agravado por la calidad del sujeto (Art. 117) con 116 casos y aborto sentimental y eugenésico (Art. 120) con 90 casos. Es un hecho resaltante que existan 122 patrocinios en Defensa Penal por aborto terapéutico (Art. 119), lo que implica que estos casos fueron llevados hasta el ámbito judicial, pese a que no está estipulado como un delito en el Código Penal Peruano por ser una situación en donde la vida y la salud de la gestante están en riesgo a causa del embarazo.

Figura 4.10. Patrocinios por delito de aborto no forzado según tipo penal, 2012 - 2022

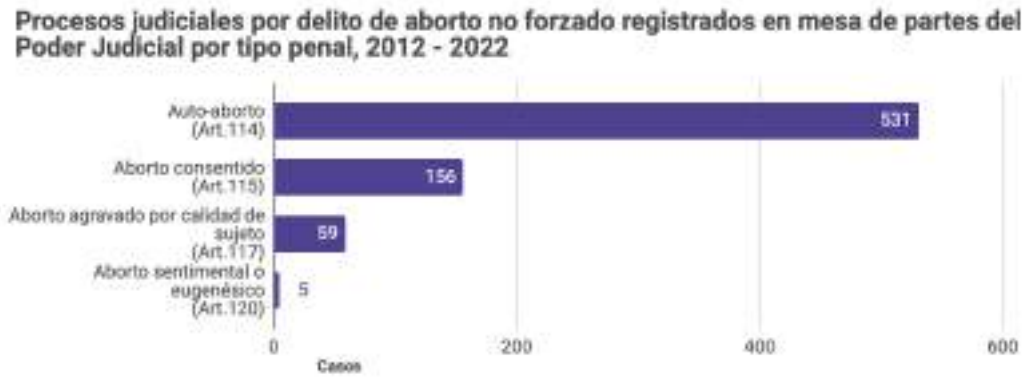


Elaboración propia. Fuente: Sistema de Seguimiento de Casos - DGDPAJ, Ministerio de Justicia.

4.4. Procesos judiciales por aborto

El Poder Judicial de Perú registró un total de 751 procesos judiciales por delitos de aborto no forzados entre 2012 y 2022, con un promedio anual de 68.3 casos. Los tipos penales con mayor cantidad de procesos fueron el autoaborto (531 casos, representando el 70% del total), seguido del aborto consentido (156 casos), el aborto agravado por la calidad del sujeto (59 casos) y el aborto sentimental o eugenésico (5 casos).

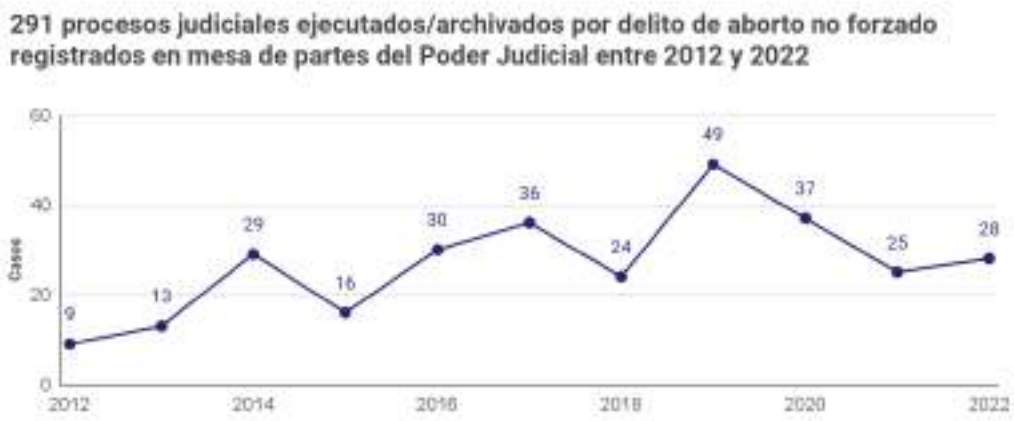
Figura 4.12. Cantidad de procesos judiciales por tipo penal de delito



Elaboración propia. Fuente: Sistema Integrado Judicial Centralizado del Poder Judicial.

De los 751 procesos judiciales, 291 (poco más de un tercio) fueron ejecutados o archivados entre 2012 y 2022. Se observa una tendencia creciente de ejecuciones y archivamientos durante el período, incluso durante el año 2020 (pandemia). Ello quiere decir que poco más de un tercio de los casos (de los 751 procesos judiciales) ha dado un posterior paso a la emisión de la decisión judicial. Los dos años con mayor cantidad de ejecuciones y archivamientos son 2019 y 2020.

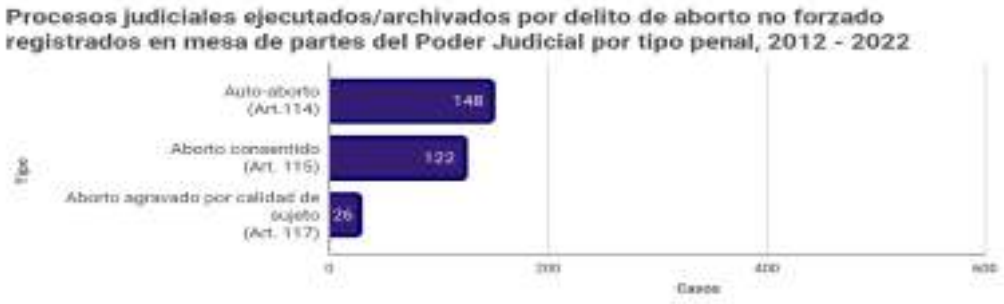
Figura 4.13. Cantidad de procesos judiciales ejecutados/archivados entre 2012 y 2022



Elaboración propia. Fuente: Sistema Integrado Judicial Centralizado del Poder Judicial.

Los tipos penales con mayor cantidad de ejecuciones/archivamientos fueron el autoaborto (148 casos) y el aborto consentido (122 casos), seguidos del aborto agravado por la calidad del sujeto (26 casos). Al analizar la proporción de procesos ejecutados/archivados en relación con los procesos iniciados, se observa que el aborto consentido es el tipo penal con mayor porcentaje de ejecución/archivo (78% de los procesos iniciados), seguido del aborto agravado por la calidad del sujeto (44%) y el autoaborto (27%).

Figura 4.14. Cantidad de procesos judiciales ejecutados/archivados por tipo de delito



Elaboración propia. Fuente: Sistema Integrado Judicial Centralizado del Poder Judicial.

4.5. Población penal por delito de aborto

En el país, para los 11 años estudiados, han sido privadas de su libertad un total de 30 personas por delitos de aborto no forzados. Casi en su totalidad, las personas han sido recluidas por el delito de Aborto no consentido (29 casos) y solo una por Aborto agravado o Aborto por la calidad del sujeto. Los casos, asimismo, han marcado una fuerte tendencia al descenso para ese periodo de tiempo.

Figura 4.15. Población penal por año y por tipo de delito de aborto no forzado, 2012 – 2022

Elaboración propia. Fuente: Unidad Estadística del INPE

De este total, el grupo de edades es variado. El mayor número está en el grupo de edad de 40 a 49 años, con 12 casos en total, seguido por el grupo de 30 a 39 años, con 5 casos; es decir, en su mayoría, población adulta de mediana edad. También se registran 4 casos de población penal que es adulta mayor.

Tabla 4.2. Población penal por edad

Grupo de edad	Casos
18 - 24 años	1
25 - 29 años	4
30 - 39 años	5
40 - 49 años	12
50 - 59 años	4
60 a más	4
Total	30

Elaboración propia. Fuente: Unidad Estadística del INPE

Asimismo, se conoce que, de los registros de población penal total, la mayoría son hombres (29 hombres y 1 mujer). A pesar de que las etapas de investigación y juicio en casos de aborto no forzado suelen estar dirigidas principalmente hacia mujeres, las cifras de población imputada revelan que, en última instancia, son principalmente hombres quienes resultan privados de su libertad[55].

Asimismo, el mayor número de personas recluidas en establecimientos penitenciarios proceden de regiones variadas, 23 reclusos/as proceden de regiones de la Costa, 5 de la Sierra y 2 de la Selva. De este número, gran parte son de Lima (12 casos) y de Ica (8 casos). Para mayor detalle observar las Tablas 4.2 y 4.3.

Tabla 4.3. Población penal por regiones

Región	Total
Arequipa	2
Huánuco	3
Ica	8
Lima	14
Loreto	2
Piura	1
Total	30

Elaboración propia. Fuente: Unidad Estadística del INPE

La Tabla 4.4, por su parte, informa sobre el tiempo que han pasado las personas recluidas en los diferentes establecimientos penitenciarios por delitos de aborto no forzados. En general, un tercio de los reclusos/as ha pasado entre 0 a 5 meses en reclusión y los demás no han sobrepasado, en ninguno de los casos, los 2 años recluidos, para mayor detalle ver la tabla a continuación.

55. Aunque este tipo penal no es objeto de análisis específico en este estudio, planteamos la hipótesis de que el aborto forzado puede ser una de las consecuencias de la violencia ejercida contra las mujeres. Dicha violencia, al alcanzar tal gravedad, justificaría la imposición de una pena de privación de libertad

Tabla 4.4. Población penal por meses en reclusión

Región	Meses en reclusión					
	0 - 5	6 - 11	12 - 23	24 – 35	36 - 59	60 - 119
Arequipa	1	0	1	0	0	0
Huánuco	1	1	1	0	0	0
Ica	3	0	1	0	2	2
Lima	4	1	3	2	1	3
Loreto	0	0	0	1	1	0
Piura	1	0	0	0	0	0
Total 10		2	6	3	4	5

Elaboración propia. Fuente: Unidad Estadística del INPE

4.6. Población adolescente en Centros Juveniles

Aunque las adolescentes, en estricto, no son privadas de su libertad por delitos de aborto, sí vienen enfrentando sanciones vinculadas a la restricción de su libertad en el sistema judicial peruano. Estas sanciones son registradas por el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).

Entre el 2018 y el 2022[56], un total de 22 adolescentes fueron sancionados por delitos de aborto no forzado, específicamente por la infracción de autoaborto (21 casos) y aborto[57] (1 caso). De estos casos, 20 adolescentes cumplieron sus sanciones en Servicios de Orientación al Adolescente (SOA) y 2 en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR), lo que significa que tuvieron medidas privativas de libertad.

Es importante señalar que 21 de las personas sancionadas fueron mujeres y 1 fue hombre. Además, 6 de estas adolescentes ya tenían un hijo o hija al momento de la sanción.

En cuanto a la distribución geográfica de las sanciones, los SOA Cusco y SOA Loreto fueron los que registraron mayor cantidad de casos con 5 cada uno. Le siguieron el SOA Huaura con 3 casos, SOA Lima Este con 3 casos, CJDR (sin especificar nombre) con 2 casos, SOA Huancayo con 2 casos, SOA Cañete con 1 caso y SOA Paucarpata con 1 caso también.

En cuanto al nivel educativo de los adolescentes sancionados, la mayoría cursaba estudios secundarios (11 casos) o superiores incompletos (7 casos).

Las adolescentes sancionadas por aborto en Perú cumplen principalmente con libertad asistida. Sin embargo, se identificaron 2 casos de internamiento en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) para adolescentes entre 15 y 17 años, y 5 casos de libertad restringida. El tiempo de sanción varía entre 3 y 30 meses, siendo de 3 a 12 meses en los SOA y de 24 a 30 meses (2 a 2.5 años) en los CJDR.

56. No se consignan datos del 2012 al 2017 debido a que la entidad no disponía de dicha información.
57. No se indicó el tipo penal de aborto.

Tabla 4.5. Población adolescente en Centros Juveniles por edad y tipo de sanción

Edad	Tipo de sanción				
	Internamiento	Libertad asistida	Libertad restringida	Prestación de servicios a la comunidad	Casos
15 a 17 años	2	3	-	3	8
18 a 20 años	-	5	2	1	8
21 a 22 años	-	1	1	-	2
No consigna	-	1	2	1	4
Total	2	10	5	5	22

Elaboración propia. Fuente: PRONACEJ.

4.7. Tasa de criminalización del aborto en el Perú

A través de la utilización de datos sobre la cantidad de mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) del Censo del 2017 del Instituto Nacional de Estadísticas e Información (INEI) y la carga fiscal ingresada por delitos de aborto no forzado (MPFN) en el periodo 2012 al 2022, hemos construido la Tasa de Criminalización del Aborto.

La tasa se define como la frecuencia de denuncias por aborto en fiscalías por cada 10.000 mujeres en edad reproductiva (15-49 años) en el período completo.

Datos:

1. Población en edad reproductiva: Se utilizaron datos del Censo del INEI del año 2017 para obtener la cantidad total de mujeres en edad reproductiva por región.
2. Denuncias por aborto: Se recopilaron las denuncias por aborto en fiscalías (MPFN) durante el período 2012 al 2022, desglosadas por región.

Cálculo de la tasa:

1. Total de denuncias: Se calculó la suma total de denuncias por aborto en cada región durante el período de 11 años.
2. Tasa por región: Se dividió la suma total de denuncias por aborto en cada región por la cantidad total de mujeres en edad reproductiva en la misma región.
3. Normalización: Se multiplicó la tasa por 10.000 para obtener la frecuencia de denuncias por aborto por cada 10.000 mujeres en edad reproductiva.

Así, la fórmula del índice de criminalización es la siguiente:

$$\frac{\text{Delitos de aborto no forzados en fiscalías 2012-2022}}{\text{Cantidad de mujeres en edad reproductiva según Censo}} \times 10000 = \text{Tasa de criminalización por cada 10 mil mujeres}$$

La tasa de criminalización del aborto por región permite identificar las regiones con mayor frecuencia de denuncias por aborto en relación con la cantidad total de mujeres en edad reproductiva durante el período 2012-2022. Esta información es útil para:

- Análisis de tendencias: Evaluar la evolución de la criminalización del aborto en las regiones a lo largo del período de 11 años.
- Identificación de brechas: Detectar disparidades en la criminalización del aborto entre diferentes regiones.
- Diseño de políticas públicas: Orientar la implementación de políticas públicas para reducir la criminalización del aborto y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva seguros y legales.

La tasa de criminalización por región

La tasa de criminalización del aborto a nivel nacional es de 16,4 investigaciones penales por cada 10.000 mujeres en edad reproductiva. Se observan variaciones considerables entre los Departamentos, con rangos que van desde 4,4 investigaciones por cada 10.000 mujeres en Puno hasta 57,6 en Ayacucho.

Las altas tasas de criminalización en algunos departamentos, como Ayacucho y Apurímac, confirman la existencia de una persecución penal sistemática contra las mujeres que buscan interrumpir su embarazo. Por su parte, las tasas más bajas se encuentran en los departamentos como Puno y Pasco.

Tabla 4.6. Tasa de criminalización por región

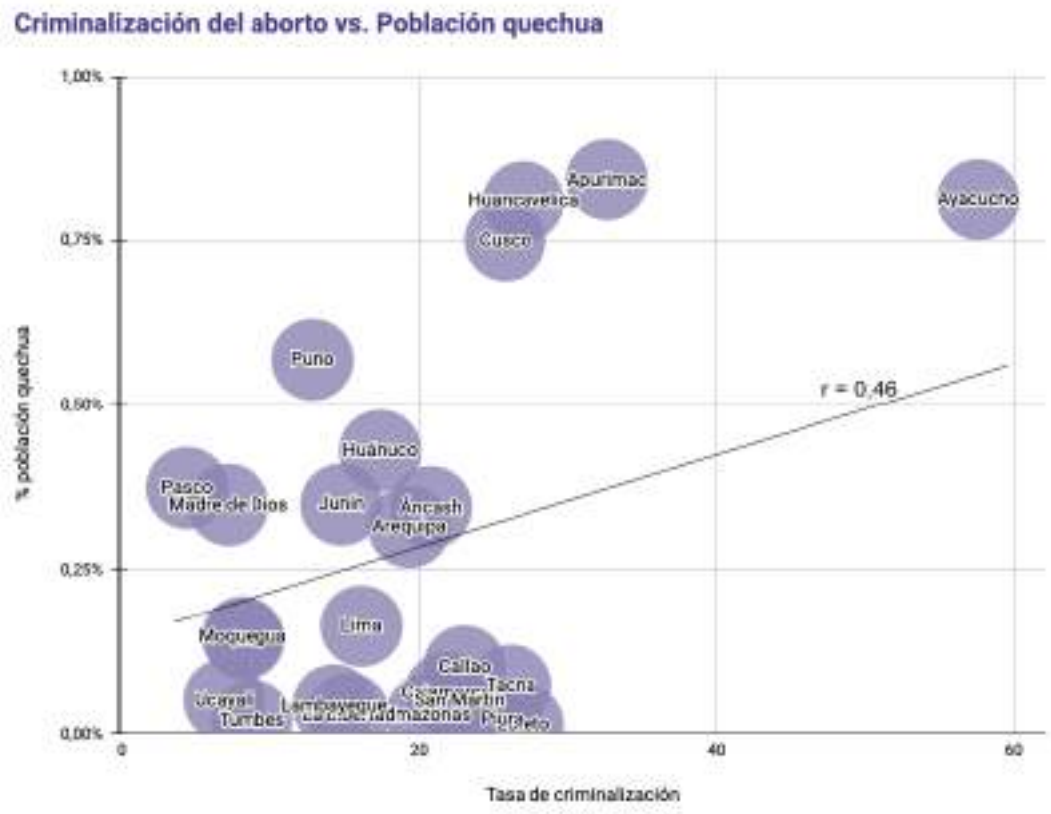
Departamento	Mujeres censadas de 15 años hasta 49 años	Carga fiscal ingresada por delito de aborto	Investigaciones penales por aborto por cada 10 mil mujeres en edad reproductiva
Ayacucho	157 470	907	**57,6**
Apurímac	100 749	329	**32,7**
Moquegua	46 639	126	**27,0**
Ica	224 696	607	**27,0**
Ucayali	124 652	326	**26,2**
Huánuco	185 340	478	**25,8**
San Martín	204 825	524	**25,6**
Huancavelica	85 502	197	**23,0**
Tumbes	58 143	132	**22,7**
Cusco	320 453	699	**21,8**
Áncash	274 222	570	**20,8**
Amazonas	93 152	191	**20,5**
Arequipa	383 245	741	**19,3**
Junín	332 823	579	**17,4**
Madre de Dios	37 804	61	**16,1**
Lima	2 660 667	4064	**15,3**
Lambayeque	315 449	467	**14,8**
Loreto	210 791	301	**14,3**
Tacna	94 173	121	**12,8**
Cajamarca	343 193	300	**8,7**
La Libertad	466 873	384	**8,2**
Piura	471 756	383	**8,1**
Pasco	67 083	48	**7,2**
Callao	271 627	187	**6,9**
Puno	314 460	137	**4,4**
Total Nacional	7 845 787	12859	**16,4**

Elaboración propia. Fuente: Censos de Población y Vivienda 2017, INEI; Sistema de Gestión Fiscal (SGF), Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF) y la Bandeja Fiscal.

Las disparidades regionales en la criminalización del aborto en Perú, con regiones como Ayacucho y Apurímac presentando tasas significativamente más altas, impulsaron la investigación de nuestro equipo sobre las causas subyacentes. Al analizar las variables sociodemográficas, se descubrió una conexión notable que incide en la Tasa de Criminalización del Aborto: la autoidentificación como persona quechua.

A partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, se calculó el porcentaje de población quechua en cada región. El análisis de correlación mediante el coeficiente de Pearson (0.460) y el valor p (0.021) reveló una correlación positiva moderada y estadísticamente significativa entre la tasa de criminalización del aborto no forzado y el porcentaje de población quechua. Esta correlación, estadísticamente significativa, plantea interrogantes sobre las causas subyacentes a esta relación y sus implicaciones para la salud sexual y reproductiva de las mujeres quechua.

Figura 4.16. Correlación entre tasa de criminalización del aborto y % de población quechua



Elaboración propia. Fuente: Censos de Población y Vivienda 2017, INEI; Sistema de Gestión Fiscal (SGF), Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIATF) y la Bandeja Fiscal.

Si bien la correlación observada es significativa, se requieren investigaciones más profundas para comprender las causas subyacentes y los mecanismos específicos que la generan. Es fundamental considerar las experiencias y perspectivas de las mujeres quechua para obtener una comprensión más completa de la situación.

CAPÍTULO 5

¿Cuáles son las características de las personas imputadas?

"Son quechuahablantes, su grado de instrucción es de secundaria completa o incluso menos que eso"

"Si es que estamos en flagrancia, dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho, el Ministerio de Justicia se encarga de la defensa pública, salvo que tengan abogado particular que es difícil porque la mayoría (de mujeres que abortan) son de condición humilde"

"La paciente generalmente la encontramos en observación o de repente hasta en trauma shock, necesitan UCI (...) A veces no llegan a tiempo al hospital, llegan ya cadáver (sic) por la infección. Esto es lo que sucede generalmente. Llega la paciente cuando ya está en las últimas consecuencias"

(Alberto, funcionario de DIRINCRI)

Del estudio, se puede observar que las mujeres criminalizadas por aborto en Perú se encuentran, en términos generales, en situaciones de vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad, según los datos recopilados, abarca diversas dimensiones que se intersectan, como la económica, etaria, racial y el limitado acceso a información y capital cultural. Un factor determinante es la criminalización racializada: las zonas con los mayores índices de judicialización de abortos están habitadas en su mayoría por mujeres quechuas y de bajos recursos económicos, quienes frecuentemente acuden a hospitales públicos, donde la persecución de estos casos es más intensa.

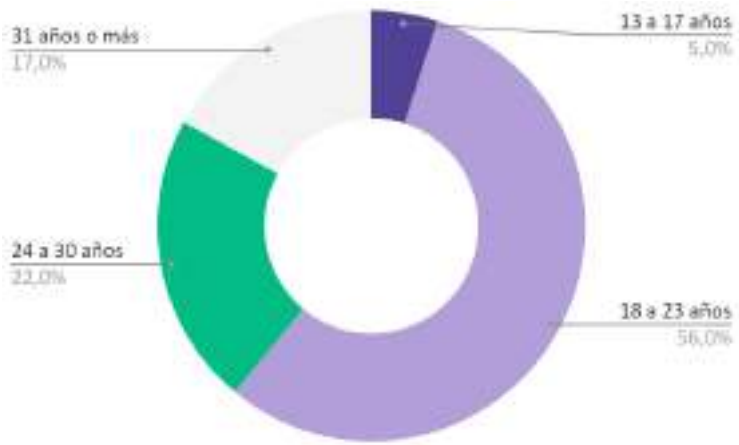
Otro aspecto crítico es que la persecución penal se inicia en un momento de alta vulnerabilidad para ellas, cuando buscan atención médica por complicaciones derivadas de un aborto o en situaciones de emergencia obstétrica. En estas circunstancias de angustia, estrés y temor por su salud y bienestar, se ven presionadas a autoincriminarse, como lo ilustra el testimonio de Catherine.

Además, su acceso limitado a una defensa legal efectiva se debe, nuevamente, a su situación de vulnerabilidad económica y cultural. Esto las lleva a depender de defensores públicos, quienes a menudo las guían hacia la autoincriminación y a la finalización anticipada del proceso, como se ha observado en los expedientes analizados y se detallará más adelante. Más allá de la soledad física, estas mujeres enfrentan una profunda soledad psicológica. El estigma social asociado al aborto y la amenaza de criminalización les impiden compartir su situación y buscar redes de apoyo.

5.1 Edad de las imputadas

La mayoría de las mujeres criminalizadas por aborto en Perú son jóvenes de entre **18 y 30 años**. En 59 de las 100 sentencias analizadas se determinó la edad de las mujeres perseguidas penalmente (MPG) al momento del aborto. El **56%** de ellas tenía entre **18 y 23 años**, y un 22% entre **24 y 30 años,** indicando que la mayoría eran mujeres jóvenes. En menor medida, 10 casos involucraban a mujeres de **31 años o más**, y 3 casos a niñas y adolescentes de **13 a 17 años**, mostrando que el sistema judicial también persigue penalmente a menores de edad. Estos datos subrayan que las MPG en su mayoría pertenecen al grupo etario de jóvenes de **18 a 30 años**, que enfrentan desafíos adicionales debido a menores ingresos y limitaciones en acceso a defensa y servicios de calidad.

Figura 5.1. Sentencias según edad de la MPG al momento de los hechos



Nota: El total es de 59 casos, pues en los restantes no se indica este dato en la sentencia.
Fuente: Elaboración propia en base a sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

A partir de las entrevistas y el análisis de expedientes, se han documentado casos en los que adolescentes, fueron investigadas y sentenciadas por la infracción de autoaborto. En estos casos su edad fue aprovechada por las y los operadores del sistema de justicia para agravar los impactos de la criminalización. En uno de estos expedientes analizados, Kari[58], una adolescente del área rural del Cusco, fue sentenciada y encontrada infractora de autoaborto. En su testimonio, declaró que "no sabía que el aborto era un delito". Aunque este elemento pudo haber sido considerado para concluir el proceso o para atenuar la pena, ello no ocurrió.

5.2. Condición económica de las personas imputadas

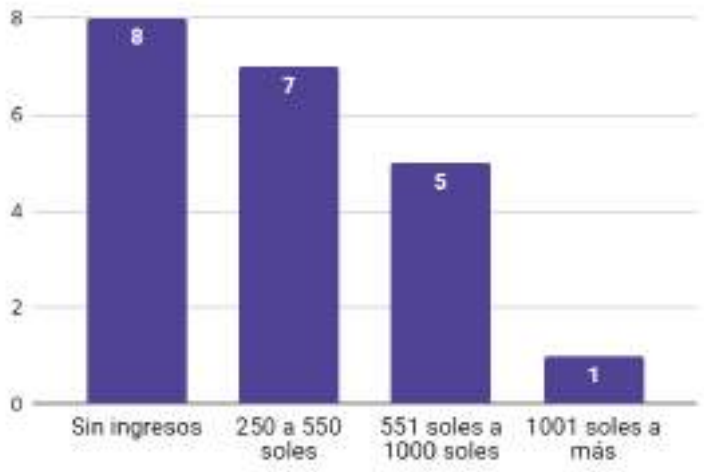
"Estos casos le pasan sobre todo a personas de bajos recursos, que no pueden costear un abogado, ni siquiera 100 soles, 50 soles, es mucho para estas personas."
(Martha, abogada defensora)

Por lo general, las mujeres criminalizadas por aborto en Perú viven en pobreza, con ingresos muy por debajo del promedio nacional y enfrentan procesos judiciales costosos que afectan su salud mental y capacidad laboral.

En 21 de las 100 sentencias analizadas se conoció el ingreso económico de las mujeres perseguidas penalmente (MPG). La mayoría (12 casos) percibía ingresos menores a 1000 soles (267 dólares[59]), destacando un rango salarial entre 250 y 550 soles (67 y 147 dólares), inferior al promedio rural de 665.6 soles[60] (177 dólares). Ocho MPG no tenían ingresos, y solo una ganaba 1200 soles (320 dólares). Considerando que la línea de pobreza extrema era de 226 soles (60 dólares) y la no extrema de 415 soles[61] , (111 dólares) al menos 15 de las 21 personas vivían en pobreza. Además, el ingreso mínimo vital promedio fue de 950 soles[62] (253 dólares) y solo una persona superaba este monto. Esto indica que las MPG enfrentan procesos judiciales prolongados y onerosos, afectando también su salud mental y capacidad laboral.

58. Expediente analizado Nº 12, MPG-2017-LIM.
59. El tipo de cambio que se usó como referencia fue 1 dolar = 3. 75 soles. Tomado de SUNAT, tipo de cambio oficial, véase: https://e-consulta.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias
60. Ibid. Pág.146.
61. INEI (2023). Perú: Evaluación de la Pobreza Monetaria 2011 - 2022. Informe Técnico. págs. 47 y 51. Enlace: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/pobreza2022/Pobreza2022.pdf
62. BCR. Remuneración Mínima Vital. Enlace: https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN02124PM/html

Figura 5.2. Sentencias según ingreso mensual aproximado de la MPG procesada



Nota: El total es de 21 casos pues en los restantes no se indica este dato en la sentencia.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

De las **43 mujeres** cuya ocupación se identificó en las sentencias, la mayoría se encontraba en situación de vulnerabilidad económica. Un **28 %** eran **amas de casa** y otro **28 %** trabajaba en la **informalidad**, sin acceso a estabilidad laboral ni derechos laborales. Además, un **23 %** eran **estudiantes sin ingresos**, lo que refleja su dependencia económica. Otro **12 %** se desempeñaba como **trabajadoras del hogar**, un sector caracterizado por condiciones precarias. Solo un **7 %** tenía **empleo formal**, mientras que el **2 %** restante trabajaba como **agricultora**. Estos datos evidencian que la gran mayoría de las mujeres criminalizadas por aborto carecían de seguridad económica, lo que las hacía aún más vulnerables ante procesos judiciales prolongados y costosos.

Tabla 5.1. Sentencias según ocupación de la MPG procesada

Ocupación	Frecuencia	%
Ama de casa	12	28%
Trabajadora con empleo informal	12	28%
Estudiante	10	23%
Trabajadora del hogar	5	12%
Trabajadora con empleo formal	3	7%
Agricultora	1	2%
Total	43	100%

Nota: El total es de 41 casos pues en los restantes no se indica este dato en la sentencia.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

Conforme lo señala Leandro Despouy (2008, p. 128) los procesos judiciales son particularmente onerosos en tanto los costos incluyen gastos de honorarios de representación legal, el transporte y la disminución de la actividad laboral. Este costo, sin embargo, también se traduce en un costo a la salud mental de las MPG. Al respecto, Sofía, una mujer criminalizada entrevistada, señaló lo siguiente:

> *"Sí, sentía tanto miedo que no hacía cosas, ¿no? Ni siquiera trabajar ni nada, solo... me dedicaba a cuidar a mi papá y existir. Eso duró medio año, más o menos. O sea, si me salían trabajos y los cumplía, sí los hacía, pero eso era como que... Rechazaba hartos trabajos porque... No me sentía con la capacidad, ¿no? De desarrollarlos, ¿no? De cumplir. Porque... Estaba vulnerable todavía, ¿no?"*
> *(Sofía, mujer criminalizada)*

La condición económica de las MPG criminalizadas por el delito de aborto también limita su acceso a una justicia en condiciones de igualdad, la cual impacta significativamente en las formas en las que se conducen y concluyen los procesos. Por ello, el **tipo de defensa** finalmente recibido por las MPG procesadas también da luces sobre su vulnerabilidad económica.

En 30 de las 100 sentencias analizadas, se pudo determinar si las mujeres imputadas por aborto (MPG) solicitaron o recibieron defensa de oficio, si contaban con los recursos económicos necesarios para contratar un servicio jurídico, o si habían recibido asistencia de alguna organización de la sociedad civil. De estos casos, el 63% (19 casos) contó con patrocinio de la defensa pública de oficio, mientras que el 23% (7 casos) tuvo representación privada, lo que implica que incurrieron en gastos de su propio bolsillo. Solo el 7% (2 casos) recibió apoyo de grupos feministas. El hallazgo más preocupante es que, en dos casos (7%), las MPG no contaron con defensa alguna durante el proceso, vulnerando su derecho fundamental a la defensa establecido en el artículo 138 de la Constitución Política. Este aspecto, sin embargo, no fue supervisado por los jueces al momento de dictar sentencia.

Figura 5.3. Sentencias según el tipo de defensa de la MPG procesadas

Nota: El total es de 30 casos pues en los restantes no se indica este dato en la sentencia.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

De esta manera, la data revela que la criminalización del aborto en el Perú impacta de manera significativa en las MPG de bajos recursos, quienes carecen de los medios para obtener defensa legal de calidad.

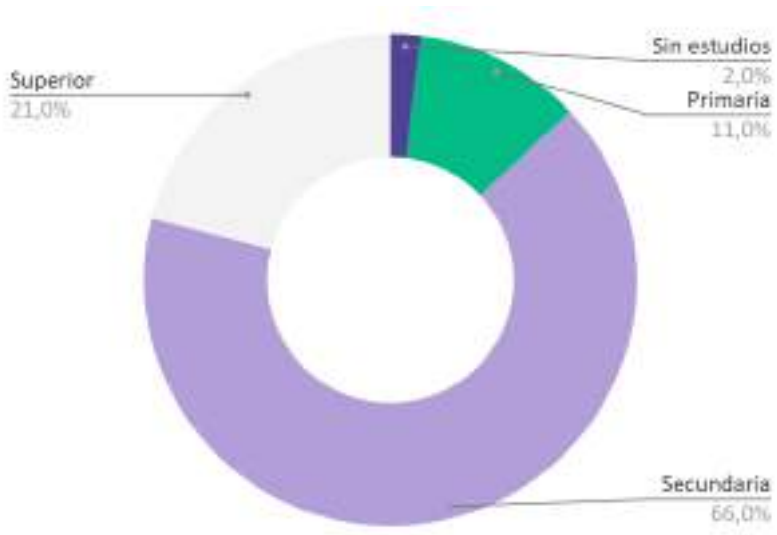
5.3. Grado de instrucción de las MPG

"Como particularidad de la joven, era una persona con primaria incompleta. Ella me precisó, que, si bien es cierto, aparece en actas quinto de primaria, era que en el colegio le habían apoyado a subir los grados, pero hasta cierto punto más ya no se podía dar. Entonces, no tenía la facilidad para expresarse, las palabras indicadas, no tenía mucho entendimiento de lo que uno le decía".

(Ana, Defensora Pública 2)

En el análisis de 53 sentencias con información sobre el grado de instrucción de las mujeres procesadas por casos de aborto (MPG), se identificó que la mayoría contaba con estudios de educación básica (primaria y secundaria, completa e incompleta), representando el 77% de los casos. Por otro lado, el 21% de las MPG tenían estudios superiores, ya sean técnicos o universitarios (completos e incompletos). En un caso (2%), la MPG procesada no contaba con ningún tipo de estudio, indicando que no sabía leer ni escribir.

Figura 5.4. Sentencias según grado de instrucción de MPG procesada

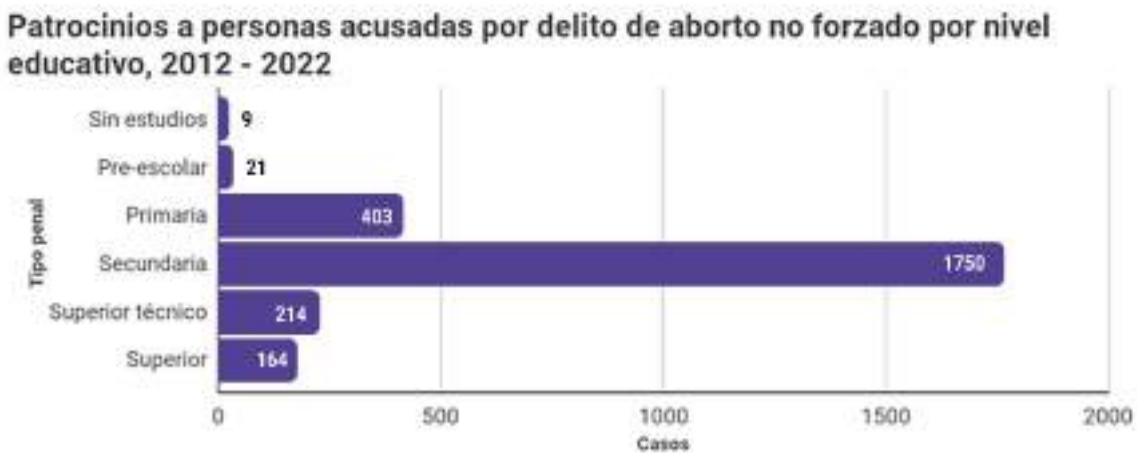


Nota: El total es de 53 casos pues en los restantes no se indica este dato en la sentencia.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

En la misma línea, según el Ministerio de Justicia, respecto al nivel educativo de las personas patrocinadas acusadas por delitos de aborto, la mayoría de estas tienen la secundaria como máximo nivel educativo (1750 casos), a comparación de las personas con nivel superior universitario (164 casos).

Figura 5.5. Patrocinios por delitos de aborto, según nivel educativo



Elaboración propia. Fuente: Sistema de Seguimiento de Casos - DGDPAJ, Ministerio de Justicia.

Las entrevistas y la data extraída del análisis de los expedientes evidencian una relación entre el nivel educativo de las MPG criminalizadas y su conocimiento sobre sus derechos y las implicancias de la ley en casos de aborto. Esta correlación resalta que aquellas con menor nivel educativo son más vulnerables en el proceso penal. La falta de conocimiento sobre la ilegalidad del aborto y sus derechos frente a un proceso judicial a menudo lleva a estas mujeres a autoincriminarse o a ceder ante presiones del personal médico o policial, incluso cuando el embarazo no ha sido interrumpido de manera intencional.

5.4. Factores de vulnerabilidad identificados

En 4 sentencias se identificaron seis factores de vulnerabilidad adicionales, destacando dentro de ellos habitar en una zona rural. Otros factores incluyen tener una discapacidad (auditiva), carecer de un DNI y no saber leer ni escribir. En un caso se identificó la interseccionalidad de tres factores de vulnerabilidad: ser adolescente, indígena y vivir en una zona rural.

Tabla 5.2. Sentencias según factor de vulnerabilidad de la MPG procesada

Factor de vulnerabilidad	Frecuencia
Condición de discapacidad	1
Condiciones geográficas: Habitar en zona rural	2
Reconocimiento legal: Carecer de DNI	1
Factores lingüísticos o culturales: Identificación étnica (indígena)	1
Factores lingüísticos o culturales: Condición de analfabetismo	1
Minoría de edad	1
Total	**6**

Nota: El total suma más de 4 pues en un caso se identificaron varios factores de vulnerabilidad.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

En uno de los expedientes se puede apreciar la historia de ***Ina***[63] una mujer de 40 años con discapacidad auditiva y en condición de analfabetismo que fue sentenciada por el delito de autoaborto. Ina fue sometida a un proceso judicial irregular, sin apoyos y ajustes razonables que le permitieran conocer sus derechos frente al juicio, así como conocer las implicancias de los consejos legales que la defensa pública le brindaba. Es más, ella fue intervenida junto a su hijo de 15 años, quien fue interrogado por agentes policiales, llegando a inculpar a su madre sin presencia de abogado/a, sin lectura de derechos; entre otros. Ina fue posteriormente detenida y privada de su libertad para ser condenada.

Vulnerabilidad por factores lingüísticos y culturales

La situación de migración, ser quechuahablante y las diferencias culturales también son factores de vulnerabilidad, los que además exponen a prácticas fraudulentas relacionadas al aborto, como la venta engañosa de medicamentos. La falta de comprensión del idioma dominante y de los marcos normativos puede contribuir a que estas personas sean además víctimas de procesos judiciales sin las garantías del debido proceso y tengan dificultades para buscar ayuda o denunciar.

Asimismo, tal como lo consignamos en el análisis de la tasa de criminalización, existe una correlación positiva moderada y estadísticamente significativa entre la tasa de criminalización del aborto no forzado y el porcentaje de población quechua.

63. Expediente analizado Nº 10, MPG-2021-AQP.

Vulnerabilidad por condiciones geográficas

Pero, ¿cuál es el lugar donde viven, generalmente? Recibimos denuncias de los conos, recibimos denuncias de la Victoria, por lo menos, de los cerros San Cosme y San Pedro, San Cayetano, de esa zona, donde sabemos que las personas.... no tienen estudios superiores, no digo que todas, pero la gran mayoría.
(Funcionario DIRINCRI)

La ubicación en áreas geográficas de bajos recursos también puede afectar la capacidad de las personas para acceder a información precisa sobre prácticas seguras de aborto, servicios médicos adecuados y apoyo social, lo que las vuelve aún más vulnerables ante la criminalización del aborto.

Este fenómeno se ilustra en el caso de ***Kari***[64], una adolescente de 17 años de una zona rural del Cusco que se encontraba sola en la ciudad de Lima debido a que seguía estudios superiores ahí. Kari fue en busca de atención médica al hospital debido a un sangrado, donde enfrentó la criminalización tanto del personal sanitario como por representantes del Ministerio Público. Dada su minoría de edad, según el expediente, el hospital exigió la autorización de sus padres para proceder con la atención del aborto incompleto. Sin embargo, debido a que Kari estaba sola en la capital y sus padres en su pueblo natal, el hospital decidió solicitar la intervención del Ministerio Público. Bajo el pretexto de autorizar la intervención, la fiscalía tomó su declaración sobre los hechos e inició un proceso judicial por autoaborto sin ninguna garantía procesal ni presencia de su abogado(a).

Según cifras del sistema de salud, Huánuco (92%), Amazonas (89.1%) y San Martín (87.6%) son las tres regiones del país en donde la cantidad de abortos practicados se han realizado principalmente en establecimientos del MINSA, lo que podría indicar que en estas regiones existe mayor accesibilidad a este sistema de salud frente al de EsSalud. En contraparte, la Provincia Constitucional del Callao es la única del país en donde la cantidad de abortos practicados en redes de EsSalud es mayor a las del MINSA (un 64.3% frente a un 35.7%). Este panorama no sólo releva las diferencias regionales en el uso de los centros de salud públicos, sino que además expone las condiciones geográficas que llevan a las MPG a ubicar el establecimiento más cercano y los obstáculos para el acceso al aborto producto de la escasa apertura del personal sanitario.

Vulnerabilidad por entorno social, familiar y de pareja

"Ella había asumido esta decisión sola, no se la comunicó al enamorado y efectivamente tú notabas la falta de soporte, ni siquiera familiar mucho menos en redes, porque ella estaba sola acá".
(Claudia, operadora de justicia)

64. Expediente analizado Nº 12, MPG-2017-LIM.

El contexto familiar y social también puede contribuir a la vulnerabilidad de las personas frente a la criminalización, ya que las condiciones adversas en este ámbito pueden influir en su acceso a la información, apoyo emocional y acompañamiento durante el proceso. En efecto, ello puede generar una sensación de ausencia, abandono o indiferencia percibida por las MPG que atraviesan una interrupción del embarazo y un proceso judicial. Es más, esta sensación se puede ver reforzada por la falta de soporte emocional de los vínculos más cercanos, como la pareja e integrantes de su familia.

"Le comenté al chico. Le dije: bueno, estoy teniendo estas cosas. Todavía no se me ha atrasado la regla, pero estoy teniendo un sangrado irregular. Me ha pasado esto. Y él como que "Ah, pucha. Bueno. No sé". No le dió mucha importancia". Y como ser consciente de mi situación es entender que no puedo trær una vida nueva al mundo porque no le daría el espacio que merece, ¿no? Y también por la situación. Porque el chico, o sea, se notaba que no iba a estar.
(Sofía, mujer criminalizada)

Esta situación de vulnerabilidad puede intensificarse cuando las víctimas o sus redes de soporte directo son personas con discapacidad, quienes además no cuentan con apoyos o ajustes razonables. Tal es el caso de las niñas y adolescentes, cuyas cuidadoras presentan alguna discapacidad.

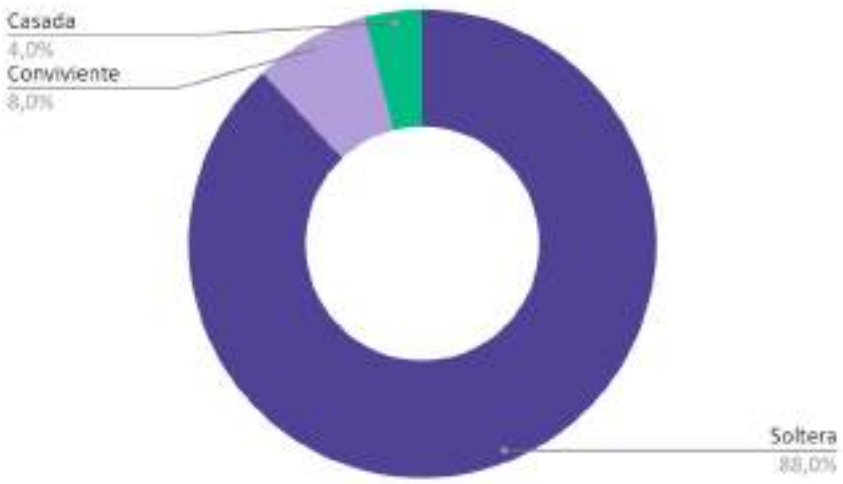
"Su mamá tenía límites para protegerla por la discapacidad, tenía un hermano alcohólico y estaba sometida a las consecuencias del abuso sexual".
(Laura, familiar de adolescente criminalizada)

5.5. Otras características de las MPG

Estado civil y maternidad

De las 52 sentencias con información relativa al estado civil de la MPG, se pudo conocer que el 88% (46 casos), casi la totalidad, era "soltera". La minoría era conviviente (4 casos) o casada (2 casos).

Figura 5.6. Sentencias según estado civil de la MPG procesada



Nota: El total es de 52 casos en los restantes no se indica este dato en la sentencia.

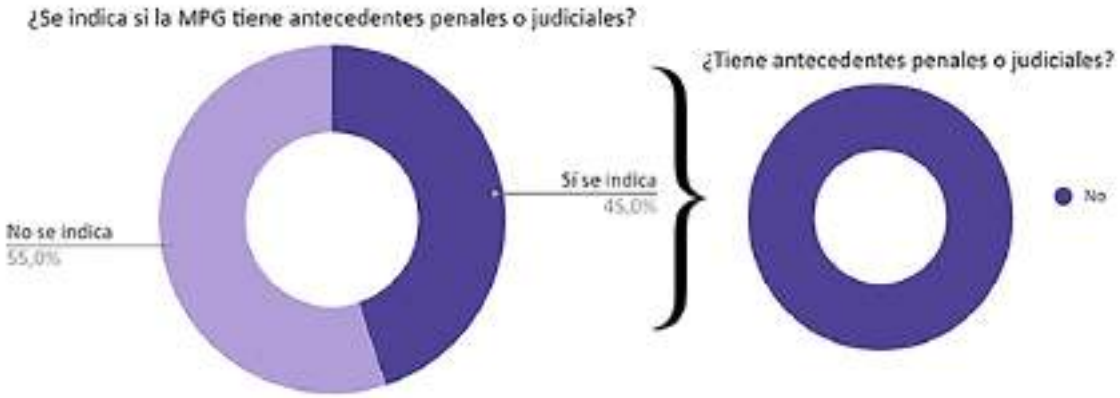
Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

En relación con el número de hijes, se supo que en 24 casos la MPG tenía hijos/as, mientras que en 10 indicaron no tener alguno. En las 65 sentencias restantes no se consignó dicho dato.

Antecedentes penales, policiales o judiciales

De las 100 sentencias analizadas, sólo en 45 se consignó la información sobre los antecedentes penales, policiales o judiciales de las MPG. De este número, ninguna registraba estos antecedentes: elementos de juicio claves para el análisis de atenuación de la pena en caso de personas adultas y elemento fundamental para la remisión o terminación del proceso en caso de adolescentes.

Figura 5.7. Sentencias según antecedentes de la MPG procesada



Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

La ausencia de antecedentes penales como característica de las personas procesadas por el delito de autoaborto da cuenta de que la realidad dista del estereotipo de género que ubica a quienes interrumpen sus embarazos en la condición de "criminales" o personas cuyas conductas se alinean con infracciones normativas reiteradas.

5.6. Características de las experiencias de aborto

Conocimiento del embarazo

Como se puede observar de la Tabla 5.3, en ocho casos seguidos por el delito de autoaborto la MPG procesada declaró que no tenía conocimiento sobre su estado de embarazo: un elemento clave para la configuración del tipo penal. Pese a lo anterior, la mitad de ellos terminaron con una sentencia condenatoria y con reparaciones civiles entre los S/. 500 (133 dólares) y S/. 2000 soles (533 dólares).

Tabla 5.3. Sentencias según si la MPG sabía que estaba embarazada

¿Sabía que estaba embarazada?	Casos
Sí	65
No indica/ No aplica	28
No	8

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

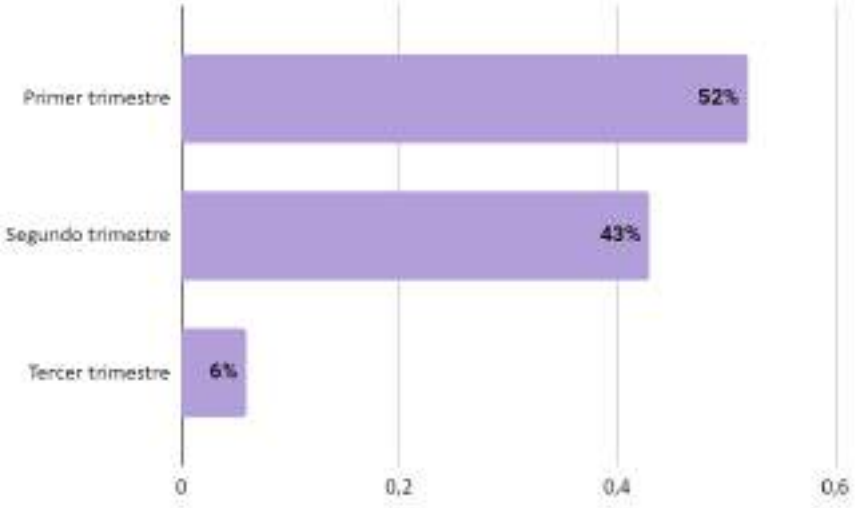
De la lectura de estas cuatro sentencias condenatorias se pudo identificar que el desconocimiento del embarazo por parte de la MPG procesada no fue siquiera un elemento controvertido en el caso. Es más, da la impresión de que este extremo de la declaración de la MPG fue voluntariamente ignorado. Sólo en un caso se declaró la absolución de la MPG procesada, el cual fue principalmente atribuido a la ausencia de medios probatorios y a la declaración de la MPG. No quisiéramos dejar de resaltar que en uno de los casos clasificados como "No aplica", la MPG criminalizada ni siquiera se encontraba embarazada. Tal es el caso de **Soledad**[65], una mujer del ande peruano, quien tuvo que enfrentar un proceso judicial de 1 año y 7 meses por el delito de autoaborto, debido a que acudió a un hospital público a solicitar atención atención por una hemorragia.

Tiempo de gestación por trimestre

En 54 de las 100 decisiones se pudo conocer en qué trimestre se interrumpió el embarazo (espontánea o voluntariamente). Como se observa de la Figura 5.8, en el 52% de los casos la interrupción sucedió durante el primer trimestre (28 casos), seguido por poco de aquellos producidos en el segundo trimestre con 41% (23 casos). Por último, sólo en 3 casos la terminación del embarazo sucedió en el tercer trimestre.

65. Sentencia Nº 77 analizada, MPG-2013-HVCA..

Figura 5.8. Sentencias según el tiempo de gestación por trimestre



Nota: El total es de 54 casos pues en los restantes no se indica este dato en la sentencia.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial

Embarazo producto de violación sexual

De la lectura de los hechos de las sentencias también se pudo identificar que en 3 casos los embarazos fueron producto de una violación sexual o, por lo menos, existían indicios de ello. En uno de los casos, la MPG procesada era una niña.

Tabla 5.4. Sentencias según si el embarazo fue producto de una violación

¿El embarazo fue producto de una violación?	Casos
Sí	3
No	69
No indica	28

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial

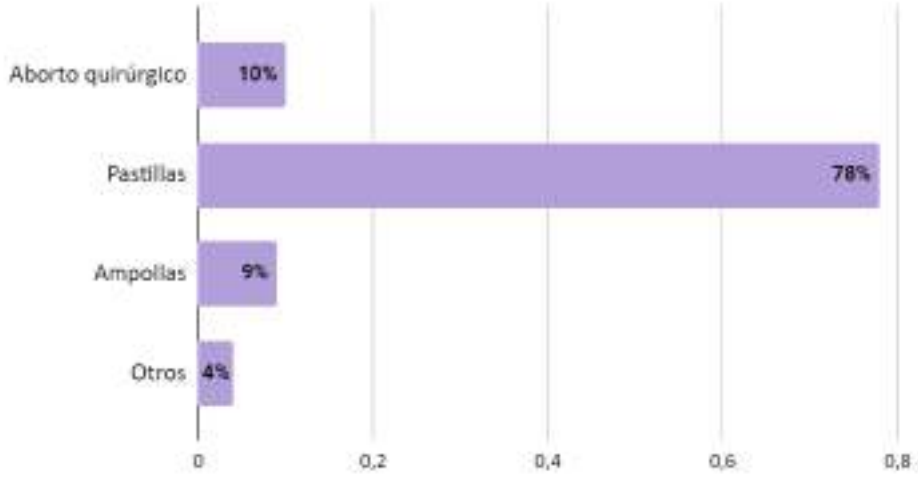
Lejos de considerar este elemento como un factor para adecuar el tipo penal de autoaborto por aborto sentimental[66], en los tres casos se declaró la culpabilidad de la MPG procesada por el primer delito. Sólo en el caso de la niña -cuyo aborto incluso fue espontáneo-, en segunda instancia, se logró la recalificación del delito y ratificar su inocencia tras las acciones de representación legal feminista. En los dos casos restantes se concluyó la responsabilidad penal de las mujeres, imponiéndose en ambos una reserva de fallo por el plazo de un año[67] y reparaciones civiles de S/. 300 (80 dólares) y S/. 500 soles (133 dólares) respectivamente.

66. El "aborto sentimental" se encuentra regulado en el inciso 1 del artículo 120 del Código Penal, estableciendo que en casos de aborto producto de una violación sexual la pena privativa máxima es de tres meses. En el caso del delito de autoaborto, la pena máxima es de dos años.
67. En ninguno de estos casos las MPG sentenciadas fueron privadas de su libertad.

Métodos utilizados para la interrupción del embarazo

En 69 de las 100 sentencias se registró cuál fue el método para abortar escogido por la MPG procesada, el cual incluye al aborto quirúrgico, por medicamentos (como pastillas y ampollas) y otros (como tés). A partir de la Figura 5.9, se puede advertir que el método más utilizado fue el farmacológico o aborto por medicamentos, destacando dentro de ellos el uso de pastillas (62 casos). Muy por debajo de esta cifra se encuentra el aborto quirúrgico (8 casos) y el uso de ampollas (7 casos). Por último, en tres casos la MPG señaló haber ingerido algún tipo de hierba natural, de los cuales sólo en uno estuvo acompañado de pastillas. Pese a la ausencia de evidencia científica que confirme el carácter abortivo de estos "métodos naturales", en los dos casos en los que se ingirió exclusivamente un té se declaró culpable a la MPG procesada.

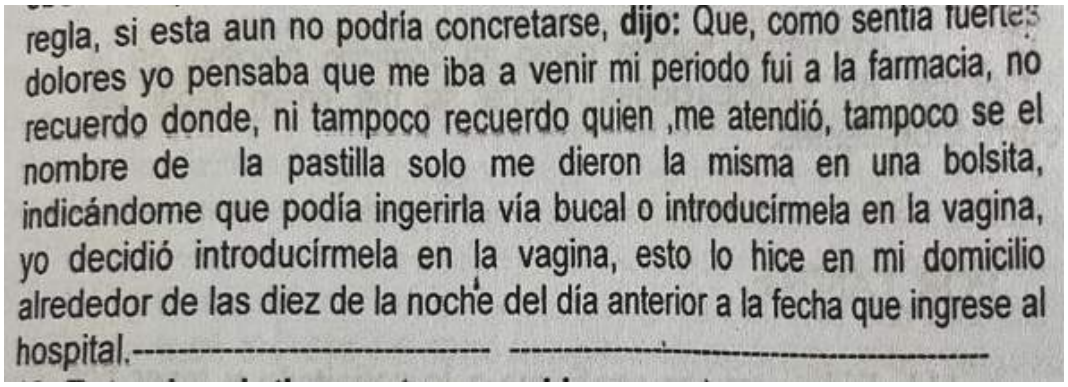
Figura 5.9. Sentencias según el método para abortar escogido



Nota: El total suma más de 69 pues en varias sentencias se hizo referencia a más de un método.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial

A pesar de hacer referencia a la ingesta de pastillas en su declaración, en algunos casos la MPG procesada desconocía o no estaba segura de estar gestando. Tampoco sabía el nombre de las pastillas ni sus efectos. Tal es el caso de ***Oriana***[68], quien fue sentenciada por el delito de autoaborto. Al solicitarle que "narre en forma detallada lo sucedido que dio motivo a su internamiento en el hospital", señaló lo siguiente:

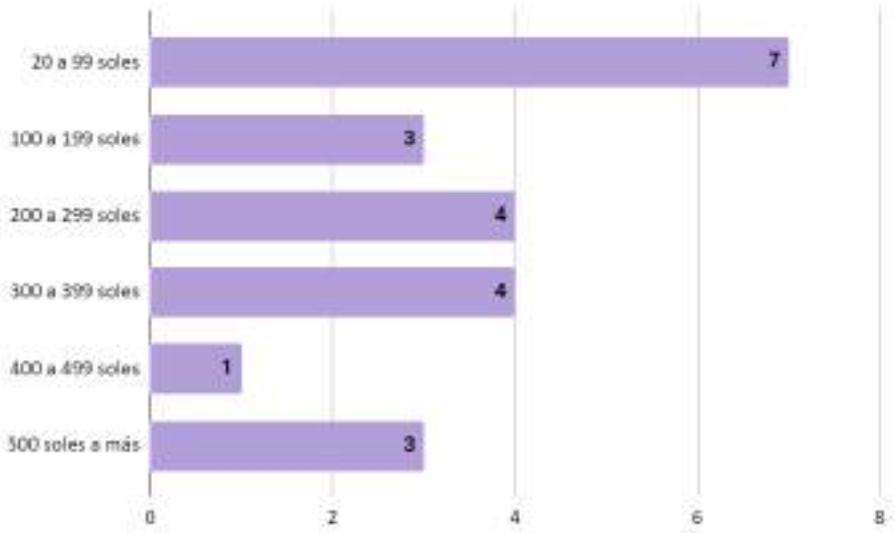

regla, si esta aun no podría concretarse, **dijo:** Que, como sentia fuertes dolores yo pensaba que me iba a venir mi periodo fui a la farmacia, no recuerdo donde, ni tampoco recuerdo quien ,me atendió, tampoco se el nombre de la pastilla solo me dieron la misma en una bolsita, indicándome que podía ingerirla vía bucal o introducírmela en la vagina, yo decidió introducírmela en la vagina, esto lo hice en mi domicilio alrededor de las diez de la noche del día anterior a la fecha que ingrese al hospital.---------- ----------

68. Expediente analizado Nº 14, MPG-2019-APU.

Costo del método para la interrupción del embarazo

En 22 de las 100 sentencias se registró a cuánto ascendía el costo del método para abortar. La Figura 5.10 muestra que el costo mínimo para acceder a un método de interrupción del embarazo fue de S/. 10 soles (principalmente, el costo unitario de las pastillas); mientras que el precio máximo supera los S/. 500 soles. Aunque usualmente los costos más elevados corresponden a abortos quirúrgicos, en algunos casos se advirtió que sólo las pastillas alcanzaban valores entre los S/. 300 y S/. 700 soles.

Figura 5.10. Sentencias según el costo del método para abortar



Nota: El total es de 21 casos pues en los restantes no se indica este dato en la sentencia.

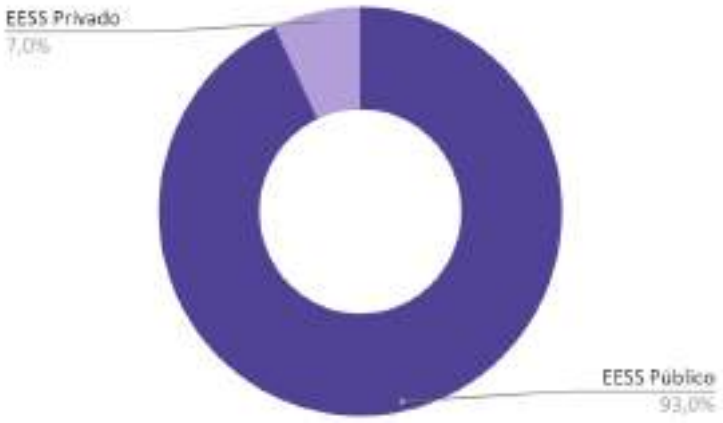
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial

Esta información no sólo evidencia la heterogeneidad en el costo de los métodos para la interrupción del embarazo empleados, sino que también demuestra los sacrificios económicos que deben asumir las MPG procesadas considerando que la mayoría de ellas carecen de ingresos económicos suficientes para su autosostenimiento.

Tipo de establecimiento de salud que atendió a MPG

En 72 de las 100 sentencias se pudo identificar el tipo de EE.SS. al que acudió la MPG en busca de asistencia médica tras presentar un evento obstétrico. Como se puede observar de la Figura 5.11, casi la totalidad de las MPG (93% o 67 casos) acudieron a un EE.SS. público. Sólo el 7%, una minoría, se dirigió a una clínica privada para ser atendida (5 casos).

Figura 5.11. Tipo de establecimiento de salud



Nota: El total es de 72 casos pues en los restantes no se indica este dato en la sentencia.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial

Una vez más, ello demuestra que quienes son llevadas a juicio son las MPG con menores recursos económicos y que son los servicios públicos de salud los escenarios más inseguros o que presentan mayor riesgo de criminalización para las MPG que enfrentan emergencias obstétricas.

Procedimiento médico realizado al llegar al EE.SS.

En 26 sentencias también se pudo identificar el tipo de procedimiento médico que se realizó a la MPG procesada tras llegar a un EE.SS. por una emergencia obstétrica. Como se puede observar de la Tabla 5.5., el legrado uterino fue el principal procedimiento médico escogido por el personal sanitario (20 casos); mientras que el AMEU sólo fue realizado en dos casos.

Tabla 5.5. Sentencias según procedimiento médico realizado al llegar a un EE.SS.

Procedimiento médico	Casos	%
Legrado uterino	20	77%
Aspiración manual endouterina (AMEU)	2	8%
"Lavado vaginal"	2	8%
Intervención quirúrgica	1	4%
Histerectomía	1	4%

Nota: El total es de 26 casos pues en los restantes no se indica este dato en la sentencia.

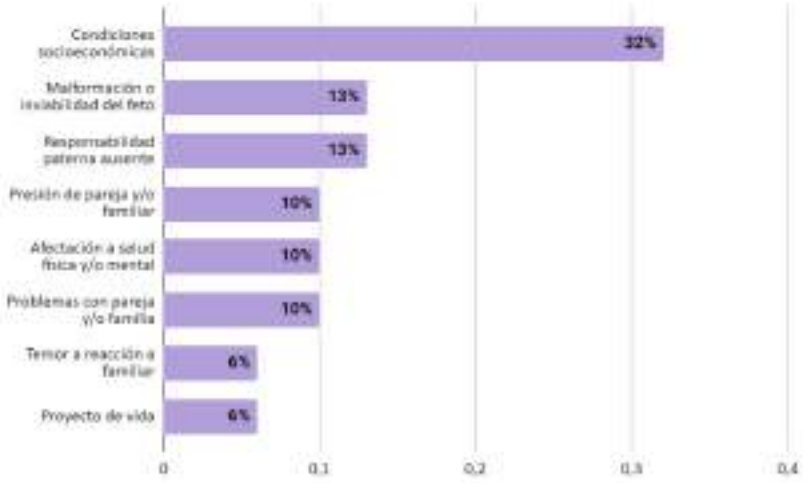
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial

Al respecto, cabe destacar que esta información difiere con los estándares más actualizados para la atención del aborto de la OMS, los cuales no recomiendan la práctica del legrado instrumental (OMS, 2022, p. 11) Por otro lado, en dos decisiones se hizo referencia a procedimientos no científicos ("lavado vaginal") y en uno se utilizó un término general ("intervención quirúrgica"). Sólo en uno se realizó una histerectomía debido a la perforación del útero.

5.7. Motivaciones para abortar

En 25 sentencias se hizo explícita la motivación de la persona para abortar, revelando la presencia de diversos factores. Entre estos destaca la ausencia de condiciones socioeconómicas necesarias para llevar adelante un embarazo, siendo la presión financiera el principal factor en la toma de decisiones. Es más, en un caso, la MPG señaló que, además de encontrarse en una situación económica precaria, tenía depresión; evidenciando cómo las dificultades económicas pueden intensificar el impacto de problemas de salud mental en estas circunstancias.

Figura 5.12. Sentencias según las motivaciones para abortar de la MPG



Nota: El total suma más de 26 pues en algunas sentencias se hizo mención a más de una motivación para abortar.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

Además de las dificultades económicas, se identificaron motivaciones relacionadas con la salud, como tener epilepsia, presión arterial alta o depresión. Dichos hallazgos llaman poderosamente la atención en la medida que en el Perú el aborto terapéutico es legal por lo que estas MPG pudieron estar frente a un aborto legal.

La presión social y familiar también se manifiesta como un factor significativo, ya que algunas personas expresaron temor a la reacción familiar y enfrentaron resistencia por parte de su pareja o familiares a tener más hijos/as. También se identificaron como factores adicionales que contribuyen a la vulnerabilidad de las MPG a la falta de asunción de responsabilidad por parte del padre, dificultades en la relación de pareja y problemas familiares.

En conjunto, estos motivos exponen las diversas y complejas situaciones individuales que llevan a las MPG a buscar un aborto, destacando cómo la intersección de factores económicos, de salud, sociales y familiares puede profundizar su vulnerabilidad y agudizar su situación de pobreza. Cabe señalar que las motivaciones aquí compartidas se limitan a la información registrada en las sentencias. En efecto, es posible que en las 71 decisiones restantes la MPG procesada haya hecho explícita la razón de su aborto, pero no haya sido consignado en el documento por los operadores de justicia.

CAPÍTULO 6

¿Cuáles son las características de los procesos penales?

En este capítulo se comparten los hallazgos vinculados a las características de los procesos penales por los delitos de aborto, los cuales dan luces sobre los espacios en los que se activa la maquinaria penal y las formas en que se conducen y analizan los procesos penales impulsados por el Ministerio Público y sentenciados por el Poder Judicial. Del análisis destaca que la gran mayoría de los procesos penales (un 84%) inician en EE.SS., principalmente públicos. El análisis cualitativo también revela cómo la información proporcionada durante la atención médica se utiliza como "medio probatorio", vulnerando el secreto profesional, la intimidad y el debido proceso. Es más, se observa que, en casos de violencia sexual, los fiscales suelen denunciar por autoaborto a las víctimas adolescentes que experimentan un aborto espontaneo o voluntario. Asimismo, se presentan testimonios que ilustran presiones policiales y médicas para la autoincriminación de las MPG.

El análisis de las 100 sentencias también nos permitió adentrarnos en los procesos penales iniciados por los delitos de aborto para así conocer con mayor detalle cómo y bajo qué paradigmas se conducen estos casos. Así, se identificó que, en al menos una veintena de casos, hubo una calificación incorrecta de los hechos, llevando a las MPG a ser procesadas por el delito de autoaborto. Asimismo, se advierte que el Ministerio Público suele solicitar penas y reparaciones civiles más gravosas a las finalmente impuestas por el Poder Judicial. Por otro lado, se halló que las sentencias condenatorias son producto de acuerdos de terminación anticipada, los cuales suelen ser propuestos por la defensa de las MPG investigadas. Por último, los procesos penales duran en promedio 2 años y 7 meses.

6.1. Regulación de los procesos penales en el Perú

En la actualidad, **el proceso penal en el Perú** se rige por el **Nuevo Código Procesal Penal**, vigente desde 2004. La resolución de una controversia con relevancia penal se lleva a cabo en tres fases: la etapa de procedimiento de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de enjuiciamiento.

En el transcurso de la **investigación preparatoria**, la Fiscalía recopila pruebas para evaluar la viabilidad de presentar cargos. Este período se inicia con diligencias preliminares que abarcan un plazo de 20 días y pueden implicar acciones urgentes para verificar la comisión del delito. La Fiscalía está facultada para requerir asistencia policial y, si es necesario, solicitar la intervención del juez. En caso de que la Fiscalía detecte indicios de un delito y se cumplan los requisitos legales, procede a formalizar la investigación preparatoria. Durante esta fase, y hasta antes de la formulación de la acusación fiscal (Art. 343.3 CPP) existe la posibilidad de solicitar **la terminación anticipada**, un proceso mediante el cual la persona imputada -quien reconoce la responsabilidad penal del delito- y la Fiscalía solicitan al juez de investigación preparatoria la reducción de la pena en una sexta parte según lo establecido en el Código Penal. Este mecanismo tiene como objetivo agilizar el curso del proceso y así evitar las etapas intermedias y de juicio oral (Artículo 330 CPP). El juez, sin embargo, debe calificar y controlar la legalidad de este acuerdo. Y es que, en tanto esta alternativa jurídica supone la aceptación de los cargos y la renuncia al juicio, la actuación probatoria demanda de un control estricto por el juez o jueza a cargo. Pero, además, exige que la MPG procesada brinde un consentimiento libre e informado a partir del adecuado asesoramiento de su defensa (San Martín Castro, 2020, p. 1149).

En la **etapa intermedia**, la Fiscalía decide si solicita el sobreseimiento del caso, esto es, la terminación del proceso, o formula una acusación. El sobreseimiento puede ser total o parcial y se debate en una audiencia preliminar convocada por el juez. De formularse una acusación, se convoca una audiencia

preliminar en la cual se discuten las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. El juez emite un auto de enjuiciamiento y, si es necesario, ordena la libertad de la persona imputada.

El **juicio oral** -o la etapa de enjuiciamiento- es la fase final del proceso penal en la que se lleva a cabo el juicio basado en la acusación, siguiendo los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. Las partes presentan argumentos y pruebas ante el juez para determinar la culpabilidad o inocencia de la persona acusada. La fase culmina con la sentencia, que determina la responsabilidad penal de la persona acusada y, en su caso, la reparación civil.

6.2. ¿Dónde inicia la criminalización del aborto?

Este apartado explora el papel crucial de los establecimientos públicos de salud en el inicio de procesos de criminalización relacionados con el aborto en Perú. A través de la lectura de sentencias, expedientes y noticias, así como del análisis cualitativo de entrevistas, se ha identificado que el personal sanitario de estos establecimientos es el principal agente de denuncia en la mayoría de los casos, en violación al deber legal de guardar secreto médico. Este capítulo examina cómo el personal médico y otros actores del sistema de salud pueden actuar como catalizadores en la activación de procesos penales, utilizando información confidencial proporcionada por las mujeres durante la atención médica. Además, se detallan las modalidades de intervención policial y la participación del Ministerio Público en estos procesos, destacando las implicaciones éticas y legales de estas prácticas y sus efectos en las mujeres criminalizadas.

6.2.1. Los establecimientos públicos de salud

> "El jefe de emergencias vino (...) y me dijo, "bueno, tengo que llamar a la policía. Es mi deber llamar a la policía porque tú has abortado y eso es ilegal y todo el peso de la ley va a caer sobre ti" Así me dijo "yo me voy a encargar de que todo el peso de la ley caiga sobre ti"
> (Sofía, mujer criminalizada).

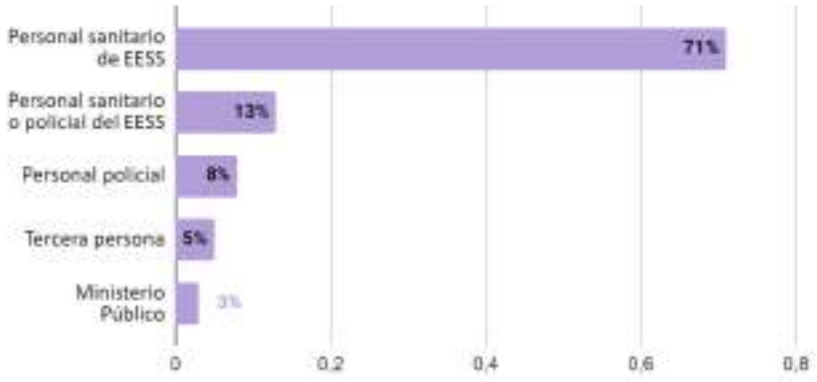
La lectura de sentencias, expedientes, noticias y el análisis cualitativo nos permitió identificar que el proceso penal generalmente inicia en un EE.SS., lo que incluye principalmente al personal sanitario como agente de denuncia.

De las 100 sentencias analizadas, en 77 se identificó información sobre el denunciante. En 55 casos (71%), **el principal agente que reportó el aborto** (espontáneo o inducido) a la PNP y/o Fiscalía **fue el personal de salud** del establecimiento donde la mujer recibió atención. En un **13% de los casos**, no quedó claro si la denuncia fue realizada directamente por el personal sanitario o por el agente policial que permanece de manera fija en las salas de emergencia de los hospitales públicos. Seguidamente, se halla el **personal policial a cargo de un allanamiento** (8% o 6 casos), **terceras personas**[69] (5% o 4 casos) y el **Ministerio Público** (3% o 2 casos). Ahora bien, en 10 casos (13%), la redacción de los

69. Esta categoría incluye a (ex)parejas y familiares de la MPG investigada.

hechos del caso no permitió identificar de manera inequívoca quién fue el agente que accionó el sistema penal. Sin embargo, nos permite afirmar que la criminalización de 65 casos inició en un EE.SS.

Figura 6.1. Sentencias según el agente que denuncia los hechos de aborto



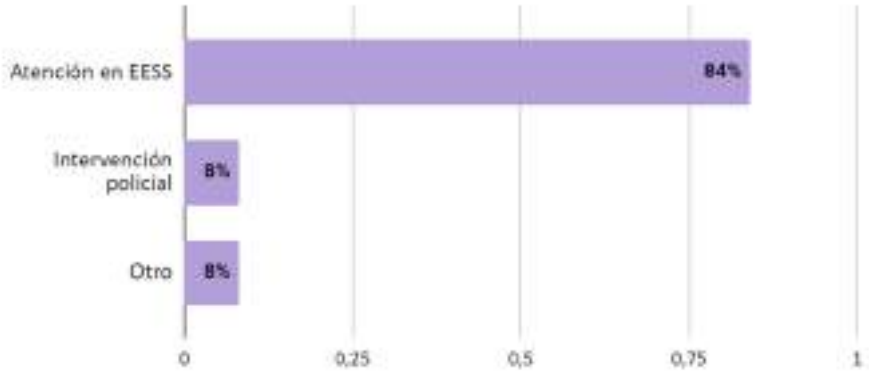
Nota: El total es de 77 casos pues en los restantes no se indica este dato en la sentencia.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

El rastreo del inicio del proceso penal también fue realizado desde otro ángulo: considerando sus circunstancias. Como muestra la Figura 6.2, en el 84% de las sentencias (65 casos) el sistema de criminalización se accionó durante la atención médica ofrecida a la MPG en el establecimiento de salud. Esta apabullante cifra pone en evidencia que **en 4 de cada 5 casos** la maquinaria de la criminalización se activa en los EE.SS. De hecho, considerando el tipo de EE.SS. al que acuden mayoritariamente las MPG, se puede concluir que **la criminalización inicia principalmente en EE.SS. públicos**.

Por otro lado, se encuentran las intervenciones policiales 8% (6 casos), las cuales hacen referencia al desarrollo de operativos policiales dirigidos a detener a quienes se encuentren dentro de un centro médico privado donde se presume se realizan abortos. El 8% restante (6 casos) incluyen procesos iniciados por llamadas de terceras personas, por el Ministerio Público y como consecuencia de la llamada de emergencia a la PNP por una MPG con un evento obstétrico.

Figura 6.2. Sentencias según circunstancia en la inicia el proceso penal



Nota: El total es de 77 casos pues en los restantes no se indica este dato en la sentencia.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

El análisis cualitativo mediante entrevistas proporcionó una comprensión más profunda de cómo inician los procesos de criminalización en los EE.SS. En estos casos, se constata que la información proporcionada por la MPG durante la atención médica -en la anamnesis- es empleada como uno de los principales "medios probatorios" para acusarla de un delito, vulnerando así el secreto profesional, la intimidad y empleando información confidencial en su contra.

En ocasiones, el personal médico ha sido el responsable de iniciar denuncias que desencadenan procesos de criminalización contra aquellas personas que han experimentado un aborto, ya sea espontáneo o inducido. Como relata Catherine y Sofía:

> *"el ginecólogo que me atendió me estaba auscultando, haciendo una ecografía para ver (...) Y en ese momento me dijo, este, "tienes que decirme si has tomado pastillas o no porque si no, no te voy a atender". Y yo asustada porque tenía miedo de morirme, ¿no? Y tenía mucho sangrado. Bueno, "sí, sí, le dije sí, lo hice" (Sofía, mujer criminalizada).*

> *"Quien me denunció fue el doctor que me atendió, el que me hizo la revisión. Y fue como que una segunda doctora que ya estaba encargada de hacer los papeleos (...). Después hubo otra chica que también era personal médico y que influyó mucho en la denuncia porque ella les decía que lo hicieran, que me denunciaran" (Catherine, mujer criminalizada).*

La presión ejercida por agentes policiales para que las MPG declaren sin información sobre sus derechos, sin defensa legal y bajo la amenaza de consecuencias legales, evidencia una coacción que puede afectar la veracidad de las declaraciones, la imparcialidad del proceso y el principio de no autoincriminación. Catherine comparte su experiencia: *"Los policías (...) me dijeron que tenía que decir las cosas nada más. Y que de eso dependía que si iba a salir o no. Y si iba a ir presa o no iba a ir presa"*.

Los testimonios también dan cuenta que, dentro de los EE.SS., los/las médicos/as pueden llegar a privar de la libertad a las MPG como mecanismo de castigo. Esta retención puede extenderse durante varias horas e incluso días.

> *"Por más que había dado mi testimonio, no me querían dejar salir. Y estaba desesperada por salir del hospital porque ya me suelten. Llegué a salir al día siguiente. Ya no había nada y recién me dieron el alta. Y ahí pude salir. Estuve detenida cuatro días. (...) Sí, los primeros dos días fue que tenía que venir la policía. El segundo día, el tercer día vino la policía a tomar una manifestación, pero nada, no me dejaron salir. El cuarto día recién en la tarde me dejaron salir" (Catherine, mujer criminalizada).*

Adicionalmente, los 48 casos documentados en las noticias muestran una variedad de desencadenantes del proceso penal. Si bien la denuncia anónima es la más frecuente, con 21 casos, le siguen las denuncias realizadas por proveedores de salud (6), personal de instituciones públicas (6) y las intervenciones en operativos policiales o de la fiscalía (6). También, se identifican denuncias públicas, iniciadas por familiares y por personal de instituciones privadas como colegios, centros comerciales y supermercados.

Es relevante destacar que la mayoría de las denuncias reportadas se refieren al delito de "autoaborto". Tanto los datos provenientes de solicitudes de información de acceso público, los expedientes y la información cualitativa obtenida a través de entrevistas revelan la prevalencia de este tipo de delito.

6.2.2. Intervención policial: operativos a consultorios

"Se llevan a cabo operativos, sí. Tenemos asignada una partida que incluye el pago de informantes y confidentes. Actualmente, el enfoque ya no se centra en el conocimiento de que un médico realiza abortos. Ahora, el pago de informantes se dirige a la realización de una inteligencia previa, preparación de actos previos, incluyendo filmaciones. ¿Con qué propósito? Demostrar que en determinados lugares se llevan a cabo actividades ilícitas y poder informar al Ministerio Público para llevar a cabo operativos en conjunto"
(Funcionario de la PNP)

En el 8% de las 100 sentencias, el proceso penal inició a partir de intervenciones policiales (ver Figura 6.2). Esta práctica se corroboró en la entrevista a un agente policial, quien mencionó que una de las estrategias utilizadas para perseguir el delito de aborto eran los operativos policiales.

Según el testimonio de un funcionario de la policía especializado en la investigación de delitos asociados al aborto, las intervenciones policiales para perseguir penalmente el delito de aborto en el Perú han experimentado cambios en su modalidad a lo largo del tiempo. Antes de la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en Lima, la policía adoptaba otras estrategias como intentar inducir al delito. Por ejemplo, coordinaba encuentros a través de anuncios de "atraso menstrual" y luego intervenía a las personas que llevaban consigo "pastillas abortivas".

Sin embargo, según refieren, con la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, tienen mayores límites para inducir a la comisión del delito. Por ello, se destaca la necesidad de coordinar operativos conjuntos con el Ministerio Público para recopilar pruebas, como filmaciones y videos, y así revestir de legalidad las acciones policiales. Para ello, se puede realizar pago de informantes y confidentes, así como la realización de labores de inteligencia previa.

"El aborto en Perú ha cambiado en modalidad, las pastillas es el boom (...). Antes del nuevo Código Procesal Penal, si observábamos a alguien viendo un anuncio de atraso menstrual, como policía, solíamos llamar y concertar un encuentro en una plaza. La persona llegaba con la pastilla, y nosotros interveníamos. No obstante, esta práctica ya no es posible. No podemos inducir al delito"
(Funcionario de la PNP).

De la revisión de los expedientes es posible advertir que la intervención de la PNP carece de garantías del debido proceso. Tal es el caso de Ina, una mujer con discapacidad auditiva, quien fue intervenida en compañía de su hijo de 15 años luego de salir de un consultorio privado y a quien no se le garantizaron ajustes razonables. El adolescente fue conminado a incriminar a su madre, aun cuando el

artículo 7.2 del Código de Responsabilidad Juvenil de Adolescentes señala que ningún adolescente puede ser obligado o inducido a declarar o reconocer un delito contra sí mismo o contra miembros de su grupo familiar. Ina fue condenada con la declaración de su hijo, considerada como una de las pruebas fundamentales de la comisión del delito.

6.2.3. Ministerio Público: La fiscalía también inicia procesos

"Ella venía de su pueblo aquí a la capital. En ese trayecto sintió fuertes dolores y terminó en el hospital, pero previo a eso ya la fiscalía le había tomado su declaración por el proceso de violación sexual. En esas declaraciones ella había dicho que no quería continuar ese embarazo. Fue por eso que le iniciaron un proceso en su contra (...). Ella dijo que no quería tenerlo, que quería matarse, porque la estigmatización es fuerte" (Martha, abogada defensora).

El Ministerio Público inicia el proceso penal en el 3% de los casos de sentencias y expedientes (ver Figura 6.1.). Sin embargo, las entrevistas revelaron situaciones en las que la fiscalía adoptó posturas amenazantes, intimidatorias e incluso hostiles hacia las MPG, ignorando las complejidades individuales inherentes a cada caso.

Adicionalmente, se han documentado instancias en las que las denuncias por autoaborto fueron promovidas por fiscales encargados de investigar casos de violencia física o sexual. Esta circunstancia, sumada a las presiones ejercidas por el Estado y a la constante vigilancia policial, refleja una arraigada cultura de sanción. Así, en lugar de salvaguardar los derechos y la salud de las MPG, esta cultura contribuye a la creación de un entorno hostil que afecta adversamente varios aspectos de la vida de las personas involucradas.

Un testimonio que ilustra esta situación es el de Laura, familiar de Camila[70], la niña de Apurímac que demandó al Estado peruano ante el Comité de Derechos del Niño por negarle el acceso a un aborto terapéutico, pese a que el embarazo fue resultado de los reiterados abusos sexuales cometidos por su padre. Además, Camila fue procesada y sancionada por el delito de autoaborto después de sufrir un aborto espontáneo.

La denuncia provino de la misma fiscal que estaba investigando el caso de violencia sexual en el que Camila era la agraviada. En lugar de brindarle protección, la fiscal acusó a la joven de autoaborto y, en un tono amenazante, advirtió a Camila y a su madre: "Si se atreven a hacer algo contra el bebé, las vamos a enjuiciar". Laura relató que recibieron varias amenazas en ese sentido, indicándoles que no podían interrumpir el embarazo, a pesar de las reiteradas solicitudes de la familia para acceder a un aborto terapéutico.

70. Ver: Comité de los Derechos del Niño. (2023). Dictamen aprobado por el Comité en relación con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, respecto de la comunicación núm. 136/2021: Falta de acceso al aborto terapéutico de niña víctima de violencia sexual por parte del padre. Naciones Unidas. Disponible en: https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/bitstream/123456789/4332/1/Camila%20v.%20Per%c3%ba.pdf

Otro caso ilustrativo es el de Martha, una abogada que asumió la defensa de una adolescente criminalizada por aborto. Ella narró la experiencia de la adolescente que, tras ser víctima de violación, viajó desde su pueblo a la capital. Dentro de las declaraciones brindadas en el proceso de violación, la adolescente expresó su deseo de no continuar con el embarazo. Dicha declaración, sumada al aborto espontáneo que experimentó, desencadenó un proceso en su contra.

6.3. ¿Cómo se conducen los procesos penales iniciados por los delitos de aborto?

Calificación (oficial) penal de los hechos

Como se indicó en la sección de "Metodología", en vista del silencio de las entidades estatales ante la primera solicitud de acceso a la información pública, nuestra segunda petición se limitó al requerimiento de sentencias vinculadas al artículo 114 del Código Penal peruano (autoaborto). Por ello, el universo de 100 sentencias analizadas corresponde al delito de autoaborto. Sólo en uno de los casos, la calificación penal inicial fue la, de aborto sentimental.

Tabla 6.1. Sentencias según tipo penal utilizado para procesar a la MPG

Artículo del Código Penal	Casos
Artículo 114 (autoaborto)	99
Artículo 120 (aborto sentimental)	1

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

En este punto es importante mencionar que en varios casos la determinación del tipo penal (autoaborto) por los operadores de justicia no correspondía con los hechos del caso. Y es que, en varios de ellos, o no se cumplía con todos los elementos del delito imputado o se ignoraron elementos fácticos -como las motivaciones- que ameritaban un análisis distinto. En otras palabras, nos encontramos frente a procesos judiciales arbitrarios. También vale la pena resaltar que el caso de "aborto sentimental" fue inicialmente procesado bajo el delito de autoaborto[71]. Sin embargo, gracias a una defensa técnica eficiente con perspectiva de género e interseccional, se logró la recalificación de los hechos.

Recalificación de los hechos y el tipo penal pertinente

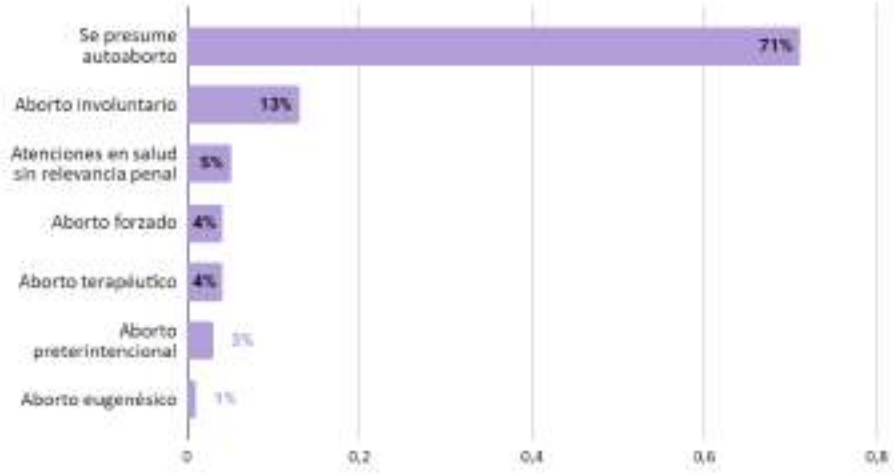
Retomando la problemática anticipada en el párrafo previo, en 80 sentencias pudimos analizar los hechos del caso y evaluar si el tipo penal atribuido era el adecuado. Debido a la insuficiente -e incluso ausente- descripción del marco fáctico en las 20 sentencias restantes, dicho análisis no pudo ser replicado.

A partir de este análisis, concluimos que en el 71% de las sentencias había indicios que sugerían la posibilidad de un autoaborto (57 casos). Sin embargo, dado que nuestra única fuente fueron las

71. El delito de autoaborto establece una pena mayor al estipulado en el artículo 120 para el delito de aborto por violación sexual.

decisiones judiciales, no podemos afirmar con certeza que la mujer procesada haya interrumpido su embarazo de manera intencional, ya que es posible que la sentencia no incluyera otros elementos que indiquen lo contrario.

Figura 6.3. Sentencias según (re)calificación de los hechos



Nota: El total es de 80 casos pues en los restantes no se indica este dato en el expediente.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

Sin duda, son las 23 sentencias restantes las que más llaman la atención tras identificarse elementos fácticos que los alejan del tipo penal de autoaborto. Por un lado, concluimos que **10 casos correspondían a abortos involuntarios** debido a la ausencia de elementos claves para la configuración del tipo penal de autoaborto (como conocimiento de su embarazo o voluntad de abortar). En efecto, la mayoría de MPG investigadas desconocía estar embarazada. Otras dos -quienes conocían de su estado de embarazo- tuvieron un aborto espontáneo. A pesar de ello, a todas se les persiguió penalmente.

Por otro lado, **cuatro casos correspondían a hechos de "atención en salud sin relevancia penal"**, los que entendemos como eventos de atención en salud reproductiva que no revisten algún carácter delictivo. A continuación, ilustramos los casos. En dos sentencias las MPG procesadas fueron sometidas a intervenciones médicas en EE.SS. públicos tras haber sido alertadas de que el feto no presentaba signos vitales. Además de conocer su estado de embarazo, ambas querían ser madres. Pese a ello, las dos fueron perseguidas penalmente y una fue declarada culpable. En otro caso, la MPG procesada nunca estuvo embarazada. Sin embargo, tras llegar al EE.SS. público con una hemorragia se presumió su culpabilidad e inició un proceso penal. Mientras que, en el último, la MPG investigada acudió de emergencia a un EE.SS. público luego de que le realizaran un aborto en un centro médico, donde le advirtieron que el feto no tenía signos vitales.

En los nueve casos restantes identificamos elementos propios de un aborto forzado (3 casos), terapéutico (3 casos), preterintencional (2 casos) y eugenésico (1 caso). De todos estos, los abortos terapéuticos son los que causan mayor consternación al encontrarse decriminalizados. En estos tres

casos las MPG investigadas afirmaron haberse sometido a un aborto porque el embarazo ponía en riesgo su salud y/o vida. Esta información, sin embargo, no fue considerada por los jueces/zas. Dos de los tres terminaron con una condena. En cuanto a los casos preterintencionales, cabe destacar que los abortos experimentados fueron producto de las agresiones que sufrieron las MPG por un tercero y su pareja.

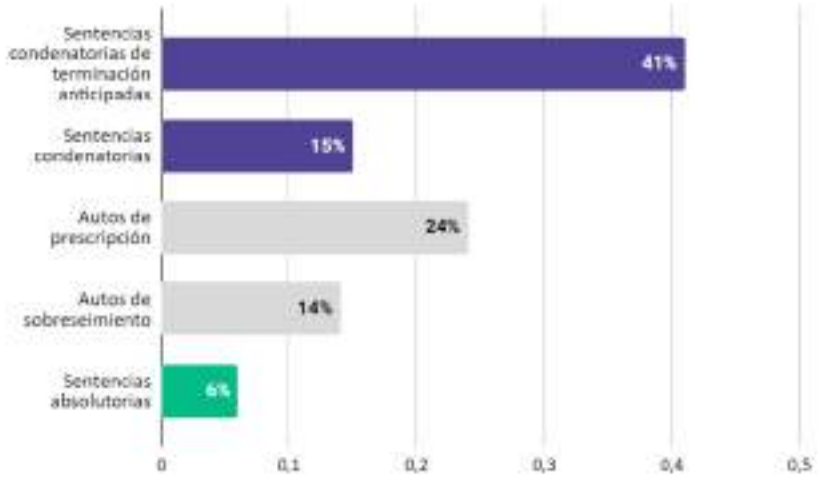
A partir de lo anterior, concluimos que en 22 casos los operadores de justicia debieron abstenerse de iniciar un proceso penal al no existir los elementos del tipo penal de autoaborto o al identificarse elementos que advertirían que el aborto fue producto de hechos de violencia, sin el consentimiento de la MPG procesada o se realizó por razones terapéuticas. En el caso restante, el tipo penal adecuado era el "eugenésico" en tanto el aborto se realizó en vista de que el feto presentaba malformaciones incompatibles con la vida.

Tipo de decisión final

En el 56% de los procesos penales por aborto se declaró la culpabilidad de la MPG procesada (ver Figura 6.4). De estas 56 sentencias, sin embargo, 41 resultaron de "acuerdos de terminación anticipada", una figura jurídica regulada entre los artículos 468 y 471 del Nuevo Código Procesal Penal. En concreto, este tipo de acuerdo permite a la MPG procesada negociar la pena o la reparación civil, entre otros factores, siempre que reconozca su culpabilidad. Para acceder a la terminación anticipada, sin embargo, se deben cumplir con una serie de reglas. Dentro de ellas, se espera que la persona procesada renuncie a la discusión probatoria y que el juez explique los alcances y consecuencias del acuerdo, así como ejerza un control de legalidad y de razonabilidad de la pena.

En posteriores secciones se profundizará sobre el agente que propone este tipo de acuerdo, las vulneraciones a las garantías procesales y se verificará si los jueces ejercen o no un control de legalidad de este tipo de acuerdos.

Figura 6.4. Sentencias según tipo de decisión final



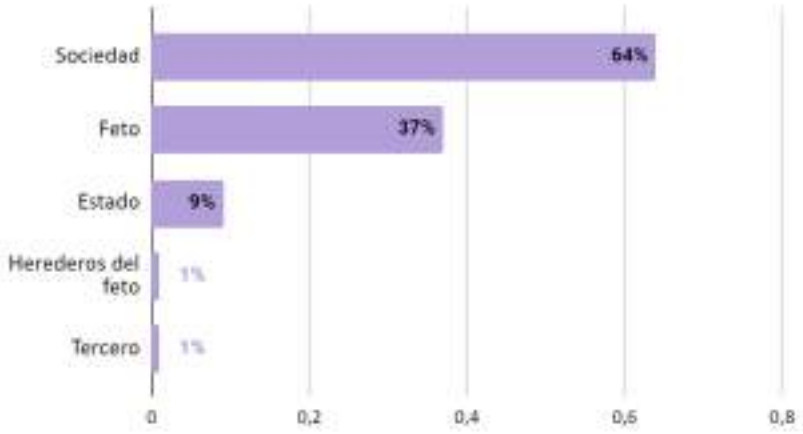
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

Por otro lado, en 38 casos se puso fin al proceso penal mediante autos de prescripción (24 casos) o de sobreseimiento (14 casos). Es decir, por cuestiones procesales. Por un lado, la prescripción se declara cuando el proceso penal supera el plazo razonable para ser juzgado (en este caso, un máximo de 3 años cuando la procesada tiene 21 años o más al momento de los hechos o un máximo de 2 años cuando tiene menos de 21 años). Mientras que el sobreseimiento aplica cuando el hecho no es atribuible a la MPG procesada porque el hecho no se realizó, no existen elementos de convicción suficientes, entre otras causas. En otras palabras, a 14 MPG se les inició un proceso penal -con las consecuencias que ello conlleva a nivel social y legal- sin existir fundamentos convincentes para activar la maquinaria judicial. Por último, sólo en seis sentencias se ratificó la inocencia de la MPG procesada.

Tipo de agraviado

En todas las sentencias analizadas se identificó a, por lo menos, una parte "agraviada" por el delito de aborto. Como se observa de la Figura 6.5, la "Sociedad" fue reconocida como el principal agente perjudicado por el caso de aborto investigado (64 casos), seguido del "Feto" (37 casos) y el "Estado" (9 casos). Sólo en dos casos se consideró que el aborto había perjudicado a los "Herederos del feto" (1 caso) y a una tercera persona (1 caso).

Figura 6.5. Sentencias según tipo agraviado



Nota: El total suma más de 100 pues en varios casos se utilizó más de un método

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

Aunque las decisiones no profundizan sobre las razones para considerar a la "Sociedad" como el agente agraviado por el delito de aborto, en un caso se representó al aborto como "un accionar que la sociedad reprocha".

Grado de tentativa del aborto

En 6 sentencias se indicó que el delito de aborto se realizó en grado de tentativa. Es decir, que las MPG procesadas habrían tomado acciones para provocarse un aborto, pero éste no se produjo. Al observar con mayor detalle estos 6 casos se advierte que en 4 de ellos el proceso penal inició en el marco de una intervención policial, donde encontraron a la MPG procesada en las instalaciones del centro médico allanado.

Tabla 6.2. Sentencias según grado de tentativa del aborto

Sentencias calificadas por autoaborto en grado de tentativa	Casos
Sí	6
No	67
No indica/No aplica	27

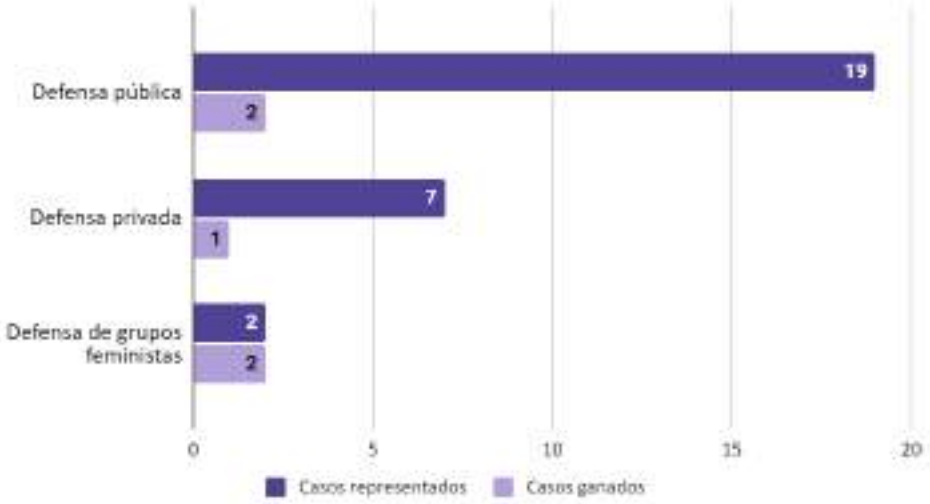
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

En una de las sentencias el grado de tentativa no fue considerado en el análisis de la decisión y, como consecuencia, la MPG fue condenada por el delito de autoaborto en grado consumado. Ello no sólo demuestra la incorrecta y sesgada aplicación del derecho por los operadores de justicia en los procesos penales por el delito de aborto, sino además la deficiente defensa con la que cuentan las MPG procesadas.

Intervención de grupos feministas y anti-derechos

Uno de los objetivos del estudio es identificar si, en algún punto de los procesos penales por aborto, participaron grupos feministas o anti-derechos. En ninguna de las 100 sentencias identificamos algún tipo de participación de grupos anti-derechos, sea a través de la presentación de *amicus curiæ* o alertando a las autoridades por un caso de aborto.

Figura 6.6. Sentencias según tipo de defensa y éxito del caso



Nota: El total es de 28 casos pues en los restantes no se indica este dato en la sentencia.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

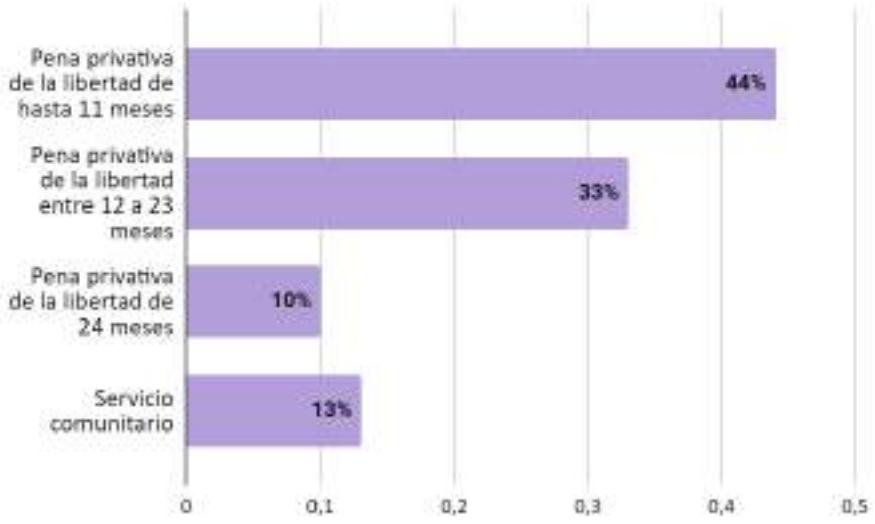
En el caso de los grupos feministas, su intervención se limitó a la defensa legal en dos casos, los cuales además resultaron en decisiones que ratificaron la inocencia de las MPG procesadas. La Figura 6.6 muestra, además, el éxito del caso dependiendo del tipo de defensa, demostrando la deficiente representación tanto de la defensa pública como de la privada. Pero, sobre todo, se evidencia también el impacto positivo de una defensa especializada y comprometida con los derechos de las MPG procesadas.

Rol del Ministerio Público: la pena solicitada

La lectura de las sentencias también nos permitió advertir que el Ministerio Público tuvo un rol activo en los procesos penales impulsados por el delito de aborto. Llegando, incluso, a solicitar penas y reparaciones civiles mayores a las finalmente impuestas por el Poder Judicial.

En 39 de las 100 sentencias se pudo identificar cuál fue la pena solicitada por el Ministerio Público, la cual incluye tanto penas privativas de la libertad como la prestación de un servicio comunitario. Como se observa en la Figura 6.7, en la mayoría de los casos, el Ministerio Público solicitó penas que alcanzaban hasta los 11 meses de prisión (17 casos), seguido de penas entre los 12 y 23 meses (13 casos). Sólo en 4 casos solicitó una pena de dos años. Al respecto, es importante anotar que en 7 de los 34 casos se precisó si la ejecución de la pena debía ejecutarse de forma efectiva o suspendida. En 3 de ellas el Ministerio Público solicitó prisión efectiva para la MPG procesada.

Figura 6.7. Sentencias según pena solicitada por el Ministerio Público



Nota: El total es de 39 casos pues en los restantes no se indica este dato en la sentencia.

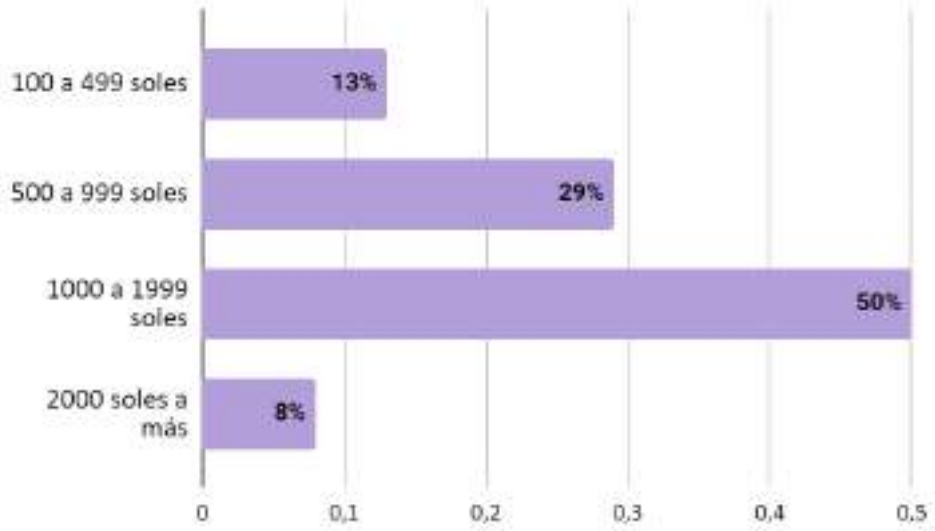
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

En cuanto a la solicitud de servicio comunitario, ésta fue requerida en 5 casos y comprendía desde las 35 hasta las 60 jornadas de trabajo. Cuatro de estas decisiones iban también acompañadas de reparaciones civiles que ascienden a S/. 100 (27 dólares), S/. 200 (53 dólares) y S/. 1000 soles (267 dólares).

Rol del Ministerio Público: la reparación civil solicitada

En 38 de los 100 casos se registró el monto de la reparación civil solicitada por el Ministerio Público. Como se observa en la Figura 6.8, en alrededor del 60% (22 casos) de estos casos los montos requeridos superaron los S/. 1000 soles (267 dólares), valores que superan ampliamente el sueldo mínimo vital. Por otro lado, en casi la tercera parte de los casos la reparación solicitada fluctuó entre los S/. 500 (133 dólares) y S/. 999 soles (267 dólares). Mientras que sólo en 5 casos se solicitó una reparación civil entre los S/. 100 (27 dólares) y S/. 499 soles (133 dólares), cuyo monto máximo bordea la mitad del salario mínimo mensual.

Figura 6.8. Sentencias según la reparación civil solicitada por el Ministerio Público



Nota: El total es de 39 casos pues en los restantes no se indica este dato en la sentencia.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

De alguna forma, los montos solicitados por el Ministerio Público parecen responder a una consciente omisión -mezclada con insensibilidad- de las condiciones económicas de las MPG procesadas al solicitar reparaciones civiles que claramente superan sus ingresos mensuales. Pero, además, dan la impresión de ser funcionales a la imposición de castigos moralizadores. En uno de los 38 casos, la procesada era una madre y vendedora ambulante, cuyos ingresos mensuales no superaban los S/. 500 soles (133 dólares). A pesar de que en su testimonio afirmó no haber tenido la certeza de estar embarazada, la fiscalía solicitó el pago de S/. 2500 soles (667 dólares) como reparación civil sin pre-

sentar algún fundamento que lo respalde. Considerando su estado de inseguridad económica, este monto la obligaría a asumir una deuda y/o redireccionar gastos, logrando así perjudicar sus finanzas.

Agente que propone la terminación anticipada

En 38 de las 100 sentencias se pudo identificar cuál de las partes propuso el acuerdo de terminación anticipada. Es decir, aquella figura jurídica que permite negociar tanto la pena como la reparación civil siempre que se reconozca la culpabilidad. En la mayoría de ellos, el acuerdo de terminación anticipada fue planteado por la defensa de la MPG investigada (22 casos). Mientras que en 16 fue promovido por el Ministerio Público.

Figura 6.9. Sentencias según parte que propone la terminación anticipada

Nota: El total es de 38 casos pues en los restantes no se indica este dato en el expediente.

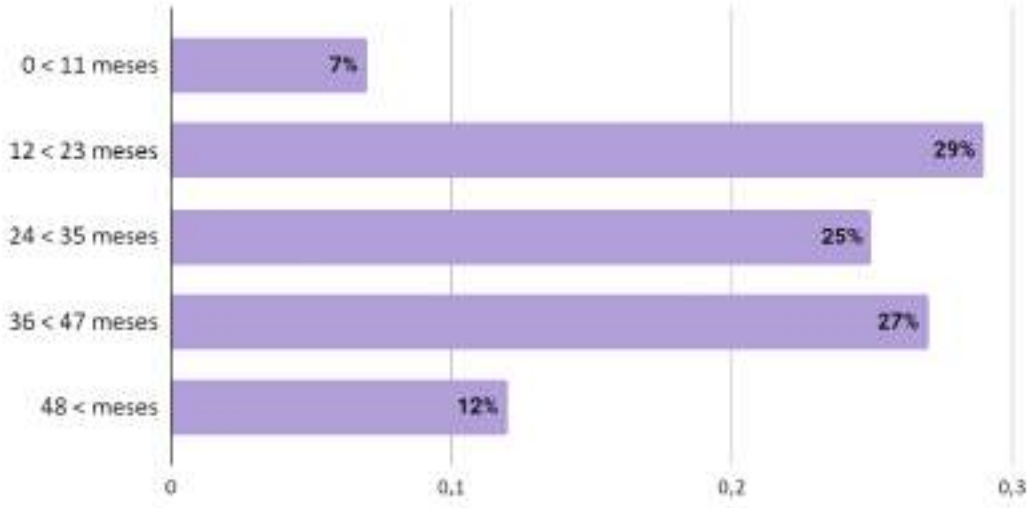
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

Tras leer los hechos de estas 38 sentencias pudimos concluir que la principal prueba utilizada para solicitar la terminación anticipada del proceso penal fue la autoincriminación de la MPG obtenida en el EE.SS. sin presencia de su representante legal, una actuación claramente violatoria a las garantías procesales. En efecto, no existían mayores pruebas objetivas que permitieran afirmar la comisión del delito. Lo cual da cuenta de la deficiente defensa con la que contaron. Por otro lado, ni las decisiones ni las transcripciones de las audiencias celebradas nos permiten afirmar que la MPG procesadas hayan sido informadas de los alcances ni implicancias del acuerdo. Tampoco se advierte un efectivo control de legalidad del acuerdo por parte del juez/jueza del caso, quien -en pocas palabras- convalidó las vulneraciones al derecho al debido proceso de las MPG procesadas. Ello, a pesar de que su rol, conforme lo establece la ley, es establecer mecanismos de control a fin de evitar la violación al debido proceso.

Duración de los procesos penales

En 84 de las 100 decisiones se pudo identificar la cantidad de meses que duró el proceso penal. Como se observa en la Figura 6.10, alrededor del 60% de los casos duraron entre 1 y 3 años (45 casos). Sin embargo, llama poderosamente la atención que 39% (33 casos) de los procesos penales hayan superado los 3 años, el cual sobrepasa el plazo prescriptorio del delito de autoaborto. Ello no sólo demuestra el ineficiente control prescriptorio de la justicia en los casos de aborto, sino también la deficiente defensa de las MPG procesadas. Además, la data muestra la excepcionalidad de que un proceso penal dure menos de 1 año.

Figura 6.10. Sentencias según duración del proceso penal



Nota: El total es de 84 casos pues en los restantes no se indica este dato en la sentencia.

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

También se pudo conocer que, en promedio, el proceso penal por el delito de autoaborto tiene una duración aproximada de 32 meses. Es decir, una MPG suele experimentar por 2 años y medio todas las implicancias a nivel legal, social, económico, educativo y de salud que un proceso penal conlleva.

Tipos de condenas impuestas por el Poder Judicial

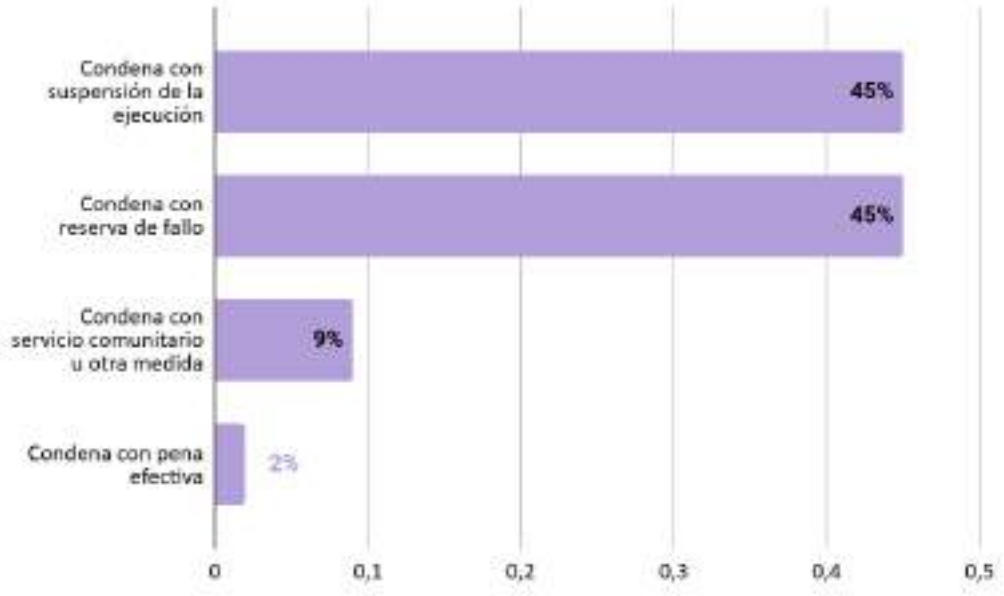
De las 100 sentencias, 56 terminaron con una condena. De dicho total, las penas se dividen en los siguientes tipos: pena efectiva, reserva del fallo condenatorio, condena con suspensión de la ejecución de la pena y condena con servicio comunitario, siendo las tres últimas modalidades alternativas a la pena privativa de la libertad.

La Figura 6.11 muestra que en un caso se condenó con pena efectiva, la cual fue convertida a días multa (a S/. 515 soles o 137 dólares). Es decir, no hubo una pena privativa de la libertad. En los res-

tantes se impusieron penas alternativas, las cuales incluyeron 25 condenas con reserva de fallo[72], 25 condenas con suspensión de la ejecución de la pena y en 5 se ordenó realizar servicio comunitario.

En este punto, cabe destacar que, tanto en la reserva de fallo como en la suspensión de la ejecución, se establecen reglas de conducta por un plazo determinado, las cuales deben ser cumplidas. En caso de incumplimiento, la pena varía, en general, de suspensión o reserva de fallo a privación de libertad. Sin embargo, a diferencia de la segunda, la reserva de fallo no se inscribe en el Registro Nacional de Condenas[73]; sino en un Registro Especial a cargo del Poder Judicial. Este registro sólo proporcionará información a pedido escrito de jueces con fines de verificación de reglas de conducta o de comisión de un nuevo delito, no generando antecedentes penales.

Figura 6.11. Sentencias según tipo de condena impuesta por Poder Judicial



Nota: El total es de 57 casos pues en el caso de la "condena con pena efectiva" los meses de prisión efectiva se convirtieron en días-multa y, como medida complementaria, se impuso a la MPG que asistiera a "terapia psicológica".

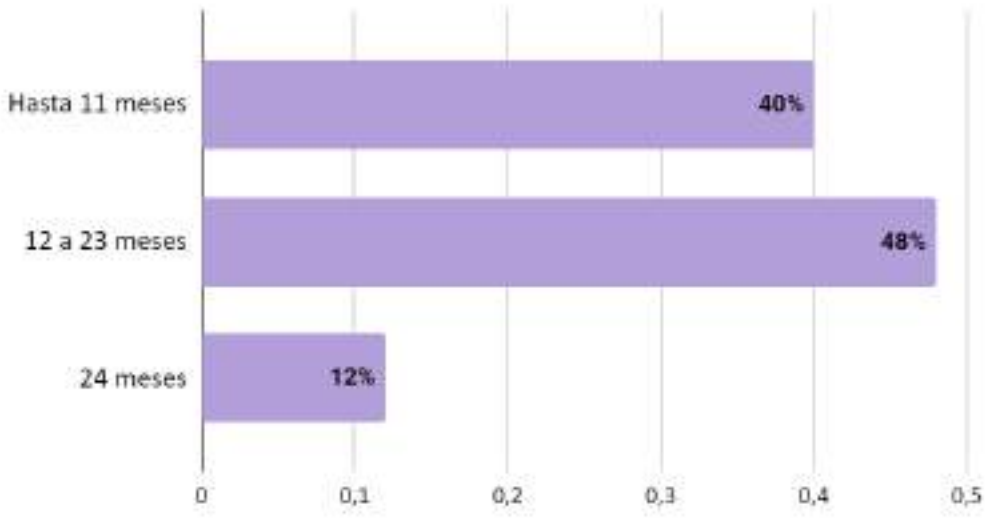
Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

Meses de pena impuesta (en condena con pena suspendida y efectiva) por el Poder Judicial

En las **25 condenas con ejecución suspendida de la pena** se pudo conocer la cantidad de meses de la pena impuesta. Como se observa en la Figura 6.12, en más del 80% de casos se impuso a las MPG procesadas penas de hasta los 23 meses (22 casos); mientras que en tres alcanzaron los 24 meses.

72. La reserva de fallo es una medida de uso facultativo para el/la juez/a que se caracteriza por declarar la culpabilidad de la MPG procesada, pero sin establecer la pena.
73. De acuerdo con el artículo 63 del Código Procesal Penal, esta modalidad se inscribe en un registro especial del Poder Judicial.

Figura 6.12. Sentencias según cantidad de meses de pena suspendida impuesta por Poder Judicial



Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

En cuanto a la **sentencia con pena efectiva**, se convirtieron los 6 meses de pena efectiva en 206 días-multa equivalente a S/. 515 soles. De acuerdo con la jueza de dicho caso, dicha conversión se realizó en vista de la "corta duración" de la pena impuesta a la MPG procesada.

Servicios comunitarios y otras medidas impuestas por el Poder Judicial

En 5 sentencias se dictó servicio comunitario como pena, la cual abarcó desde las 36 hasta las 60 jornadas. En una sentencia, la jueza determinó que la MPG procesada debía asistir a un tratamiento psicológico.

Tabla 6.3. Sentencias según jornadas de servicio comunitario u otra medida impuesta

Número de jornadas/ otro medida	Frecuencia	%
Hasta 41 jornadas	1	17%
42 jornadas a 51 jornadas	2	33%
52 jornadas a 61 jornadas	2	33%
Tratamiento psicológico	1	179%
Total	6	100%

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

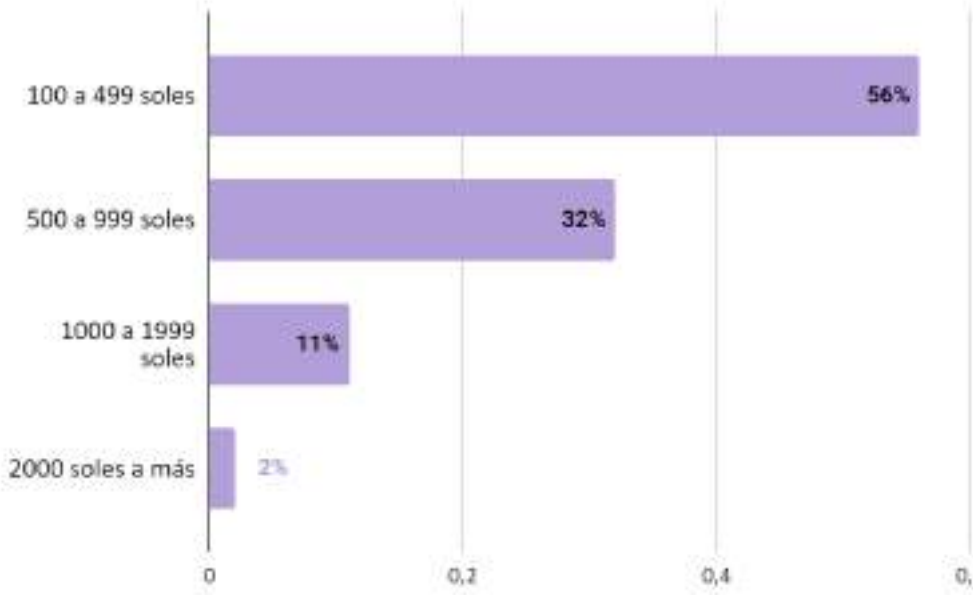
Reparación civil impuesta por el Poder Judicial

En 57 sentencias, el Poder Judicial impuso una reparación civil a la MPG procesada por el (supuesto) daño ocasionado producto de la interrupción del embarazo. Curiosamente, estas 57 sentencias no sólo abarcan las 56 condenas, sino también a 1 auto de sobreseimiento.

La **Figura 6.13** evidencia que en **más de la mitad de los casos (56%, equivalente a 32 casos)**, la reparación civil impuesta osciló entre **S/. 100 (27 dólares) y S/. 499 (133 dólares)**. En un **32% de los casos** (18 casos), el monto de la reparación estuvo en el rango de **S/. 500 (133 dólares) a S/. 999 (266 dólares)**. Por otro lado, en un **11% de los casos** (6 casos), la reparación civil se fijó entre **S/. 1,000 (266 dólares) y S/. 1,999 (533 dólares)**. Finalmente, en un único caso (**2%**), el monto impuesto alcanzó los **S/. 2,000 (533 dólares)**.

Estos datos reflejan la variabilidad en las sanciones económicas impuestas, con la mayoría de las reparaciones civiles ubicándose en montos que podrían ser valorados como relativamente bajos, pero, en relación a los ingresos de las mujeres, representan una carga económica significativa para las mujeres procesadas.

Figura 6.13. Sentencias según monto de la reparación civil impuesta por Poder Judicial



Nota: El total es de 57 casos pues en una sentencia de sobreseimiento se impuso una reparación civil

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

Los montos por reparación civil impuestos son notoriamente dispares. Y es que en el Perú no existen parámetros para definir el valor monetario del supuesto daño ocasionado por un aborto. Por el contrario, el monto finalmente impuesto obedece a las consideraciones personales del juez o jueza a cargo, convirtiéndose así en un acto arbitrario. Precisamente, advertimos que, en casos sustancialmente análogos, las reparaciones civiles difieren considerablemente. De hecho, en ninguna de las 57 decisiones analizadas el Poder Judicial motivó su decisión.

Por otro lado, resulta inevitable notar que en siete casos los montos impuestos sobrepasaron exageradamente al sueldo mínimo mensual. Tampoco es un dato menor que, en la mayoría de los casos, el Poder Judicial dispuso que la reparación civil sea pagada en cuotas, demostrando ser consciente de las restricciones económicas de la MPG procesada. Un factor que, sin embargo, no les limitó a imponer montos exorbitantes. Con ello, las reparaciones civiles en los casos de aborto parecen ser utilizadas para castigar -a través de la sanción económica- a aquellas MPG que, por diferentes razones, no cumplen con el rol socialmente impuesto de ser madres.

Periodo de prueba y reglas de conducta impuestas (reservas de fallo y condenas con pena suspendida)

En el marco de las sentencias con **reserva de fallo condenatorio y suspensión de la ejecución de la pena**, el Código Penal peruano dispone la imposición de un **periodo de prueba**, durante el cual la persona procesada debe cumplir una serie de **reglas de conducta** como condición para mantener el beneficio otorgado. No obstante, el análisis de **50 sentencias** revela que estas medidas, lejos de constituir herramientas orientadas a la reinserción social, reproducen de forma preocupante **lógicas punitivas moralizantes y estereotipadas.**

En **el 82% de los casos analizados (41 sentencias)** se impuso un periodo de prueba de entre **12 y 23 meses**, siendo el más frecuente el de **12 meses** (presente en el 78% de los casos). Esta práctica evidencia una tendencia sistemática del Poder Judicial a imponer **regímenes prolongados de supervisión y control,** incluso en contextos donde la conducta imputada no representaba una amenaza para terceros ni mostraba elementos de peligrosidad.

Más grave aún es que en **el 32% de los casos (16 sentencias)** se detectaron **reglas de conducta profundamente influenciadas por estereotipos de género,** tales como:"no frecuentar personas ni lugares de dudosa reputación", "no ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias estupefacientes", "observar buena conducta" y "someterse a una evaluación y/o tratamiento psicológico".

Figura 6.14. Sentencias según periodo de prueba impuesta por Poder Judicial

Fuente: Elaboración propia en base a la revisión de sentencias y expedientes provistos por el Poder Judicial.

Estas medidas no solo carecieron de **motivación específica,** tal como exige el artículo 58 y el artículo 64 del Código Penal, sino que además reflejan una concepción normativa sobre cómo debe comportarse una mujer "moralmente aceptable". Se trata, en esencia, de una **instrumentalización del derecho penal con fines de control social,** en la que se sanciona no solo la conducta típica imputada, sino también formas de vida y elecciones personales que escapan a los modelos hegemónicos de feminidad.

Estas reglas, formuladas en términos amplios y vagos, son **susceptibles de interpretaciones arbitrarias**. ¿Qué constituye un lugar de "dudosa reputación"? ¿Qué se entiende por "buena conducta"? Al no establecer criterios objetivos y al no exigirse una justificación basada en las circunstancias particulares del caso, el juzgador adquiere una **discrecionalidad excesiva**, que permite imponer condiciones basadas en juicios morales y no en criterios jurídicos. Esto vulnera derechos fundamentales como el **libre desarrollo de la personalidad, el principio de legalidad y el principio de igualdad y no discriminación.**

El uso de reglas de conducta con sesgo de género no responde a un interés legítimo de prevención de reincidencia o protección social, sino a la intención de **reformar o corregir conductas consideradas inapropiadas desde una visión patriarcal del rol de las mujeres**. Esta práctica evidencia cómo el sistema de justicia, al aplicar penas alternativas, no se desentiende del castigo, sino que lo **desplaza hacia formas de control moral y simbólico**.

Finalmente, en **64% de las sentencias con reserva de fallo (16 de 25 casos)**, se establecieron expresamente las consecuencias del incumplimiento: en 14 casos, se fijaron penas privativas de libertad de entre **5 y 24 meses**, y en 4 casos se indicó que la pena sería **efectiva**. Esto confirma que, pese a tratarse de salidas alternativas, las condiciones impuestas operan como un **mecanismo de castigo condicionado**, donde el margen de actuación de las mujeres queda sometido a una vigilancia judicial teñida de sesgos y expectativas de género.

En síntesis, el periodo de prueba no solo implica una restricción de derechos, sino que **funciona como un dispositivo de control social y de género**, en el cual el Poder Judicial sanciona formas de vida consideradas "desviadas" respecto al ideal normativo de feminidad. Se impone, así, un castigo que no solo es legal, sino **moral y disciplinador**, que profundiza la criminalización de las mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad.

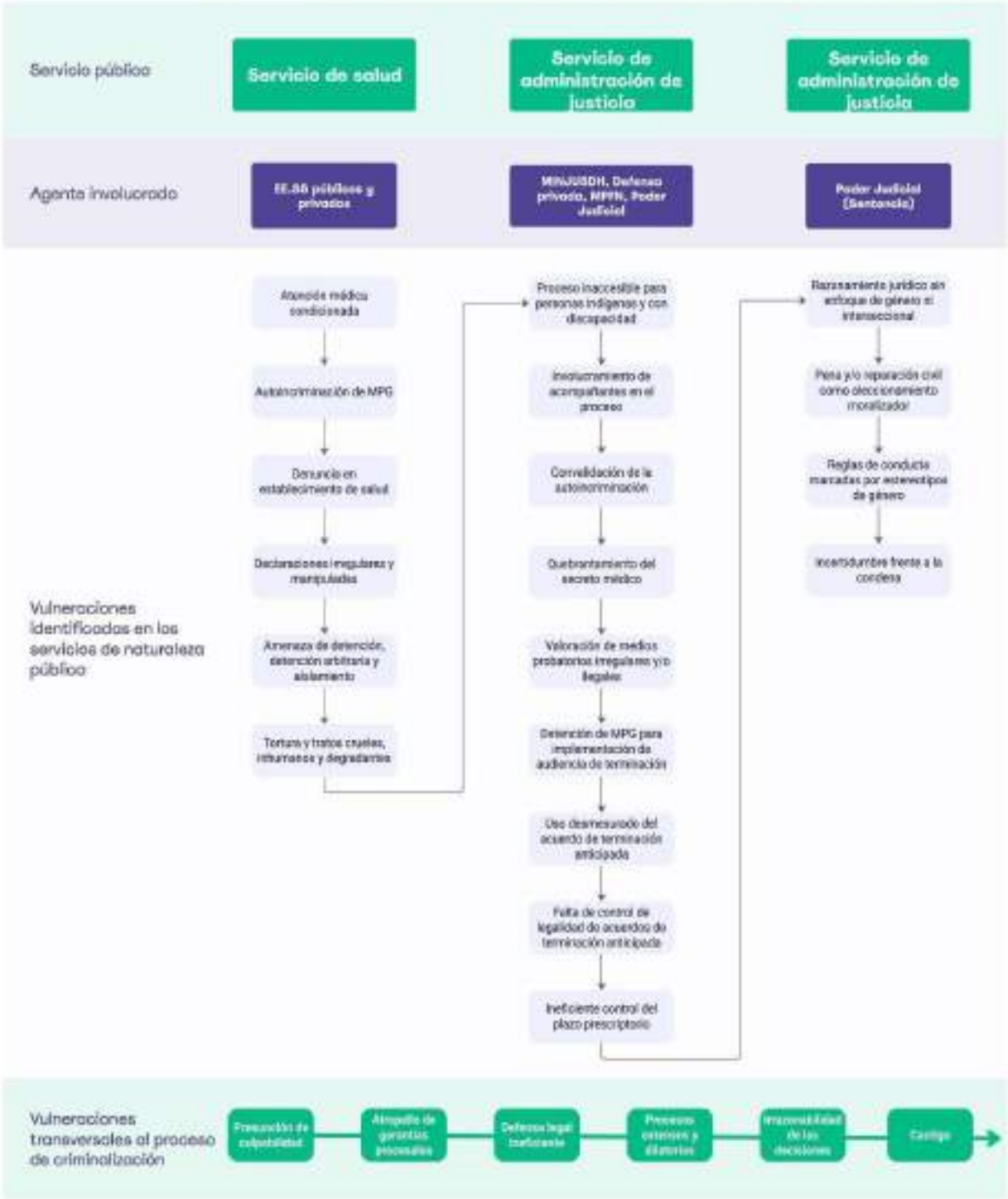
6.4. La ruta de la criminalización

A partir de los hallazgos, hemos elaborado una "Ruta de la criminalización" en el que se identifican tres grandes momentos. El primero, que ocurre en la provisión de servicios de salud y que es donde se originan, en su mayoría, las denuncias y en donde intervienen, principalmente, los prestadores de salud y la Policía Nacional del Perú. El segundo se vincula al proceso en sí mismo a cargo de los distintos operadores involucrados en la administración de justicia (la Defensa Pública, el MPFN, y el Poder Judicial). Finalmente, el tercer momento se centra en el resultado del proceso penal, e involucra al Poder Judicial principalmente.

En cada uno de estos momentos, y a cargo de los servicios de naturaleza pública, se han identificado vulneraciones a los derechos de las personas imputadas, según se muestra en la figura. Además, se identifican vulneraciones transversales a todo el proceso, como lo son la presunción de culpabilidad, el atropello de garantías procesales, la defensa legal ineficiente, los procesos extensos y dilatorios, la irracionabilidad de las decisiones y el ánimo de castigar socialmente a la persona.

RUTA DE LA CRIMINALIZACIÓN

Vulneraciones identificadas en el proceso de criminalización del aborto a mujeres y personas gestantes (MPG)



CAPÍTULO 7

¿Cuál es el impacto que los procesos penales tuvieron y tienen sobre las personas imputadas?

"El doctor me empezó a exigir que dijera qué me había puesto, qué me había metido, que no me iban a atender si es que yo no decía y ahí me lo dejaban (...) Después me llevaron a otro cuarto y las enfermeras (me increparon) pero ¿qué te has puesto? ¿Y cuántas? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro?".

"Que 'todas las mujeres querían tener hijos y tú matándolos, que no puede ser así, que Dios te ha bendecido y tú, ¿cómo puedes matar a un ángel tan chiquito?' Cosas así me empezaron a decir".

"Cada vez que llega un papeleo vuelvo a leer y sale todo y me vuelvo a sentir mal. Es volver a vivir la pesadilla. Como que los primeros papeles cuando llegaron la misma sensación. Todo. Me carga de recuerdos cada vez que sigo con esto".

"Antes era muy alegre, muy amigable, y ahora siento que no puedo ser así, me encierro, he perdido muchas amistades por eso. No vivo bien. Vivo muy deprimida. Muy deprimida todo el tiempo".

(Catherine, mujer criminalizada)

A partir del análisis de tres entrevistas a MPG (Sofía, Catherine y Marianella) que atravesaron y atraviesan procesos de criminalización del aborto, advertimos que este fenómeno tiene profundas consecuencias en la vida de las mujeres imputadas, impactando no solo su salud física y mental, sino también sus relaciones interpersonales y proyectos de vida. Este análisis examina el impacto emocional, el trauma, las secuelas a largo plazo y el aislamiento social que enfrentan las mujeres criminalizadas. A través de testimonios y relatos de mujeres afectadas, se evidencia cómo el proceso judicial y el estigma asociado al aborto exacerban su sufrimiento, dificultan su acceso a la atención médica y mental, y erosionan su capacidad para desarrollar y mantener relaciones sanas y alcanzar sus metas personales y profesionales.

7.1. Impacto emocional

"El proceso me ha afectado mucho. Me siento mal por Cathy, porque tiene recaídas, está triste, se siente juzgada, y ha tenido que buscar ayuda de una psicóloga y medicación. Pero siempre está la preocupación de qué va a pasar después".
(Pedro, familiar de persona criminalizada)

El proceso de criminalización del aborto genera un impacto emocional significativo en las personas involucradas, predominando el miedo. Esta emoción se manifiesta especialmente durante la estancia hospitalaria, la recepción de citaciones y la espera del proceso judicial. Entre personas criminalizadas, defensoras y familiares, el temor constante a la severidad de la condena y sus consecuencias es palpable. Los defensores también experimentan preocupación por su seguridad personal y la posibilidad de ser implicados como cómplices, aunque algunos perciben estas amenazas como menos plausibles.

La impotencia y la rabia son emociones comunes entre familiares y defensores, surgiendo de la frustración ante situaciones injustas y la incapacidad de ayudar a sus seres queridos o defendidos. Estas emociones reflejan la indignación y el malestar por las circunstancias adversas enfrentadas.

La culpa es otra emoción frecuente, intensificada por el estigma asociado al aborto y la criminalización. Las personas que abortan a menudo experimentan una profunda culpabilidad, exacerbada por la presión social y los mensajes condenatorios de su entorno. Además de miedo, rabia e impotencia, la tristeza es una emoción predominante entre las personas que han pasado por procesos de criminalización por aborto.

Esta tristeza está arraigada en la experiencia de haber tomado una decisión impuesta por las circunstancias y el entorno, y luego haber enfrentado la criminalización por ello. La persistente tristeza refleja el trauma de haber perdido una opción significativa y haber sido forzadas a enfrentar las consecuencias legales de esa decisión impuesta.

7.2. La criminalización como evento traumático

"Me sentía observada en todo momento, sentía paranoia siempre. Si veía un policía cerca de mi casa, pensaba, "él ha venido porque me está viendo". Si estaba con amigos en la calle y venía el serenazgo o la policía… yo solo pensaba "uy, ¿si me piden mis papeles? ¿Y si piden antecedentes? Yo estoy ahí, en un proceso y ¿qué me van a hacer?". Siempre sentía esa paranoia fuerte, la he sentido por mucho tiempo" (Sofía, mujer criminalizada)

El proceso de criminalización del aborto es un evento traumático para las personas involucradas. Tanto las criminalizadas como sus familiares y acompañantes describen este proceso como una sucesión de eventos dolorosos y violentos, especialmente en los centros de atención médica. Al buscar ayuda por complicaciones post aborto, enfrentan tratos humillantes, violencia física, castigos e incluso torturas antes de recibir atención médica. Estas situaciones intensas, junto con la presión de las autoridades para obtener confesiones, configuran un evento traumático.

El proceso judicial obliga a las personas imputadas a revivir el trauma, convirtiéndose en una experiencia revictimizante. Desde la recepción de citaciones hasta las declaraciones, el proceso judicial es un constante recordatorio de la violencia pasada. Esta revictimización aumenta la carga emocional y agrava los daños en su salud mental. La combinación de estrés y revictimización genera síntomas de ansiedad y depresión, insomnio, pesadillas, pensamientos rumiantes e hipervigilancia, afectando significativamente su calidad de vida.

Las entrevistadas reportan diagnósticos de depresión y trastorno de estrés post-traumático, problemas inexistentes antes del proceso de criminalización. Estos efectos también han provocado problemas de salud física como anemia. En adolescentes, la criminalización intensifica los impactos en la salud mental, generando sentimientos de desesperanza y conduciendo a la ideación

suicida. Muchas de las afectadas han iniciado tratamientos terapéuticos y de medicación, confirmando que la criminalización socava gravemente su salud mental, como también lo corroboran las recomendaciones de profesionales de salud durante los procesos judiciales.

7.3. Secuelas a largo plazo: proyecto de vida

"Aún sigo queriendo estudiar psicología, pero siento que necesitaré más tiempo. Lo que planeaba hacer el próximo año, ahora creo que necesitaré dos o tres años más porque no me siento preparada mentalmente. (...) Antes era muy alegre y amigable, pero ahora me encierro y he perdido muchas amistades. Mi relación de pareja también se ha afectado mucho. Nos hemos vuelto fríos y distantes. Siempre que surge el tema, me siento muy frustrada y enojada".
(Catherine, mujer criminalizada)

El proceso de criminalización del aborto tiene un impacto profundo en los proyectos de vida y la salud mental de las mujeres afectadas. La violencia y el trauma experimentados durante el proceso judicial erosionan su autoconfianza y percepción de control sobre su entorno. Esto les obliga a desviar sus recursos cognitivos y emocionales hacia la gestión de problemas nuevos y abrumadores, alejándose de sus metas y dificultando su desarrollo personal y profesional. Por ejemplo, los deseos de Catherine de estudiar una carrera y el desempeño laboral de otras mujeres se ven gravemente afectados, llevándolas a dedicarse solo a tareas inmediatas para solventar.

La criminalización no solo demanda una reorientación de recursos cognitivos, sino también económicos y sociales. Estos recursos, que deberían ser destinados a la búsqueda de justicia en situaciones donde han sido víctimas, como la violencia psicológica de parejas, se desvían hacia la defensa en casos de criminalización por aborto. Este desvío de recursos afecta especialmente a adolescentes en situaciones de violencia, intensificando su desesperanza y disminuyendo sus posibilidades de alcanzar sus metas personales.

Las relaciones interpersonales también sufren significativamente debido a los impactos en la salud mental y la estigmatización del aborto. Las mujeres afectadas experimentan distanciamiento de sus vínculos cercanos, lo que lleva al aislamiento y debilita sus redes de apoyo. En relaciones de pareja, la frustración por las circunstancias enfrentadas provoca conflictos y, en algunos casos, rupturas. Además, las dificultades para entablar nuevos vínculos románticos, especialmente con hombres, se vuelven más pronunciadas, reflejando un cambio notable en las dinámicas interpersonales.

7.4. Silenciamiento y aislamiento social

"Durante mucho tiempo y muchos meses literalmente la pasé sola. Me tragué mis palabras, las cosas que yo sentía. No podía hablar con nadie. Fue muy difícil" (Marianella, mujer criminalizada)

Frente al estigma existente hacia el aborto, las mujeres se ven forzadas a silenciar sus experiencias, soportando y ocultando el dolor y la violencia sufridos. La criminalización agrega un sufrimiento adicional a esta carga, intensificando el daño emocional y el impacto de este silenciamiento. En contextos donde el aborto es perseguido legalmente, las mujeres enfrentan la difícil decisión de buscar atención médica y arriesgarse a ser procesadas, o manejar las complicaciones por su cuenta, poniendo en riesgo su vida. Las activistas destacan los perjuicios generados por el estigma y la criminalización en la búsqueda de atención médica, así como los lamentables resultados para la salud.

La criminalización del aborto obstaculiza el acceso a la atención física y mental. En entornos terapéuticos, donde las personas deberían sentirse seguras, muchas mujeres evitan mencionar su experiencia de aborto por miedo al estigma y a las repercusiones legales. Esto es alarmante, considerando los múltiples problemas de salud mental provocados por la criminalización y la necesidad de atención adecuada. El silenciamiento y la criminalización también interfieren con el tratamiento adecuado, ya que los procedimientos de aborto y las preocupaciones legales pueden causar retrasos en el ciclo menstrual y en la administración de medicamentos psiquiátricos, complicando aún más la atención necesaria.

El estigma asociado con el proceso penal por aborto puede forzar a las mujeres a huir de sus lugares de origen para evitar la violencia y el hostigamiento. Además, durante el proceso judicial, las citaciones que llegan a los hogares de las mujeres imputadas revelan tanto el aborto como el proceso judicial, exponiéndolas innecesariamente al juicio de terceros e incluso a posibles reacciones violentas.

CAPÍTULO 8

¿Qué factores inciden en efectos más o menos graves para las personas imputadas?

A partir del análisis general de las entrevistas analizadas en esta investigación, así como de las sentencias y expedientes, se construye este capítulo en el que se tratará de identificar y analizar los factores que influyen en la gravedad de las consecuencias legales y sociales para las personas imputadas. Estos factores pueden ser protectores o agravantes, y su comprensión es esencial para abordar las desigualdades y mejorar el acceso a una justicia equitativa. Los factores protectores son aquellos que mitigan las consecuencias adversas de la criminalización y pueden facilitar un tratamiento judicial más favorable, mientras que los factores agravantes aumentan la severidad de las consecuencias legales y sociales.

8.1. Seguridad del procedimiento

Hay menos denuncias de hospitales porque ahora ya el que te vende o el que te compra, revisa en el internet, entonces no solamente te venden la Citotec o el misoprostol, sino también te venden todo el pack completo: para el dolor, para casos de infección. Entonces ya no necesitas ir al hospital.

(Alberto, funcionario DIRINCRI)

El nivel de seguridad y salubridad en la interrupción del embarazo es un factor determinante en el inicio de la criminalización del aborto en la experiencia de las personas gestantes. La forma en que se lleva a cabo el procedimiento puede actuar tanto como un factor protector o como agravante en

el proceso judicial. Por ejemplo, si el aborto se realiza en un entorno seguro y con la información adecuada sobre el uso de medicamentos y dosis, es probable que la MPG no necesite acudir a un establecimiento de salud por complicaciones. Dado que los centros de salud suelen ser el principal escenario donde se inician las investigaciones por emergencias obstétricas, como se mencionó previamente, una interrupción del embarazo realizada de manera segura reduce significativamente el riesgo de criminalización.

Como lo menciona **Alberto**, funcionario de DIRINCRI, si el aborto se realiza en condiciones precarias o sin las medidas de seguridad adecuadas, las MPG acudirán a un establecimiento de salud para solicitar atención médica, lo cual las expondrá a ser denunciadas.

8.2. Información y autonomía reproductiva

"Y con mi pareja empezamos a buscar en internet, ayuda, abogados, eso. Y dimos con una organización que brinda defensa legal para estos casos."
(Catherine, mujer criminalizada)

El nivel de acceso a información confiable y la autonomía reproductiva son factores determinantes que inciden en el resultado del proceso de criminalización del aborto en la experiencia de las personas gestantes. La falta de acceso a información precisa sobre los derechos reproductivos y las implicaciones legales del aborto puede llevar a consecuencias perjudiciales para las personas imputadas. Por ejemplo, se han identificado casos de personas que no conocían la situación legal de la interrupción del embarazo sino hasta que resultan investigadas, como en el caso de **Catherine, Sofía y Marianella**.

Es esencial que las personas gestantes tengan acceso a información precisa y confiable sobre sus derechos reproductivos. La educación en materia de salud reproductiva y los servicios de asesoramiento pueden ser herramientas fundamentales para empoderar a las personas gestantes y garantizar que tomen decisiones informadas y conscientes, mientras que la falta de acceso a esta información puede aumentar el riesgo de enfrentar consecuencias legales perjudiciales.

8.3. Nivel socioeconómico y etnicidad

"No quiero crear algún prejuicio, pero, en mi experiencia, las personas de sexo femenino que son acusadas se les nota humildes. Nunca he visto que una persona femenina que demuestra buen vestir, joyas, haya pasado por estos procesos. Siempre han sido personas probablemente en condición humilde. Esa es la línea que se ha podido advertir."
(Pedro, Ex Defensor Público)

El nivel socioeconómico juega un papel crucial en el acceso a servicios de salud reproductiva y en la exposición a riesgos legales, especialmente en el contexto de la criminalización del aborto. Como se discutió en el capítulo 9, la criminalización del aborto afecta predominantemente a mujeres de bajos recursos, quienes no pueden costear una defensa legal de calidad. Esta falta de recursos las coloca en una desventaja significativa frente al sistema judicial, donde enfrentan acusaciones graves con poca o ninguna representación adecuada. Este desequilibrio en el acceso a la justicia refuerza las desigualdades socioeconómicas existentes y limita los derechos reproductivos de las mujeres más pobres y marginadas.

Las MPG de bajos recursos enfrentan barreras significativas para acceder a servicios seguros de aborto debido a sus limitados ingresos. Esta falta de acceso incrementa el riesgo de procedimientos inseguros y la probabilidad de enfrentar consecuencias legales severas. En los casos judiciales analizados, la mayoría de las mujeres criminalizadas por aborto vivían en condiciones de pobreza, con ingresos muy por debajo del promedio nacional, lo que refleja una vulnerabilidad adicional frente al sistema legal.

La pobreza limita significativamente la capacidad de las mujeres perseguidas penalmente para afrontar los costos judiciales prolongados y onerosos, impactando también su salud mental y capacidad laboral. Los gastos asociados con la representación legal, el transporte para asistir a audiencias y la pérdida de ingresos debido a la disminución de la actividad laboral son cargas adicionales que estas mujeres deben soportar. Esta situación no solo exacerba su situación económica precaria, sino que también les impide acceder a una defensa adecuada, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad y desprotección. En muchos casos, las personas criminalizadas dependen de defensores públicos o de asistencia legal gratuita, que a menudo no tienen los recursos necesarios para proporcionar una defensa robusta.

"Las personas denunciadas comúnmente son quechuahablantes, su grado de instrucción es de secundaria completa o incluso menos que eso"
(Alberto, funcionario Dirincri)

Por su parte, la etnicidad juega un papel significativo en la criminalización del aborto, especialmente para mujeres racializadas. En el análisis realizado en el apartado 5.3, se encontró una correlación positiva y significativa entre la tasa de criminalización del aborto no forzado y el porcentaje de población quechua. Este hallazgo sugiere que las mujeres indígenas quechuas están desproporcionadamente afectadas por la criminalización del aborto, lo que refleja una combinación de factores socioeconómicos y culturales que influyen en su vulnerabilidad frente al sistema legal.

Así, las estructuras de poder históricas y el patriarcado continúan influyendo en la vida de las mujeres indígenas, exacerbando las desigualdades y limitando sus derechos reproductivos. La falta de sensibilidad cultural y de respeto a la diversidad étnica en el sistema judicial y de salud agrava la situación, ya que las mujeres indígenas enfrentan barreras adicionales (desde el idioma, en primer lugar) para acceder a servicios de salud reproductiva seguros y justos. La discriminación estructural y los prejuicios culturales arraigados perpetúan un ciclo de exclusión y violencia que afecta directamente la autonomía reproductiva de estas mujeres.

Este análisis resalta la necesidad urgente de adoptar enfoques interseccionales que consideren las múltiples dimensiones de la identidad y la opresión en la región andina. Abordar la criminalización

del aborto desde una perspectiva que incluya la etnia y el género es crucial para entender y mitigar las desigualdades que enfrentan las mujeres indígenas.

8.4. Enfoque de la defensa legal

"Así es como yo contacto a un grupo acá de Huaraz, una organización feminista, y una de las chicas conocía a una abogada. Me explicaron que ella se especializaba en todos esos casos sobre aborto. Entonces así es como empecé a hablar con ella y se ofreció a ayudarme: al final terminaron archivando el caso".
(Marianella, mujer criminalizada)

El enfoque y la calidad de la defensa legal son elementos clave que influyen en el resultado del proceso de criminalización del aborto para las personas gestantes, especialmente en relación con las garantías procesales. Es muy importante que una defensa legal feminista no solo proteja los derechos reproductivos de las personas gestantes, sino que también asegure el respeto de las garantías procesales durante todo el proceso judicial a fin de que no se cometan abusos.

Por ejemplo, según el testimonio de **Martha,** una abogada defensora, identificó en un caso que no había medios probatorios suficientes o válidos, en lo cual pudo apoyar su estrategia. Esta estrategia no solo busca la absolución de las acusadas, sino que también garantiza el respeto a su derecho a un juicio justo y equitativo.

Además, es crucial destacar la aplicación consciente y reflexiva del marco internacional de derechos humanos en la resolución de casos de criminalización del aborto como un elemento que tiene impactos favorables en el proceso penal. La jueza entrevistada enfatizó este punto como un elemento fundamental para proteger los derechos de las niñas, subrayando la importancia de interpretar las normas de manera actualizada y en línea con los principios de derechos humanos.

En contraste, un factor que agrava el resultado de los casos es una estrategia identificada entre abogados/as de la defensa legal de oficio: la terminación anticipada. Esta estrategia prioriza que las personas acusadas se declaren culpables a fin de terminar el proceso de investigación, incluso sin analizar de manera minuciosa los medios probatorios o si se han brindado las garantías procesales necesarias.

8.5. Nivel de soporte del entorno cercano

Mi papá estuvo con mis hijos, y me dijo que la decisión que tomara iba a ser la mejor. Siempre me da ánimos, me dice que vaya a las terapias, que me dedique tiempo a mí misma. Siempre como que me está llamando, me está preguntando cómo estoy.
(Catherine, mujer criminalizada)

El apoyo familiar y comunitario puede ser determinante en la forma en que se desarrolla el caso y en la capacidad de la persona imputada para afrontar el proceso judicial. Por ejemplo, en el testimonio de **Catherine**, se destaca el apoyo incondicional de su padre, quien entiende y respalda la decisión que ella tomó, apoyo que contribuyó positivamente a su situación durante el proceso de criminalización del aborto.

El nivel de soporte del entorno cercano también se relaciona con la capacidad de acceder a recursos legales y apoyo práctico. Por ejemplo, en algunos casos, un familiar o amistades pueden no sólo brindar ánimos y validación, sino también brindar datos y contactos de ayuda legal que resultan cruciales para la persona criminalizada.

En contraste, la falta de apoyo del entorno cercano puede exacerbar la vulnerabilidad de la persona criminalizada, especialmente en contextos donde la presión social y el estigma son altos. Como mencionó una **Carla**, acompañante entrevistada, muchas personas prefieren no buscar apoyo debido al temor al estigma y la persecución social, lo que dificulta el acceso a recursos legales y apoyo emocional durante el proceso de criminalización del aborto.

En resumen, el nivel de soporte del entorno cercano de la persona criminalizada puede actuar como un factor protector o agravante en el resultado del proceso de criminalización del aborto. El apoyo familiar, comunitario y de organizaciones feministas puede fortalecer la posición de la persona imputada, proporcionando recursos legales, información educativa y respaldo práctico que contribuyen a una defensa efectiva y a la protección de sus derechos durante el proceso judicial. Por el contrario, la falta de apoyo del entorno cercano puede aumentar la vulnerabilidad de la persona criminalizada, dificultando su acceso a recursos legales y apoyo emocional, y exponiéndola a mayores riesgos de estigmatización y persecución social en el contexto de la criminalización del aborto.

8.6. Nivel de prejuicios en operadores públicos

Después me llevaron a otro cuarto y las enfermeras empezaron a decirme: 'pero ¿qué te has puesto? ¿Y cuántas? ¿Qué es esto? Todas las mujeres quieren tener hijos y tú matándolos, no puede ser así, Dios te ha bendecido y tú cómo puedes matar a un ángel tan chiquito?' Cosas así me empezaron a decir".
(Catherine, mujer criminalizada)

La presencia de prejuicios y estigmas en los operadores públicos de justicia impacta de manera significativa en el proceso penal de criminalización del aborto y en la experiencia de las personas gestantes. Los estereotipos y la discriminación dentro del sistema legal y judicial complican la interpretación y aplicación de la ley en estos casos. Las actitudes estigmatizantes hacia quienes deciden abortar pueden influir en la forma en que se aborda el caso y en las decisiones tomadas durante el proceso judicial.

El testimonio de **Catherine** ilustra cómo estos prejuicios pueden manifestarse en un trato hostil y despectivo por parte del personal médico. Los comentarios del personal de salud de un hospital público reflejan una falta de comprensión y empatía hacia las decisiones personales de las mujeres, exacerbando su situación y perpetuando un ambiente de miedo y desconfianza.

La presión estatal y el hostigamiento hacia las personas gestantes que deciden interrumpir su embarazo reflejan prejuicios arraigados en algunos operadores de justicia, lo que constituye una forma de violencia institucional. Estos comportamientos hostiles agravan la situación de las imputadas, dificultando su acceso a la justicia y la protección de sus derechos. Así, la cultura de sanción y criminalización del aborto, manifestada en la falta de comprensión de las circunstancias individuales, conduce a decisiones judiciales sesgadas y basadas en prejuicios, en lugar de un análisis objetivo de cada caso.

Por otro lado, cuando los servidores públicos se manejan libres de estigmas y prejuicios y analizan el caso con mayor objetividad y empatía, el proceso puede ser una experiencia menos difícil para la persona imputada. La actitud comprensiva y respetuosa de los operadores de justicia contribuye a crear un ambiente de confianza y apoyo, facilitando un trato más humano y justo. Esto permite que el proceso judicial se enfoque en los hechos y circunstancias específicas del caso, en lugar de ser influenciado por estereotipos y discriminación.

En resumen, el nivel de prejuicios y estigmas en los operadores públicos de justicia influye significativamente en el proceso de criminalización del aborto. Actitudes estigmatizantes y discriminatorias agravan la situación de las personas imputadas, dificultando su acceso a la justicia y creando un ambiente de desprotección y vulnerabilidad. La comprensión y el respeto por parte de los operadores de justicia son esenciales para asegurar un proceso judicial más justo y equitativo para las personas imputadas en casos de aborto criminalizado.

CAPÍTULO 9

Vulneraciones a los derechos humanos y garantías procesales identificadas

Hasta este punto, el informe ha compartido desde estadísticas sobre el aborto en el Perú, hasta los testimonios de personas que han estado involucradas en dichos eventos obstétricos, pasando por los discursos que se tejen en medios de comunicación sobre las MPG que abortan. En esta sección, las inconsistencias, los hechos de abuso y las injusticias advertidas a lo largo de estas páginas, son traducidas al lenguaje de los derechos humanos. Y es que, además de ser un asunto de salud pública, la penalización del aborto tiene un impacto directo en el acceso y ejercicio de los derechos de toda MPG. Un impacto que, por desgracia, deja cicatrices en sus vidas.

Aunque, en sí misma, la criminalización casi absoluta del aborto resulta una violación a los derechos humanos, la forma en que se conducen los procesos penales contra las MPG que abortan -voluntaria o involuntariamente- demuestran que las vulneraciones a sus derechos no inician ni terminan en la tipificación penal. Conscientes de que las sentencias que concluyen el proceso sólo muestran la fotografía final de la criminalización del aborto, analizamos 15 expedientes por autoaborto para conocer el recorrido sanitario, policial, fiscal y judicial que transitan las MPG acusadas de dicho delito. Sin embargo, también reconociendo las limitaciones de los expedientes -documentos en los que predomina la voz y visión de los operadores de justicia-, esta sección se nutre de los testimonios de MPG perseguidas y defensores públicos. Con ello, aspiramos a tener una mirada mucho más completa de los hechos.

Este apartado comparte las irregularidades identificadas en diferentes espacios y momentos del proceso penal iniciado por el delito de autoaborto. Decimos "espacios", porque la criminalización del aborto no se limita a los juzgados, sino que se extiende incluso a otras instituciones como los EE.SS. públicos, donde inicia la persecución penal de las MPG. También decimos "momentos", porque las vulneraciones identificadas trascienden a una sola situación, principalmente porque son omitidas por los operadores de justicia, quienes formalmente se encuentran obligados a salvaguardar las garantías del proceso.

De esta manera, esta sección inicia señalando las vulneraciones que se producen al interior de los EE.SS., cuando una MPG llega por una emergencia obstétrica. Estas violaciones abarcan -pero no se limitan- a la violación del derecho al secreto profesional, al deber de confidencialidad, a las garantías procesales, a la integridad personal y a la libertad personal. Seguidamente, nos enfocamos en las vulneraciones identificadas a lo largo del proceso penal y que tienen como autores a la Fiscalía, el Poder Judicial y la Defensa de la MPG. Dentro de las garantías procesales vulneradas, se encuentra el derecho a probar y controlar la prueba, así como a tener una defensa efectiva. Finalmente, a la luz de la normativa interna e internacional, evaluamos el razonamiento jurídico desarrollado en las decisiones finales. Ahí advertimos que las vulneraciones al deber de motivación, al principio de presunción de inocencia, al derecho a un juez imparcial y al derecho a la igualdad y no discriminación tienen como origen la aplicación de estereotipos de género sobre las MPG.

En suma, el análisis de los expedientes y de los testimonios nos permite concluir que en este tipo de proceso penal el respeto a los derechos humanos y a las garantías procesales es casi inexistente. De hecho, da la impresión de que los operadores de justicia tienen una suerte de "carta blanca" en la aplicación de la norma, debido al tipo de delito perseguido. Un delito que, como se verá posteriormente, no sólo merece de un castigo jurídico, sino también de uno moralizador.

9.1. Vulneraciones Identificadas en los establecimientos de salud

"Fue horrible. Recuerdo que llegué y me pasaron a camilla y el doctor me empezó a exigir que dijera qué me había puesto, qué me había metido, que no me iban a atender si es que yo no decía y ahí me dejaban" (Catherine, mujer criminalizada).

Para este momento no debe causar sorpresa que el origen de las vulneraciones a los derechos humanos y garantías procesales de quienes tienen un aborto, voluntario o involuntario, se produce en los EE.SS., principalmente públicos. A partir de diversas fuentes, este estudio ha demostrado que, lejos de garantizar el acceso a un servicio de salud de calidad, los hospitales se han convertido en espacios hostiles para las MPG que pasan por un aborto. La lectura de los expedientes nos permitió adentrarnos aún más en las experiencias procesales de las MPG acusadas por el delito de aborto, y confirmar que los hospitales se han transformado en la puerta de ingreso al sistema de justicia, cuyas violaciones procesales no sólo son ignoradas a lo largo del proceso penal sino convalidadas por el sistema de justicia.

En esta sección, el análisis de los expedientes se limita a 8 de los 15 casos; en tanto sólo en ellos la persecución penal inicia en los EE.SS. públicos. De igual manera, a fin de representar la imagen completa de las vulneraciones a las garantías procesales, recogemos los testimonios de las MPG que fueron interrogadas en el nosocomio.

9.1.1. Derecho al secreto profesional y el deber de confidencialidad

"[hubo] una comunicación del médico tratante que efectivamente esta usuaria había ingresado al hospital con una situación de sangrado y al hacerle la revisión al médico de emergencia se da cuenta de que se había introducido por vía vaginal una pastilla abortiva. Luego se determinó que era una pastilla de citotex, me acuerdo el nombre, y en esa razón es que dan cuenta del aborto" (Juan, defensor público).

La lectura de los expedientes nos permitió confirmar que tanto el quebrantamiento del secreto profesional, como del deber de confidencialidad encuentran respaldo en el actual marco normativo, cuyo enérgico interés por perseguir el aborto termina por vulnerar una serie de derechos y garan-

tías procesales. Y es que cabe recordar que el artículo 30 de la Ley General de Salud establece que el personal sanitario tiene la obligación de denunciar "cuando existan indicios de aborto criminal", sin más desarrollo respecto a qué situaciones se enmarcan en esta categoría, se abre paso a mayores consideraciones arbitrarias. Como se señaló anteriormente, este artículo contraviene no sólo disposiciones constitucionales sino también es contraria a lo dispuesto por los artículos 11 y 26 Convención Americana de Derechos Humanos en lo referido a la protección a la vida privada y salud.

Del análisis pudimos advertir que en los 8 expedientes[74] de criminalización del aborto que inician en un EE.SS., el secreto profesional se quebranta a través (i) de la denuncia por parte del personal sanitario y (ii) de la declaración brindada por los mismos durante la etapa de investigación fiscal. Por su parte, la violación del deber de confidencialidad se materializa también a partir de la (iii) revelación de información personal brindada por la usuaria de los servicios de salud cuando se realiza la anamnesis o -en la mayoría de los casos- se las interroga sobre las causas de la emergencia obstétrica y (ii)a través de la entrega de la Historia Clínica a solicitud del Ministerio Público.

En 4 de los 8 casos se pudo identificar que en el Acta Fiscal, el Parte Policial, el Acta de Intervención Policial y un Oficio se registró a personal de salud como el denunciante de hechos de "aborto criminal". En tres de ellos se estableció que fueron los médicos a cargo -con especialidad ginecológica- quienes llamaron a la PNP o al Ministerio Público. Estos quebrantamientos al secreto profesional también guardan relación con los hallazgos identificados en las entrevistas a las MPG criminalizadas. Por un lado, destaca el relato de **Catherine**[75] al compartir que "[q]uién [la] denunció fue el doctor que [la] atendió". Añadiendo además el carácter ajusticiador de las dinámicas al interior del hospital, tras señalar que "otra chica que también era personal médico y que influyó mucho en la denuncia porque ella les decía que lo hicieran, que me denunciaran".

El deseo de castigo o de "ajusticiar" también se repitió en el caso de **Sofía**[76]**,** quien señaló que el residente de emergencias le indicó: *"bueno, tengo que llamar a la policía. Es mi deber llamar a la policía porque tú has abortado y eso es ilegal y todo el peso de la ley va a cær sobre ti"*. Es más, recalco que: "yo me voy a encargar de que todo el peso de la ley caiga sobre ti".

De igual manera, en otros 3 expedientes se halló que personal médico -incluyendo obstetras y ginecólogos/as- brindó su testimonio sobre el alegado "aborto criminal". Incluso cuando el artículo 165.2.a del Nuevo Código Procesal establece expresamente que médicos y personal sanitario "no podrán ser obligados a declarar sobre lo conocido por razón del ejercicio de su profesión" (una norma también contemplada en el antiguo Código de Procedimientos Penales). A pesar de ello, sus testimonios fueron considerados como medios de prueba por el Ministerio Público para demostrar el delito de autoaborto. En ninguno de ellos el Poder Judicial o la defensa pública cuestionó su validez jurídica. Es más, en dos de estos casos dio conformidad a los testimonios del personal médico a través de sus sentencias de terminación anticipada. Lo anteriormente mencionado, también pone en evidencia la violación del derecho al secreto profesional ya que como lo señaló la Corte IDH en el caso Manuela vs. El Salvador, en situaciones de emergencia obstétrica el deber de preservar el secreto profesional médico es una excepción a la obligación general de denuncia (2021; párr. 215).

74. Expediente analizado Nº 2 - MPG-2018-AQP, expediente analizado Nº 6 - MPG-2018-AQP, expediente analizado Nº 7 - MPG-2021-AQP, expediente analizado Nº 8 - MPG-2020-AQP, expediente analizado Nº 11 - MPG- 2016, expediente analizado Nº 12 - MPG-2017-LIM, expediente analizado Nº 13 - MPG-2016-LIMEste, y expediente analizado Nº 14 - MPG-2016-LIM.
75. Testimonio de mujer entrevistada y criminalizada por autoaborto.
76. Testimonio de mujer entrevistada y criminalizada por autoaborto.

En cuanto a la remisión de la Historia Clínica, advertimos que en todos los casos de criminalización que iniciaron en un EE.SS. -que además eran públicos- el personal médico remitió dicho documento al Ministerio Público. En ninguno de ellos se solicitó el consentimiento de la MPG procesada. Peor aún, en algunos casos, las acusadas cuestionaron el contenido registrado en la Historia Clínica. A pesar de todas estas consideraciones, dicho documento fue considerado como un medio de prueba para acreditar el delito de autoaborto.

Continuando con lo señalado en un inicio, el análisis de los expedientes nos ha permitido confirmar aquellas sospechas trazadas desde la lectura de las sentencias sobre el impacto del artículo 30 de la Ley General de Salud en la judicialización de casos de autoaborto. Una norma que, además de ser contraria al orden constitucional (artículos 2.7 y 2.18 de la Constitución Política) y convencional (Corte IDH, 2021, párr. 206), se encuentra en la raíz de los procesos de criminalización del aborto y cuyos efectos, como caída dominó, se manifiestan a lo largo del proceso penal.

Peor aún, sus impactos se extienden a terrenos extralegales al contribuir a la instauración de un ambiente de temor y desconfianza en los servicios de salud pública por parte de las usuarias, pudiendo incluso desincentivarlas a acudir a EE.SS. públicos frente a emergencias médicas y/u obstétricas. Un escenario que además incrementaría los riesgos a su salud y vida[77].

9.1.2. Garantías procesales

"[los policías]me decían , "¿pero tomaste pastillas? ¿Sí o no?" No. O sea, yo le dije, "los doctores me obligaron a mí a decir que había ingerido algo porque si no, no me iban a atender. "¿Pero las tomaste o no las *tomaste?[me repreguntaban]" Y le decía, no, porque los doctores solo me han dicho que diga que sí, y yo no tenía otra cosa que decir", "Ah, y entonces sí tomaste" y lo apuntaron"*
(Catherine, mujer criminalizada).

Si la lectura de las sentencias arrojó luces sobre la vulneración a diversas garantías procesales de las MPG criminalizadas por el delito de autoaborto durante su estancia hospitalaria, los expedientes reafirmaron dicha presunción[78]. Vulneraciones que se manifiestan cuando las MPG (i) fueron interrogadas en los servicios de emergencia, (ii) carecieron de la presencia de un abogado defensor en dicho interrogatorio y (iii) las autoridades (sanitarias, policiales y fiscales) no les informaron de sus derechos. En su conjunto, estos factores contribuyeron además (iv) a que las MPG se autoincriminación.

77. En efecto, como destaca Gianella, "un sistema de salud que no garantice la generación de confianza producirá actos médicos no fiables y, probablemente, no se logrará el objetivo de un beneficio en la salud de las personas/pacientes" (2011, p. 68) .
78. Expedientes analizados: Nº 1 - MPG-2027-AQP, Nº2 - MPG-2018-AQP, Nº3 - MPG-2018-AQP, Nº 4-MPG-2018-AQP, Nº 5-MPG-2018-AQP, Nº6-MPG-2018-AQP, Nº 7-MPG-2021-AQP, Nº 8-MPG-2020-AQP, Nº9-MPG-2021-AQP, Nº10-MPG-2021-AQP, Nº11-MPG-2016-L, Nº12-MPG-2017-L; Nº13-MPG-2016-LEste, Nº14-MPG-2016-L, Nº15-MPG-96; Nº16-MPG-MPG-1019-APU.

Para corroborar dichas irregularidades, se revisaron las **Historias Clínicas**[79], las **Actas de Entrevista** y las **Actas de Lectura de Derechos** incorporadas en los expedientes, documentos en los que debió constar, conforme al marco legal vigente, la intervención de la defensa técnica. Sin embargo, en **4 de los 8 expedientes**[80] originados en establecimientos de salud públicos, se verificó que las entrevistadas fueron sometidas a interrogatorios en el mismo hospital, sin presencia de defensa legal.

Sin necesidad de recurrir al marco internacional por el momento, el artículo IX del Código Procesal Penal señala de forma expresa que todas las personas tienen el derecho inviolable e irrestricto a que (i) se le informe de sus derechos, (ii) se le comunique de inmediato de la imputación formulada en su contra y (iii) sea asistida por un abogado de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. En el mismo sentido, el artículo 72.1 del Código Procesal Penal establece claramente que los Jueces, los Fiscales y la Policía Nacional tienen la obligación de informar a la persona imputada cuáles son sus derechos, los cuales además deben registrarse en un acta. Dentro de ellos, se incluye el derecho a contar con una defensa técnica desde los actos iniciales de la investigación (inciso c), así como a abstenerse de declarar y, si acepta hacerlo, a que su defensa se encuentre presente en su declaración y en toda diligencia que requiera su presencia (inciso d). El incumplimiento de estas garantías generaría, a todas luces, la ilegitimidad de las pruebas obtenidas y, por tanto, deberían haber carecido de cualquier efecto legal. Es más, debieron ser excluidas de la evaluación probatoria por la violación directa del contenido del derecho a la defensa y a la no autoincriminación, según lo señalado por el artículo VIII del Código Procesal Penal.

A pesar de la literalidad de las obligaciones de los operadores de justicia, en ninguno de los cuatro expedientes analizados se garantizó los derechos procesales de las MPG criminalizadas. Por un lado, las Actas de Entrevista sólo registraban la firma de la MPG procesada y de la autoridad fiscal o policial, destacando así la ausencia de la representación legal que evidencia a su vez la privación a su derecho a la defensa. Peor aún, en un expediente se pudo advertir que en el Acta de Entrevista a la MPG[81] se realizó durante su estancia hospitalaria, sin representación legal y en presencia de la representante del Ministerio Público. Lo alarmante de este acto radica en la naturaleza de dicho documento y la vulneración al derecho de defensa de la MPG imputada. Y es que, como establece la Directiva para la Intervención Policial en Flagrante Delito[82], dicha acta tiene como fin plasmar cómo se produjo el hecho materia de intervención, pero no entrevistar a la MPG.

Desafortunadamente, la ausencia de una representación jurídica sumada al desconocimiento de la MPG imputada sobre los derechos que la asisten desde los actos iniciales de la investigación contribuyeron a la creación de un escenario que las arrojó a la autoincriminación. Este escenario se agrava aún más si se considera que las MPG acusadas se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad, al estar recuperándose de una emergencia obstétrica y, en algunos casos, encontrarse privadas de su libertad -por su condición de internamiento en el EE.SS.- y haber sido condicionadas a recibir atención médica siempre que se autoincriminaran.

79. Los documentos revisados se limitaron a aquellos en los que recibimos autorización de las usuarias.
80. Expedientes analizados: Nº 11-MPG-2016-L, Nº10-MPG-2021-AQP, Nº 8-MPG-2020-AQP y Nº15-MPG-96.
81. Expediente analizado Nº12-MPG-2017-L.
82. Directiva N° 03-04-2016-DIRGEN-PNP/EMG-DIRASOPE-B3 aprobada por la Resolución Directoral No.135-2016-DITGEM/EMG-PNP.

Las dimensiones de esta situación de vulnerabilidad fueron también dilucidadas a partir de la entrevista a un defensor público, quien señaló que:

> *"[N]o se le recomendó guardar silencio pero... en ese momento, en el estado que ella se encontraba, era bastante expresiva. Ella decía pues que "no, yo, por esta situación (escasos recursos económicos)", en su desesperación, indicaba que en todo momento que sí, ella quería declarar. Entonces en ese sentido ya no había forma, tampoco de inducir de que ella guarde silencio". Esta mujer se encontraba en una situación de crisis emocional por lo que necesitó ser medicada en tanto "presentaba ansiedad, (...) se le suministró medicamentos. La situación que estaba pasando la señora en ese momento era de desesperación" (Juan, ex defensor público).*

Este conjunto de factores permite sostener que las declaraciones autoincriminatorias de las MPG acusadas no fueron voluntarias. Una garantía procesal que no sólo se quebranta con violencia (física, psicológica o sexual) o a través del uso de métodos engañosos, sino también cuando la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las condiciona a asumir su culpabilidad. Es decir, cuando su declaración no formó parte de su libre expresión de voluntad. Y es que cabe recordar que, desconociendo sus obligaciones, ninguna autoridad les informó de su derecho a guardar silencio o de contar con una defensa jurídica que las pudiera asesorar en actos claves del proceso, como la toma de declaración.

Lamentablemente, en todos los expedientes analizados, los operadores de justicia omitieron verificar la legalidad de las declaraciones autoincriminatorias, eludiendo su deber de garantizar las garantías procesales establecidas tanto en la Constitución Política en el artículo 138 como en la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta última dispone, en su artículo 8.2.g, que una de las garantías mínimas de las personas procesadas es no ser obligadas a declarar contra sí mismas ni a confesarse culpables.

Las vulneraciones a los derechos procesales también fueron identificadas en las entrevistas: fuentes que nos permitieron conocer las experiencias de las MPG acusadas que no fueron registradas en los expedientes. A partir de ellas pudimos conocer que algunas MPG tuvieron que auto incriminarse para recibir asistencia médica, una afirmación que luego sería utilizada por los operadores de justicia en el proceso penal para sostener su culpabilidad. El relato de **Catherine** retrata este escenario:

> *Me decían, "¿pero tomaste pastillas? ¿Sí o no?" No. O sea, yo le dije, "los doctores me obligaron a mí a decir que me había ingerido algo porque si no, no me iban a atender. "¿Pero las tomaste o no las tomaste?" Y le decía, no, porque los doctores solo me han dicho que diga que sí, y yo no tenía otra cosa que decir", "Ah, y entonces sí tomaste" y lo apuntaron (Catherine, mujer criminalizada)*

En suma, las declaraciones -y, por tanto, las autoincriminaciones de las MPG acusadas- carecían de validez jurídica por prescindir de las garantías procesales mínimas. Sin embargo, como se verá posteriormente, ello no constituyó un impedimento para que los operadores de justicia las utilizaran para perseguirlas penalmente y, finalmente, condenarlas.

9.1.3. Derecho a la integridad personal y violencia obstétrica

"[ella]presentaba (...) ansiedad,[en el hospital]se le suministró medicamentos(...)la situación que estaba pasando la señora en ese momento era de desesperación"
(Juan, defensor público)

El análisis de esta sección se limita a los testimonios de dos mujeres acusadas de autoaborto en EE.SS. públicos que fueron entrevistadas para esta investigación. Los expedientes no fueron considerados en tanto los hechos se registran exclusivamente desde la mirada de los operadores de justicia. Las entrevistas, por el contrario, les dan la oportunidad de contar sus experiencias con sus propias palabras.

La Corte IDH, en el caso Brítez Arce y otros vs. Argentina, ha determinado que la violencia ejercida durante el embarazo, el parto y el posparto en el acceso a los servicios de salud constituye una violación manifiesta de los derechos humanos y una forma específica de violencia de género, conocida como violencia obstétrica. Esta forma de violencia abarca situaciones de trato irrespetuoso, abusivo, negligente o la denegación de atención médica tanto durante el embarazo, el parto y el posparto,(2022; párr. 75) como en los contextos relacionados con el aborto y el post-aborto, tanto en centros de salud públicos como privados .

La violencia obstétrica en los cuidados relacionados con el aborto y post-aborto es un elemento recurrente en las historias de Catherine y Sofía. Entre las principales manifestaciones de esta violencia se destacan el sometimiento interrogatorios en las salas de emergencia, la coacción para autoincriminarse, la condicionante de acceso a la atención médica a cambio de una "confesión" de culpa, la privación de alimentos como forma de castigo, la privación de anestesia, la exposición intencionada de los restos fetales, los insultos y la restricción indebida de la libertad dentro de los centros de salud.

Los testimonios de Catherine y Sofía permitieron conocer algunos de los maltratos que sufren las MPG acusadas del delito de autoaborto. Decimos "algunos" porque reconocemos que las experiencias de otras MPG perseguidas pueden incluir otros tipos de violencias. Dicho esto, una de las primeras manifestaciones de la violencia psicológica identificadas fue condicionar el acceso a servicios de salud a la autoincriminación de la paciente. Más allá de configurar una vulneración a las garantías procesales y al derecho a la salud, dicho acto también supone un maltrato psicológico. Y es que, en ese momento, las MPG acusadas no sólo se encuentran experimentando altos niveles de dolor, sino también temor de perder su vida, la cual además se encuentra en manos del personal médico que condiciona su atención.

En el caso de Sofía, el ginecólogo a cargo le dijo: "tienes que decirme si has tomado pastillas o no porque si no, no te voy a atender". Este escenario se repitió momentos previos a realizar el legrado, cuando una enfermera le dijo "el policía está afuera y quiere saber dónde es que has conseguido las pastillas". Sofia recuerda ese momento de la siguiente manera:

Yo estando echada, con las piernas arriba, esperando que me hagan un alegrado. Seguía sangrando, seguía mal. Y me dijo, "no, es que quiere saberlo. Quiere saberlo". Y hasta creo que entró el policía.

Ya no me acuerdo porque estaba mal, ¿no? Pero estaba ahí, ¿no? O sea, seguía ahí. Y yo no sabía qué hacer. Y yo le decía, "no sé, no sé, no sé, no sé, por favor, ayúdeme (Sofía, mujer criminalizada)"

La historia de Catherine es similar en tanto "el doctor [l]e empezó a exigir que dijera qué [s]e había puesto, qué [s]e había metido, que no [l]e iban a atender si es que [ella] no decía y ahí [s]e lo dejaban [el feto]". En efecto, ambas narraciones evidencian sentimientos de angustia, miedo y desesperación por parte de las mujeres, las cuales además se convirtieron en episodios traumáticos para ambas.

La violencia psicológica también se manifestó en agresiones verbales que buscaban generar sentimientos de culpa en la paciente. De acuerdo con Catherine, las enfermeras le decían "Que todas las mujeres querían tener hijos y tú matándolos, que no puede ser así, que Dios te ha bendecido y tú, ¿cómo puedes matar a un ángel tan chiquito? Cosas así me empezaron a decir". Sin embargo, sostiene que el episodio más cruel durante su estancia hospitalaria fue el siguiente:

"Lo que fue más horrible fue cuando, o sea, mi pareja trajo la bolsa con el feto y sin pena lo dejaron debajo de la camilla. Y después de un rato como que subieron la bolsa y en mis pies abrieron la placenta y sacaron el bebito y ellos lo tenían delante de mí y me empezaron a decir cosas horribles. Creo que eso fue lo más difícil de todo. Porque ya me puedo tragar las cosas que me digan, pero el hecho de que, no sé, que agarran el bebé así y me hagan ver y me digan cosas horribles, eso fue lo peor. Porque me trataban de asesina, de mala, esas cosas, lo siento (Catherine, mujer criminalizada)".

El castigo también se manifestó por medio de la privación de alimentos necesarios, un maltrato que -de acuerdo con el personal médico- tenía como fin que ella reflexionara sobre su mal actuar, demostrando también el abuso de poder del personal sanitario.

"Me trataron muy mal. No me dieron de comer en todo el día para que, supuestamente, piense en las cosas que había hecho y que esas eran las consecuencias. Y me mataron de hambre todo el día. No me dieron ni un vaso de agua. Fue un trato pésimo. Ni siquiera es que me lo dijeron a mí sola en un cuarto. Había como dos, tres pacientes y delante de ellas me hablaban así (Catherine, mujer criminalizada)"

Desafortunadamente, la violencia física también se encontró presente en el testimonio de una de ellas. La experiencia de Sofía al momento del legrado demuestra la indiferencia del personal médico respecto del dolor que puede sentir la paciente durante la intervención médica, una práctica que además no debería causarle dolor.

"Me hicieron el legrado. No sé si me pusieron anestesia, porque me desmayé del dolor. Fue muy fuerte, o sea, yo solo gritaba.

[Y]o me acuerdo moverme, ¿no?, porque dolía demasiado. Y el doctor me decía, "no te muevas, no te muevas" Y yo sola, como que, "pero duele, duele mucho" porque era una aspiradora ahí, ¿no? O sea, era... Es muy fuerte. Y, obviamente, me desmayé del dolor (Sofia, mujer criminalizada)"

Es posible concluir que una de las características comunes en los casos de criminalización del aborto es su vínculo directo con la violencia obstétrica, la cual se encuentra profundamente normalizada, a pesar de estar prohibida por el artículo 5[83] de la Ley Nº 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Asimismo, esta práctica constituye una violación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, el cual impone la obligación de los Estados de garantizar el derecho a vivir una vida de libre de violencia obstétrica; así como sus agentes actúen en consecuencia, tomando en consideración la especiali vulnerabilidad que implica encontrarse en un contexto post aborto (Corte IDH caso Brítez Arce y otros vs. Argentina, 2022, párr. 77).

9.1.4. Derecho a la libertad personal

"[mi patrocinada]estaba con custodia. Pues dado que en ese momento se había dispuesto la custodia de la usuaria, inmediatamente luego que ella prestó su declaración, pasó a calidad de citada. [estuvo detenida]aproximadamente tres horas, porque fue rápido. Dado su situación, concurrimos en forma inmediata al hospital" (Juan, defensor público)

Aunque el derecho a la libertad personal abarca diferentes dimensiones, para el presente informe nos limitaremos a su aspecto más general. Es decir, aquel que lo asocia a la libertad de movimiento. Al igual que en la sección anterior, la vulneración a este derecho en los EE.SS. públicos sólo pudo ser identificado en el marco de las entrevistas realizadas a las MPG acusadas por el delito de aborto.

En particular, el testimonio de Catherine dio luces de algunas prácticas llevadas a cabo en los nosocomios: retener a la paciente en contra de su voluntad -durante horas o días- en el hospital a fin de obtener su testimonio.

Por más que había dado mi testimonio, no me querían dejar salir. Y estaba desesperada por salir del hospital porque ya me suelten. Llegué a salir al día siguiente. Ya no había nada y recién me dieron el alta. Y ahí pude salir. Estuve detenida cuatro días. (...) Sí, los primeros dos días fue que tenía que venir la policía. El segundo día, el tercer día vino la policía a tomar una manifestación pero nada, no me dejaron salir. El cuarto día recién en la tarde me dejaron salir. (Catherine, mujer criminalizada).

83. Artículo 5. Definición de violencia contra las mujeres: La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. (...) b) Se entiende por violencia contra las mujeres: La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

Para este punto debe quedar claro que la limitación al derecho a la libertad personal no depende de la discrecionalidad de cualquier autoridad, sino que -en virtud del principio de legalidad- ella debe responder a causas y condiciones establecidas en la normativa interna. En efecto, la Constitución Política establece en su artículo 2.24.b que "No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley". En este caso, no existía ninguna razón legal que justificara que Catherine permaneciera retenida en el EE.SS. A pesar de ello, y desconociendo de los derechos que debían ser puestos en su conocimiento, Catherine permaneció por cuatro días en el hospital.

Así también, uno de los defensores públicos entrevistados para esta investigación narró la historia de una de las mujeres a las que él asistió en un hospital la misma que fue custodiada por efectivos policiales y retenida en el hospital por unas horas, luego de que éste solicitara la aplicación del principio de oportunidad; el mismo que supuso que la MPG asumiera su responsabilidad. Así relata "la usuaria se puso en custodia durante 3 horas en el hospital, después de brindar su declaración se puso en calidad de citada".

9.2. Vulneraciones al debido proceso identificadas en el proceso penal

"Lo que más llama la atención, es que haya habido una sentencia, ¿no?Cuando era evidente que no había sucedido ese hecho(...) no se había cometido ninguna infracción, ¿no?"
(Martha, abogada de adolescente criminalizada)

La adecuada aplicación del debido proceso es un pilar fundamental en cualquier sistema judicial que busque garantizar la justicia y proteger los derechos de las personas. En este contexto, este apartado se centra en examinar las vulneraciones al debido proceso identificadas en el ámbito del proceso penal, específicamente en relación con el derecho a probar y controlar la prueba, así como el derecho a la defensa. Para ello, se analizan detalladamente 15 expedientes judiciales y se complementa con entrevistas a diversos actores del sistema de justicia, como MPG, operadores judiciales y abogados defensores. Este análisis permite identificar una serie de irregularidades que afectan la imparcialidad y la equidad del proceso penal.

9.2.1. Derecho a probar y controlar la prueba

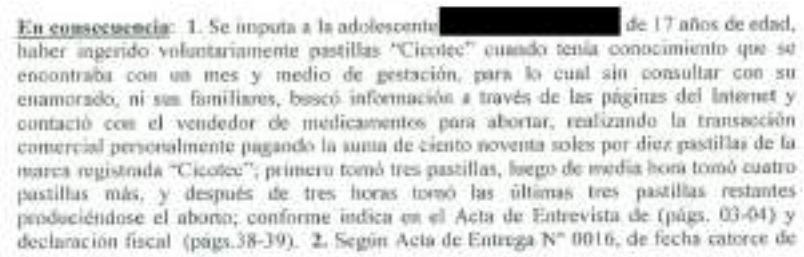
El Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho fundamental a la prueba goza de protección constitucional (2007, Sentencia Nº 1014-2007-PHC/TC, fundamento jurídico 8-14), siendo parte esencial del derecho al debido proceso según lo establecido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución. Este derecho permite a las partes del proceso presentar los medios de prueba necesarios para convencer al juez sobre la veracidad de sus argumentos. Sin embargo, como ocurre

con todos los derechos fundamentales, el derecho a la prueba está sujeto a restricciones por la necesidad de armonizar con otros derechos fundamentales.

Aunque el reconocimiento del derecho a la prueba en la normativa es limitado y se relaciona principalmente con la presunción de inocencia, cabe reconocer que este derecho implica la posibilidad de presentar los medios probatorios pertinentes dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes. Uno de estos límites viene trazado por el artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Penal, el cual establece que todo medio probatorio podrá ser valorado si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo.

Considerando la doble naturaleza de los derechos fundamentales y del derecho a la prueba en particular, este último implica también el deber del juez de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico correspondiente a los medios de prueba en el iter procesal en el que interviene. En suma, el derecho a la prueba no solo implica la posibilidad de ofrecer y admitir medios probatorios necesarios, sino también que estos sean adecuadamente actuados, producidos, conservados y valorados con la debida motivación por parte del juez, respetando siempre los derechos fundamentales y las leyes aplicables en el proceso.

De los 15 expedientes analizados, es posible concluir que sólo en un caso, a pedido de la defensa de la acusada, el juez excluyó su declaración por considerarla irregular. En los 14 restantes, tanto fiscales como jueces omitieron realizar un control sobre la legalidad de las pruebas, como, las declaraciones y actas de entrevistas actuadas por la PNP en las que no participaron sus abogados defensores. Es más, emplearon dichas pruebas para fundamentar la condena.


En consecuencia: 1. Se imputa a la adolescente [redacted] de 17 años de edad, haber ingerido voluntariamente pastillas "Cicotec" cuando tenía conocimiento que se encontraba con un mes y medio de gestación, para lo cual sin consultar con su enamorado, ni sus familiares, buscó información a través de las páginas del Internet y contactó con el vendedor de medicamentos para abortar, realizando la transacción comercial personalmente pagando la suma de ciento noventa soles por diez pastillas de la marca registrada "Cicotec"; primero tomó tres pastillas, luego de media hora tomó cuatro pastillas más, y después de tres horas tomó las últimas tres pastillas restantes produciéndose el aborto; conforme indica en el Acta de Entrevista de (págs. 03-04) y declaración fiscal (págs.38-39). 2. Según Acta de Entrega N° 0016, de fecha catorce de

En el caso de Kari[84], la adolescente de 17 años que fue sentenciada y declarada infractora por el delito de autoaborto, la jueza de familia a cargo no solo incumplió con su deber de supervisar los medios de prueba presentados por la fiscalía, tales como el Acta de Entrevista y su Declaración, en la que ella no tuvo representación legal. Además, empleó medios de prueba ilícitos para castigar y sentenciar a Kari. Ello contraviene el artículo 159 del Código Procesal Penal que establece que el juez no puede utilizar, ni directa ni indirectamente, los medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de las personas.

Como podemos advertir, la omisión injustificada de controlar la validez legal de una prueba presentada por la Fiscalía, dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a la normativa pertinente, constituye una vulneración del derecho fundamental a la prueba y, por ende, del debido proceso.

84. Expediente analizado Nº 12, MPG-2017-LIM.

9.2.2. Derecho a la defensa

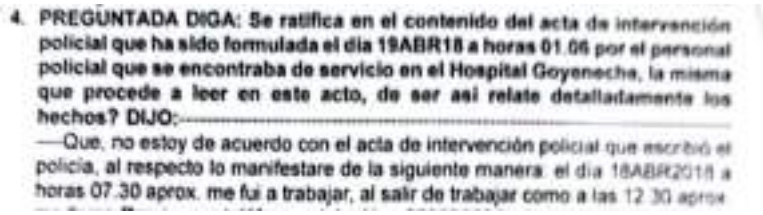
La ausencia de defensa en la toma de declaraciones

Reiteradamente, el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la defensa comporta, en estricto, el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso penal, que tiene una doble dimensión. La primera es material, referida al derecho de la persona imputada o demandada de ejercer su propia defensa desde el instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de un hecho delictivo. La segunda dimensión es la formal, que supone el derecho a una defensa técnica. Es decir, al asesoramiento y patrocinio de un/a abogado/a defensor durante el tiempo que dure el proceso (Tribunal Constitucional, 2022, Sentencia N.° 05246-2022-HC/TC). En ese sentido, el artículo 86 del Código Procesal Penal refiere que, durante la investigación preparatoria, el imputado podrá prestar declaración ante la PNP o Fiscalía siempre que cuente con la asistencia de su defensa.

Para esta investigación resultaba clave verificar si esta garantía procesal se había cumplido o no y en qué medida. De los 15 expedientes a los que se tuvo acceso, solo en 6 se pudieron identificar Declaraciones, Actas de Intervención y Entrevistas. Las Actas de Entrevista realizadas en EE.SS. solo fueron identificados en 2 expedientes, los que además carecieron de acompañamiento legal (público o privado). Sin embargo, la Fiscalía consideró este documento como medio de prueba en ambas circunstancias. Por otro lado, en 5 expedientes se observó que las Declaraciones realizadas durante la etapa de diligencias preliminares tampoco contaron con defensa. Resulta notable el caso de **Lía**[85], una mujer cuyo aborto incompleto fue atendido en un consultorio privado y posteriormente necesitó atención médica. En su caso se advierte del Acta de Entrevista y de su Declaración que careció de acompañamiento legal, pero sí contó con presencia de Fiscalía.

Otros riesgos asociados a la falta de garantía del derecho a la defensa están asociados a que (i) la información registrada en las actas y declaraciones sea modificada por las autoridades, y (ii) las preguntas dirigidas a las MPG investigadas estén diseñadas para inducirlas a la autoincriminación.

Un caso que refleja esta primera caracteristica es el de Mar, una mujer que llegó al hospital público con un aborto incompleto, la misma que se vio sometida a un interrogatorio por parte de la PNP dentro del EE.SS y sin asesoría legal. En el Acta de Intervención Policial se consignó que había utilizado pastillas de "Cytotec", supuestamente proporcionadas por un amigo.


4. **PREGUNTADA DIGA: Se ratifica en el contenido del acta de intervención policial que ha sido formulada el dia 19ABR18 a horas 01.06 por el personal policial que se encontraba de servicio en el Hospital Goyeneche, la misma que procede a leer en este acto, de ser asi relate detalladamente los hechos? DIJO:**----------
—Que, no estoy de acuerdo con el acta de intervención policial que escribió el policia, al respecto lo manifestare de la siguiente manera: el dia 18ABR2018 a horas 07.30 aprox. me fui a trabajar, al salir de trabajar como a las 12.30 aprox

85. Expediente analizado Nº 11, MPG-2016-LIM-ECC.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre si ratificaba el contenido del acta policial, en su declaración -también realizada sin acompañamiento legal- Mar expresó su desacuerdo con dicho documento. En su testimonio mencionó que la persona con la que había mantenido relaciones sexuales le entregó unas pastillas luego de comunicarle que experimentaba dolor y sangrado. Mar no sólo desconocía el nombre de las pastillas, sino que las consumió sin saber que tienen efectos abortivos. Es decir, no se trataba de un aborto intencional. Es más, ella señaló que no deseaba perder el embarazo. Asimismo, indicó carecer de recursos económicos para costear su defensa. A pesar de ello, la PNP no garantizó la presencia de la defensa pública. Mar fue sentenciada por el delito de autoaborto y una de las principales pruebas utilizada en su contra fue su declaración.

.PREGUNTADA DIGA: Si tiene algo más que agregar, quitar o modificar a su presente declaración? DIJO:----------
----Que, mi plan era tenerlo a mi bebe con Alonso pero para esto yo tenía que mudarme de la casa de mi mama, Alonso me iba a apoyar por el lapso de seis meses con mis hijos, de ahí íbamos ver cómo seguir, además tenía muchos planes con mi bebe y en la actualidad me siento mal por lo sucedido; asimismo debo manifestar que no tengo recursos económicos para contratar un abogado defensor y si esto declaro es en honor a la verdad. Es todo lo que tengo que declarar al respecto y leída que fue la encuentro conforme en todas sus partes firmándola e imprimiendo mi índice derecho en señal de conformidad, en presencia del instructor que certifica.----------

En cuanto a la segunda característica, el caso de **Lia**[86] describe con claridad cómo la PNP realiza preguntas con clara intención de inducir a las MPG a la autoincriminación. Este proceder se encuentra proscrito el artículo 88, numeral 4, del Código Procesal Penal, refiere que "no podrán formularse preguntas ambiguas, capciosas o sugestivas". El caso de Lía fue archivado por prescripción, luego de una investigación que duró 3 años, 2 meses, y 9 días.

PREGUNTADO DIGA: Diga Ud., como fue que se acudía un centro medico por su embarazo para hacerse una limpieza y quien le motivo para hacerle un aborto consentido? Dijo:----------
— Que, el día lunes 22ABR2013, fui a trabajar como de costumbre y a las 11:00 am, salí de trabajo por que la sra. donde trabajo me dijo que iba a ver a su esposo, y fue que en esos momentos que aproveche para ir al centro de

La ineficacia de la defensa pública

El derecho a la defensa también involucra, en su sentido negativo, la prohibición de quedar en indefensión. Ello supone, entre otras cosas, que el/la abogado/a designado/a en el proceso penal realice eficazmente la defensa técnica, lo que comporta como garantía para enfrentar el proceso penal en igualdad de armas frente al MPFN y el Poder Judicial (Nakazaki Servigón, 2006, p. 18). La falta de garantía de este derecho comporta la nulidad del proceso penal por la vulneración del derecho fundamental a la defensa y el debido proceso.

ENTREVISTADA DIGA: CUANTOS MESES DE EMBARAZO TENIA Ud. ANTES DE SOMETERSE A LA PRACTICA ABORTIVA; DIJO: - - -

JUSDH, era clave evaluar las estrategias utilizadas por estas defensas y su efectividad. Este tipo de análisis requería, sin embargo, del estudio de expedientes.

Dentro de los hallazgos más relevantes, destaca que en 10 de los 15 expedientes, las MPG criminalizadas tuvieron una Defensa Pública y que, en todos ellos, las sentencias fueron condenatorias. Asimismo, se observó como práctica habitual: (i) la falta de impugnación de la legalidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía, como las Actas de Entrevistas y Declaraciones sin la presencia de un abogado/a; (ii) la ausencia interposición de recursos para proteger el derecho al debido proceso de las investigadas, tales como solicitar la exclusión de pruebas ilegales, (iii) la falta de control de los plazos prescriptorios; y (iv) la promoción de acuerdos de terminación anticipada.

Las características de la defensa de oficio evidencian una vulneración del derecho a una defensa adecuada. Aunque en estos casos se cumplió con la formalidad de asignar abogados de oficio a las investigadas, su representación no fue eficaz. En relación con esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso *Manuela vs. El Salvador estableció* que el Estado debe garantizar que los defensores de oficio actúen de manera diligente para proteger las garantías procesales de las personas procesadas, evitando así que sus derechos sean vulnerados (2021, párr. 122). De lo contrario, la asistencia legal que se limita a cumplir una formalidad procesal equivaldría a no contar con una defensa técnica real.

9.2.3. Privación de libertad

Aunque de la revisión de las sentencias, sólo identificamos un caso que resultó en una pena efectiva de privación de libertad por el delito de parricidio, el estudio de expedientes nos permitió conocer de otras problemáticas al interior de estos procesos. Notamos que, si bien no se emiten sentencias con penas de prisión efectiva, en 687 de los 15 casos revisados, los jueces emitieron órdenes de captura. Estas órdenes llevaron a la detención y privación de la libertad de las MPG.

Estas disposiciones de captura fueron emitidas por los jueces penales, a petición de la Fiscalía, como una medida de apercibimiento luego de que las MPG no asistieron a las audiencias de juicio oral. Con ello se cambió su condición de comparecencia a reas contumaz para su conducción obligatoria al juicio. Pese a su prohibición, en algunos casos las mujeres fueron esposadas, fotografiadas y expuestas al escrutinio público. Ello se puede apreciar en la fotografía presentada.

Un caso que refleja este tipo de acciones es el de Ina88, una mujer con discapacidad auditiva e iletrada. Al revisar su expediente, no podemos concluir que Ina haya sido notificada de manera adecuada, ni que haya comprendido claramente el contenido de la citación judicial. Además, no se encuentran disposiciones del juez penal que hayan tenido en cuen-

87. Expediente analizados: Nº 2 - MPG-2018-AQP; Nº3-MPG-2018-AQP; Nº4-MPG-2018-AQP; Nº 5-MPG-2018-AQP; Nº9-MPG-2021-AQP; y, Nº10-MPG-2021-AQP.
88. Expediente analizado Nº 10, MPG-2021-AQP-RBC.

ta sus vulnerabilidades -como su discapacidad auditiva y condición de iletrada- para la implementación de ajustes razonables a lo largo del proceso. Dicha negligencia nos impide inferir que su ausencia haya sido intencional y motivada para obstaculizar el juicio. Más bien resulta imposible saber si Ina comprendió con claridad las razones por las que enfrentaba un juicio. Se observa únicamente que su defensor de oficio no cuestionó la idoneidad de la notificación ni la solicitud de la Fiscalía. De hecho, expresó su conformidad.

9.2.4. Plazo razonable

En general, los procesos judiciales por el delito de autoaborto prescriben después de tres años, plazo en el cual las autoridades encargadas de las investigaciones disponen de tiempo para impulsar la acción penal. Este plazo razonable constituye una garantía procesal en favor de las personas bajo el escrutinio del sistema de justicia. Aunque desde el análisis de sentencias advertimos que **1 de cada 3 procesos judiciales por autoaborto continuaron aún con los plazos prescriptorios vencidos,** consideramos necesario analizar si en esos casos se presentaron o no mecanismos de defensa por quienes ejercieron el patrocinio. De igual manera, buscábamos entender el razonamiento de los/las jueces/zas para la continuación del proceso aún con acción penal ya extinta.

Resultó sorprendente descubrir que de los 16 expedientes examinados, seis excedieron el límite de prescripción y que en ninguno de ellos la defensa solicitó el cese del proceso penal. Solo en uno de esos casos los jueces llevaron a cabo el control correspondiente y declararon la prescripción de la acción penal. En los otros cinco casos, las condenas se dictaron a pesar de que la acción penal estaba extinguida. Ello nos demuestra, por un lado, que las MPG contaba con una defensa ineficaz, la cual no presentó excepciones por el vencimiento del plazo de la acción penal establecido en el artículo 6, literal 6 del Código Procesal Penal. Por el otro, evidencia una falta de control de legalidad por parte de los/as magistrados/as, quienes condenaron de manera irregular a las imputadas.

El caso más llamativo fue el de **Elena**[89], quien recibió una condena por el delito de aborto. Su proceso judicial comenzó el 2 de abril de 2015, siendo detenida y privada de su libertad el 7 de junio de 2021, como medida de apercibimiento debido a que no concurrió a la audiencia de juicio oral. Finalmente, el 8 de junio de 2021, con ella detenida, se dictó la sentencia que terminó finalmente en su condena. En otras palabras, desde el momento de su intervención hasta la lectura de la sentencia, transcurrieron 6 años, 2 meses y 6 días: un período que superó en exceso el plazo prescriptorio establecido para el delito (3 años, 2 meses y 6 días).

Estas irregularidades subrayan la necesidad urgente de proveer mejores mecanismos de defensa por parte de sus abogados y abogadas defensoras, sobre todo de quienes asumen esta labor en el ámbito público. De igual manera, destaca la necesidad de supervisar el desempeño de los jueces y juezas.

89. Expediente analizado Nº9, MPG-2021-AQP.

9.2.5. Solicitudes de conclusión anticipada del juicio

Según las reglas procesales peruanas, un paso necesario en el periodo inicial del juicio oral es poner a consideración de las partes la posibilidad de arribar a una "conclusión anticipada del juicio". El artículo 372 del Código Procesal Penal establece que, después de haber instruido de sus derechos a la persona acusada, el juez le preguntará si admite la autoría o participación en el delito materia de acusación y su responsabilidad sobre la reparación civil. Si la persona acusada responde afirmativamente, el juez declara la conclusión del juicio. Antes de emitir una respuesta, la persona acusada tiene la posibilidad de conferenciar con su defensa y la fiscalía para llegar a un acuerdo sobre la pena. La sentencia condenatoria que emitirá el juez se dictará aceptando los términos del acuerdo entre las partes (Fiscalía y parte acusada).

Esta forma de concluir el juicio supone la renuncia a la actuación probatoria y del derecho a un juicio público. Una de las implicancias directas de este procedimiento especial es que los hechos aceptados por la parte acusada son los definidos en la acusación fiscal. No obstante, como refiere el Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116 el juez debe ejercer un rol de control. De esta manera, es su obligación: (i) apreciar que la decisión de la persona acusada sea expresada de forma libre, voluntaria, sin vicios del consentimiento, con plena capacidad y conocimiento racional e informado de la naturaleza de la acusación que acepta, la limitación o restricción de sus derechos e intereses legítimos; así como de los derechos e instrumentos de defensa a los que está renunciando; (ii) realizar un control respecto a la tipicidad de los hechos, el título de la imputación, así como la pena solicitada y aceptada; (iii) identificar la presencia de cualquier causa que exima o atenúe la responsabilidad penal (Corte Suprema de Justicia de la República, 2008, fj. 8, 11 y 14). Si después de ejercido el control, el juez considera que se han vulnerado los aspectos antes mencionados, dictará sentencia en los términos que considere, apartándose del acuerdo entre las partes. Es decir, el juez no comporta la suerte de una mera mesa de partes; sino que recae sobre él una obligación de control de legalidad de los acuerdos en cuanto al consentimiento, tipicidad de los hechos, el título de la imputación y la pena.

Del análisis de las sentencias, observamos que el 41% de los casos culminaron con sentencias condenatorias derivadas de un proceso de conclusión anticipada. Un porcentaje que evidencia el uso habitual de esta práctica en este tipo de procedimientos. Las sentencias, sin embargo, no mostraban las circunstancias en las que se llevaban a cabo estos acuerdos. Nos preguntamos: ¿En qué condiciones las MPG aceptaron tanto su responsabilidad de los hechos como los términos del acuerdo? ¿El juez ejerció un adecuado control de las condiciones, la tipicidad del hecho, la concurrencia de eximentes o atenuantes y la determinación de la pena? Para responder a estas interrogantes, nos adentramos en los expedientes judiciales.

Durante este análisis, notamos que, de los 15 casos estudiados, en 9 de ellos se utilizó la conclusión anticipada para llegar a una sentencia condenatoria. Uno de los expedientes que llamó poderosamente la atención es el caso de Elena, al cual le dedicamos varias líneas en este informe para ejemplificar de qué forma los operadores de justicia vulneran los derechos y garantías procesales de las MPG.

Elena fue intervenida y detenida por policías de un escuadrón especializado denominado "terna" al salir de un consultorio obstétrico, con evidentes signos de dolores ginecológicos. Ella señaló que se encontraba cursando un aborto y que acudió al EE.SS. privado para solicitar atención. Ahí le dijeron que presentaba un aborto infectado por lo que solicitó le realizaran un procedimiento. Una vez finalizada la intervención, le recetaron antibióticos y analgésicos adicionales, los que fueron incautados. Además de Elena, se procesó a la persona que gestionó el servicio de salud y su ayudante. Ambas fueron absueltas de los cargos por aborto consentido en la medida que:

> *no se encuentra acreditada la responsabilidad penal de la acusada por el delito de aborto consentido, ya que, del análisis de las pruebas aportadas por el Ministerio público no acredita que la acusada haya intervenido o coadyuvado en la practica abortiva. Por lo tanto, en tal virtud , ante la falta de pruebas corresponde dictar una sentencia absolutoria[90].*

Pese al sentido absolutorio de la argumentación del juez, la Fiscalía mantuvo la persecución penal en contra de Elena, sin mayores elementos de prueba que demostraran que ella causó su aborto o que se practicó un aborto en el consultorio intervenido. Las únicas pruebas citadas en el requerimiento de acusación que la "vinculan directamente" fueron: (i) el Acta de Entrevista Personal -tomada el día de la intervención y cuestionada posteriormente por su defensa debido a su carácter irregular-, (ii) el Certificado de Medicina Legal que concluía que "presenta signos presuntivos de embarazo y signos compatibles con maniobras abortivas", (iii) un parte policial que refiere como causa de ingreso al hospital la presencia de "sangrado genital, no signos de infección, no signos clínicos", (iv) un Dictamen Pericial de Análisis Químico que da positivo para MISOPROSTOL - que fue incautado a una de las trabajadoras del centro médico- y (v) un Dictamen Pericial de Biología Forense que halló restos hemáticos de origen humano pertenecientes al grupo sanguíneo "O", entre otros.

En la audiencia de requerimiento de acusación del 13 de marzo de 2019, el defensor designado expresó su desacuerdo con la solicitud de la Fiscalía de imponer una pena de 8 meses de prisión efectiva, así como con los medios de prueba presentados, resaltando que el Acta de Entrevista personal se elaboró por la PNP durante la intervención. El juez decidió no admitir este documento como prueba, siendo esta la única evidencia que podría implicar a la acusada, debido a las inconsistencias en la información registrada en la misma.

Aún con ello, la Fiscalía continuó impulsando el proceso y se llevó a cabo las audiencias correspondientes al juicio oral. Elena no asistió a la primera citación (19 de enero de 2021), por lo que Fiscalía -como mecanismo de apercibimiento- solicitó que se declare su contumacia y pidió al juez se ordene su captura. El juez de la causa dispuso ***"emitir las órdenes de captura en su contra a nivel nacional, las mismas que deben ser renovadas periódicamente, hasta que sea puesta a disposición del despacho".***

Elena fue detenida el 7 de junio de 2021 y al día siguiente se realizó el juicio oral. Ahí, su defensor público solicitó al juez alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para la conformidad de la sentencia, señalando además que Elena asumiría su culpabilidad. Sin demora, se emitió una sentencia con-

90. Sentencia analizada Nº17, MPG-2021-AQP, 17 de febrero 2021.

denatoria, derivada de una reserva de fallo condenatorio por un año, bajo la condición de cumplir las siguientes reglas de conducta: (i) comparecer al juzgado el primer día hábil de cada dos meses para informar y justificar sus actividades, (ii) pagar una reparación civil de 400 soles y (iii) abstenerse de cometer nuevos delitos dolosos, en especial el de aborto. Su incumplimiento resultaría en la revocación de la decisión y una pena privativa de libertad efectiva de 7 meses.

En el caso de Elena, la acción penal prescribió el 2 de abril de 2018. Es decir, antes (i) de que se emitiera el requerimiento acusatorio por parte de la Fiscalía, (ii) del inicio del juicio oral, (iii) de la orden de captura emitida por el juez, (iv) de su detención y (iv) dela emisión de la sentencia. Ni su defensa, ni la Fiscalía, ni el juez llevaron a cabo un control sobre los plazos.

Llama también la atención el cambio de postura de su defensa, quien inicialmente cuestionó la legalidad del accionar de la Fiscalía, las pruebas y la pena solicitada; para luego aconsejar a Elena aceptar la responsabilidad por los cargos imputados. Esta situación nos lleva a preguntarnos si la detención de Elena jugó un papel importante en el cambio de posición, y si es realmente posible concluir que ella aceptó el acuerdo con total libertad.

Para este punto, vale la pena considerar en el análisis que la pérdida de libertad se asocia a la idea de ser dominado y a la pérdida de agencia. Esta dominación va de la mano con la corrección, el castigo y el aislamiento de la persona(Escaff, Estévez, Feliú, & Torrealba, 2013, p. 296). Bajo esas condiciones, resulta improbable que una persona tome una decisión de manera libre, o que la misma que no esté mediada por las ganas de recuperar su libertad; aún cuando ello suponga asumir la responsabilidad sobre hechos que no ha cometido.

Este caso evidencia una vulneración del debido proceso de Elena, pues fue investigada y juzgada más allá del plazo estipulado por la ley, incluso vulnerando su derecho a la libertad tras la orden de captura en su contra. También evidencia que los jueces no realizan un control exhaustivo de legalidad en la conducción de los procesos, y mucho menos, de los mecanismos de terminación anticipada.

9.3. Vulneraciones identificadas en las decisiones judiciales

Las decisiones judiciales que ponen fin a los casos de aborto (sean condenas, absoluciones, prescripciones o autos de sobreseimiento) constituyen la fotografía final del proceso de criminalización. Aunque la principal limitación de esta fuente radica en su incapacidad de compartir a detalle el desarrollo del proceso, no es menos cierto que dan cuenta de las actuaciones adoptadas y las

omisiones incurridas a lo largo del recorrido penal. Además, ellas nos permiten conocer qué hechos del caso fueron considerados y cuáles fueron las razones que llevaron a los operadores de justicia a concluir en determinado sentido. Pero, sobre todo, nos da la oportunidad de conocer si los jueces o juezas a cargo se aproximaron al caso sin prejuicios, específicamente sin estereotipos de género.

Para poner en contexto, de los 15 expedientes analizados, 11 terminaron con una sentencia que declaraba la culpabilidad de la MPG procesada, 2 ratificaron su inocencia y en los 2 restantes se declaró la prescripción del proceso. De las 11 sentencias condenatorias, 9 fueron adoptadas en el marco de un Acuerdo de Terminación Anticipada que concluyeron en una reserva de fallo. Si bien en esta sección se analizan principalmente las decisiones que culminaron con el proceso penal, para los casos que llegaron a segunda instancia (Sala) se evalúan las decisiones de primer y segundo grado, debido a la riqueza de los argumentos allí expuestos. De manera excepcional, también hemos recogido algunas resoluciones que fueron adoptadas a lo largo del proceso para exponer la materialización del estereotipo de género.

A comparación de apartados previos, en esta sección las vulneraciones a los derechos humanos de las MPG procesadas por el delito de aborto tienen su génesis en un sólo hecho: los estereotipos de género. Sesgos que han comprometido la imparcialidad de jueces y juezas al desarrollar decisiones carentes de una adecuada motivación que además reflejan una presunción de culpabilidad de las MPG procesadas. En suma, decisiones que son producto de un proceso penal deficientemente conducido y colmados de vicios jurídicos, pero también de autoridades judiciales cuyo razonamiento se encuentra influenciado por creencias preconcebidas sobre el rol o la naturaleza de las mujeres.

9.3.1. Estereotipo de género: detonador de múltiples vulneraciones

El estereotipo de género puede ser entendido como la "pre-concepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente" (Corte IDH, 2016, párr. 187). En tanto su uso "se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer"(Corte IDH, 2009, párr. 401), su aplicación por parte de los operadores de justicia "puede constituir un elemento indicativo de la existencia de falta de imparcialidad" (Corte IDH, 2021, párr. 133), así como de la vulneración de otros derechos humanos.

De antemano, concluimos que el uso de estereotipos de género en los casos de aborto constituye una violación de múltiples derechos y garantias como (el i) el deber de motivación, (ii) principio de presunción de inocencia, (iii) el derecho a un juez imparcial y (iv) el derecho a la igualdad y no discriminación.

El principal estereotipo identificado en el razonamiento de los operadores de justicia fue aquel que impone a adolescentes y mujeres la "maternidad como un destino irrefutable". Es decir, aquel "que entiende el ejercicio de la capacidad reproductora de la mujer como un deber en vez de un derecho"

(Comité CEDAW, 2011, párr. 7.7). Un estereotipo que, como se verá posteriormente, se encuentra en la raíz de diversas expresiones. Así, en diferentes sentencias se resaltó que la MPG procesada no sólo había cometido un delito, sino que peor aún había incurrido en un acto socialmente "reprochable".

> **4.4. JUICIO DE CULPABILIDAD.** Asimismo, cabe señalar que la conducta de la acusada además de típica y antijurídica resulta reprochable, dado que pudo haber actuado de otra manera, vale decir respetando la integridad del concebido. Por otro lado, la

Básicamente, de acuerdo con algunos operadores de justicia peruana, las MPG no tenemos otra opción más que aceptar la maternidad, sea o no deseada. Otra manera en la que se manifestó este estereotipo fue a través del establecimiento de una preferencia del concebido por sobre la salud e integridad de la MPG, incluso si la acusada era una adolescente. Así, en el caso de Kari[91], la jueza que la condenó empleó los siguientes argumentos:

> *JUICIO DE ANTIJURICIDAD. Y la conducta desplegada por la acusada no sólo se contrapone o transgrede la norma penal en particular (antijuridicidad formal) sino también es opuesta al derecho en general (antijuridicidad material) que comprende el mandato de velar por la integridad y salud del concebido que lleva en su vientre, al margen de la existencia o no de una norma legal prohibitiva.*
>
> *La adolescente con su comportamiento atentó con el bien jurídico protegido como es la vida humana del embrión o feto, ya que la adolescente gestante no es titular del derecho a la vida del concebido, ella no puede disponer libremente de esa vida que lleva en sus entrañas.*

En este mismo caso, se advierte uno de los pasajes más impactantes de los expedientes analizados, ya que la operadora de justicia calificó como "egoísta" la decisión de Kari de interrumpir su embarazo por razones educativas, demostrando las ramificaciones del estereotipo que impone a las mujeres una maternidad inevitable.

> *Se trata pues de una adolescente de 17 años de edad, que realiza estudios superiores y es imposible desconocer que por sus estudio o por los medio de comunicación que publican temas similares desconozca que su conducta era ilícita, más aún si utiliza las páginas de internet fuente de conocimiento mundial, al cual accedió para informarse de las pastillas abortivas que ingirió provocándose el aborto; actuando a espaldas de su enamorado quien según palabras de la propia investigada se sorprendió de su acto ilícito cuando le comunicó lo que había hecho; ocultando a su familia su embarazo motivado por el único interés egoísta de no perjudicar sus estudios.*

El uso de este estereotipo también dejó rastros en el uso del lenguaje utilizado por los operadores de justicia, quienes adoptaron términos propios de otros tipos penales, desnaturalizando así el

91. Expediente analizado Nº 12, MPG-2017-LIM.

delito de autoaborto y revistiéndolo de un carácter homicida.

> *COMPORTAMIENTO TÍPICO: Comete delito de autoaborto, la mujer embarazada que voluntariamente, se somete a prácticas abortivas con el objetivo primordial de poner fin a su embarazo aniquilando su producto, en consecuencia debemos concluir que el delito se perfecciona en el momento que se verifica tal objetivo.*

> *5. […] Siendo necesario comprobar que la adolescente tuvo aptitud e idoneidad objetiva para matar al concebido.*

Peor aún, en un caso, el juez a cargo realizó una interpretación errónea de los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado peruano. al afirmar que la protección del derecho a la vida del concebido es absoluta.

> *Por eso cuando la mujer se provoca el aborto o consciente que otro se lo practique será sancionado penalmente de acuerdo a nuestra legislación nacional, sujeta a convenios internacionales, leyes que protegen la vida del concebido [...] En cuanto al Derecho Internacional, la obligatoriedad de los tratados se fundamenta en los principios de buena fe y pacta sunt servanda. Los compromisos internacionales asumidos deben ser respetados. No cabe desconocer lo previsto por las normas internacionales protectoras de los Derechos Humanos. No se trata de un cuestionamiento moral, sino esencialmente jurídico.*

Ahora bien, es importante tomar en cuenta que el uso de estereotipos también perjudica otras dimensiones del proceso penal. En efecto, a partir de la lectura de los expedientes, pudimos advertir que los estereotipos afectaron la credibilidad del testimonio de las MPG procesadas, los cuales fueron incluso dejados de lado. Asimismo, producto de ellos, los administradores de justicia desconocieron documentación clave para la valoración de los hechos, así como ignoraron y convalidaron una serie de vicios procesales.

En diferentes sentencias, los testimonios de las MPG procesadas fueron ignorados o considerados falsos. En uno de ellos, la acusada señaló en su testimonio dos hechos relevantes para el caso: (i) haber experimentado amenazas de aborto previamente a la ingesta de pastillas y (ii) que las pastillas fueron ofrecidas con engaños por su pareja y cuya procedencia además le era desconocida. Ninguno de estos elementos fue considerado por la justicia peruana. Por el contrario, valiéndose del Acuerdo de Terminación Anticipada, se concluyó en la culpabilidad de la MPG procesada sin que la administración de justicia cuestionara la ausencia de medios probatorios. Tampoco es un dato menor que a la pareja nunca se le inició una investigación penal.

En el caso de **Oriana**[92] se pudo advertir que, a pesar de la insuficiencia de medios probatorios que demuestren el nexo de causalidad, la jueza a cargo se apoyó en la calificación de la Historia Clínica de los hechos como un "aborto en curso" para condenar a la MPG procesada. Una categoría que,

92. Expediente Nº 14 analizado, MPG-2016-LIM.

cabe destacar, no describe por sí misma la comisión de un delito. Asimismo, se valió del hallazgo de una pastilla hexagonal, cuyo uso abortivo no fue sustentado. El testimonio de la MPG que afirmaba desconocer que se encontraba embarazada, sin embargo, fue considerado como falso. Y es que para la jueza era "absurdo que no haya conocido del estado de gravidez en el que se encontraba, dado que, conforme es de verse tenía 20 semanas de gestación".

En el caso de **Lita**[93], que, producto de una violación sexual, quedó embarazada se advierte que, a diferencia de los otros casos su testimonio sí fue valorado por la administración de justicia. Su declaración, sin embargo, fue utilizada para perseguirla penalmente luego de haber mencionado en una Cámara Gesell -un espacio destinado a evitar la revictimización de las sobrevivientes de violencia sexual- que no quería ser mamá.

En ninguno de estos casos existían pruebas que vinculen a la MPG procesada con los hechos denunciados, lo que demuestra la presunción de culpabilidad como principio que orienta la conducción del proceso penal y la valoración de los testimonios de las MPG investigadas. Una creencia que, además, lleva a los operadores de justicia a desconocer hechos relevantes para el proceso. En otros casos, la autoincriminación de la MPG se constituye como prueba irrefutable de su culpabilidad, siendo irrelevante si fue obtenida vulnerando las garantías procesales mínimas de un proceso penal.

Por otro lado, advertimos que los estereotipos de género impiden a la administración de justicia siquiera considerar las condiciones de vulnerabilidad de la persona investigada. En el caso de **Ina**[94]**,** una mujer analfabeta y sorda que fue sentenciada, ninguno de estos factores fue considerado para la evaluación de su culpabilidad o imputabilidad, lo que contribuyó a la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación de la MPG acusada.

> Sobre la *imputabilidad*, cabe indicar que la acusada no padece de ninguna limitación de carácter psíquica o mental que eventualmente pueda enervar su responsabilidad penal; por el contrario, en juicio oral han denotado ser una persona con plena capacidad de ejercicio, tal como se ha podido apreciar en el acto del juicio oral (principio de inmediación), lo cual permite concluir que es una persona imputable. Respecto al segundo elemento *conocimiento del injusto*, cabe indicar que la acusada estaba en plena capacidad de advertir el carácter delictuoso de su conducta. Finalmente, respecto al tercer elemento, esto es la *exigibilidad de la conducta de la acusada*, es preciso señalar que no se le exigía ningún comportamiento heroico o extraordinario, sino el de una persona común y corriente. En tal sentido la conducta dela acusada es reprochable.

La persistencia de estereotipos de género en los procesos judiciales relacionados con el aborto en el Perú constituye una grave violación de múltiples derechos fundamentales. Estos estereotipos no solo afectan el deber de motivación y el principio de presunción de inocencia, sino que también comprometen el derecho a un juez imparcial y el derecho a la igualdad y no discriminación. El más prominente de estos estereotipos es el que impone la maternidad como destino inevitable para las mujeres, transformando el ejercicio de su capacidad reproductiva en un deber, en lugar de un derecho. Esta visión se refleja en sentencias judiciales que condenan a las mujeres no solo por el acto de haber abortado, sino también por contravenir una supuesta norma social que prioriza la maternidad por encima de sus derechos y decisiones personales.

93. Expediente Nº 15 analizado,MPG-2019-APU.
94. Expediente analizado Nº 10, MPG-2021-AQP-RBC.

Además, el uso de estos estereotipos influye negativamente en la credibilidad de los testimonios de las mujeres procesadas, lleva a la ignorancia de documentación crucial, y convalida múltiples vicios procesales. Los testimonios de las mujeres procesadas son frecuentemente desestimados o considerados falsos sin pruebas suficientes, mientras que las condiciones de vulnerabilidad de las acusadas, como analfabetismo o discapacidades, no son tomadas en cuenta. Este enfoque judicial refleja una presunción de culpabilidad que guía la conducción de los procesos penales y vulnera las garantías procesales mínimas.

En resumen, los estereotipos de género no solo distorsionan el juicio legal, sino que también perpetúan una injusticia sistémica contra las MPG en situaciones de aborto.

Tabla 9.1. Estereotipos de género identificados en las sentencias y expedientes

Estereotipo de género	Cómo se manifiesta	Dónde se manifiesta
La maternidad como destino irrefutable de las MPG.	• Reproche de no haber continuado con el embarazo. • Calificación peyorativa de MPG que decidieron interrumpir su embarazo. • Imposición de reglas de conducta sin relación con los hechos.	• Descripción de los hechos. • Calificación jurídica. • Motivación jurídica. • Determinación de pena y reparación civil desmesuradas. • Reglas de conducta impuestas.
El embarazo como proceso conocido y evidente para las MPG.	• Deber de conocer el embarazo y sus síntomas por el hecho de tener un útero y sin importar el tiempo de gestación. • Cuestionamiento de la declaración de la MPG cuando alega desconocimiento del embarazo. • Falta de consideración de la declaración de la MPG cuando alega desconocimiento del embarazo.	• Juicio de subsunción. • Motivación jurídica. • Determinación de pena y reparación civil desmesuradas.

La protección del feto debe prevalecer sobre la vida y/o salud de la madre.	• Falta de consideración de la declaración de la MPG cuando alega que la interrupción del embarazo responde a causas terapéuticas. • Aplicación del DIDH contraria a los estándares internacionales vigentes. • Descripción del delito de auto-aborto como acto homicida. • Falta de consideración de la condición socioeconómica de la MPG.	• Juicio de subsunción. • Motivación jurídica. • Determinación de pena y reparación civil desmesuradas. • Reglas de conducta impuestas.
Las MPG que abortan no dicen la verdad.	• Falta de consideración de la declaración de la MPG cuando alega hechos de violencia o hace referencia a indicios de aborto forzado. • Falta de consideración de la declaración de la MPG cuando alega desconocimiento del embarazo. • Falta de consideración de la declaración de la MPG cuando alega desconocimiento del medicamento ingerido.	• Juicio de subsunción. • Motivación jurídica. • Determinación de pena y reparación civil desmesuradas.

Conclusiones

Sobre los procesos penales

- Los procesos penales por aborto en Perú generalmente inician en hospitales, donde se produce la medicalización y judicialización de los casos. Los establecimientos de salud actúan como la puerta de entrada al sistema de justicia penal, marcando el inicio de un proceso que a menudo está plagado de vulneraciones a los derechos de las mujeres y personas procesadas.
- Estos procesos se caracterizan por vulneraciones a los derechos y garantías procesales, presentando múltiples vicios que los tornan arbitrarios e inciertos. Las mujeres y personas procesadas enfrentan procedimientos legales que no respetan los estándares mínimos de justicia, lo cual agrava su situación de vulnerabilidad.
- Un rasgo distintivo de estos procesos es su naturaleza revictimizante, cargada de estereotipos y sesgos de género. Las mujeres son objeto de castigo y disciplinamiento por parte de los operadores de justicia, lo que materializa el estigma social asociado al aborto y perpetúa percepciones negativas sobre la autonomía femenina.
- La autoincriminación es un elemento recurrente en estos procesos. Las mujeres, a menudo en situaciones de alta vulnerabilidad, se autoincriminan, lo cual es reforzado por estrategias de defensa que promueven la aceptación de culpabilidad con la promesa de una terminación anticipada del proceso. Esto desnaturaliza la finalidad del proceso penal, que debería ser investigar el delito y determinar la culpabilidad de manera justa.
- La falta de predictibilidad y garantías del debido proceso se ve exacerbada por los sesgos y estereotipos de género presentes entre los operadores de justicia. Los jueces, a menudo, actúan como meras "mesas de partes", aprobando acuerdos sin evaluar ni controlar debidamente las garantías procesales, lo que resulta en una falta de control de legalidad.
- Los procesos judiciales conllevan un empobrecimiento para las mujeres procesadas, debido a los costos adicionales en defensa legal, disposición de tiempo y otros recursos, incluso cuando cuentan con defensores públicos. Esta situación agrava su precariedad económica y limita aún más su acceso a una justicia equitativa.

Sobre las personas imputadas

- Las mujeres criminalizadas por aborto en Perú generalmente se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica, etaria y racial. Estas mujeres, a menudo empobrecidas y con limitada autonomía reproductiva, enfrentan procesos judiciales en un contexto de desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos y de los procesos fisiológicos de su propio cuerpo.
- La persecución penal se inicia en momentos de alta vulnerabilidad, cuando las mujeres acuden a centros de salud por complicaciones derivadas de un aborto o emergencias obstétricas. En estas circunstancias de estrés y temor, son presionadas para autoincriminarse, lo que inicia un proceso penal en su contra.

- El acceso limitado a una defensa legal eficiente es una característica común entre las mujeres procesadas. Su situación de vulnerabilidad económica y cultural las obliga a confiar en defensores públicos, quienes frecuentemente las conducen hacia la autoincriminación y la terminación anticipada del proceso, sin un análisis exhaustivo de los medios probatorios.

Sobre los efectos de la criminalización

- El estigma social y la amenaza de criminalización resultan en un aislamiento significativo para las mujeres procesadas. Esta situación de soledad y el quiebre en sus vínculos de soporte emocional agravan los síntomas de salud mental, llevando a un deterioro en su calidad de vida y en sus oportunidades laborales, relacionales y económicas.
- Los impactos de los procesos penales por aborto son profundos y multidimensionales, afectando la salud mental, emocional y económica de las mujeres. La criminalización del aborto desencadena una espiral de efectos negativos que mina profundamente el bienestar integral de las imputadas, afectando sus proyectos de vida y oportunidades futuras.

Sobre los factores que mitigan o agravan los procesos de criminalización

- Los factores que mitigan o agravan los efectos de la criminalización del aborto incluyen la seguridad de los procedimientos, el acceso a información, el nivel socioeconómico, la calidad de la defensa legal, el soporte del entorno cercano, los prejuicios en los operadores públicos y el tiempo de gestación. Factores protectores, como procedimientos seguros y acceso a información confiable, pueden reducir las consecuencias adversas, mientras que la falta de estos recursos y la proximidad al tercer trimestre de gestación, agravan la situación de las imputadas.

Recomendaciones

Al Ministerio de Salud

- Incorporar en la Norma Técnica de Salud para la Prevención y Eliminación de la Violencia de Género en los Establecimientos de Salud que brinden Servicios de Salud Sexual y Reproductiva, el reconocimiento de la violencia obstétrica en la atención de abortos y emergencias ginecoobstétricas. Esto debe incluir, con especial énfasis, la prohibición de interrogatorios o diligencias en las salas de emergencia de los hospitales, así como la garantía del respeto al secreto profesional.
- Desarrollar programas de capacitación sobre el marco normativo aplicable a la atención de emergencias obstétricas dirigido al personal de salud, enfatizando los derechos que asisten a las mujeres usuarias de los servicios de salud. Especialmente aquellos que se encuentran comprendidos en la Ley Nº 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias en los servicios de salud.
- Realizar programas de sensibilización sobre los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y MPG destinado a personal de salud.
- Impartir programas de actualización para el tratamiento de abortos que consideren los estándares más actualizados en la materia, como los desarrollados en las "Directrices sobre la atención para el aborto" de la OMS (2022).
- Implementar un mecanismo de transparencia activa que suministre la información necesaria para el ejercicio de los derechos de las usuarias del servicio de salud, lo que incluye poner en su conocimiento el derecho a contar con una defensa, a la no autoincriminación, al aborto terapéutico, entre otros en los servicios de emergencia.
- Implementar programas de formación para el personal de salud que fortalezcan el conocimiento y la aplicación de los principios éticos sobre el secreto profesional y la confidencialidad en la atención médica en la atención de emergencias obstétricas.

A la Policía Nacional del Perú

- Llevar a cabo un programa de capacitación que aborde cómo realizar diligencias preliminares considerando el marco normativo vigente, prestando especial atención a la prohibición de entrevistar o detener a las MPG en los EE.SS. en tanto se vulneran las garantías procesales y los derechos de las personas investigadas.
- Abstenerse de publicar en sus redes sociales y otras plataformas virtuales las fotografías de MPG acusadas del delito de aborto, lo que configura una violación a sus derechos.

Al Ministerio Público

- Asegurar que los y las fiscales a cargo de la persecución de los delitos de aborto garanticen una investigación conforme con el marco normativo vigente, especialmente aquel vinculado a

las garantías procesales para el recojo de pruebas. En particular, en la toma de declaraciones en casos que involucren el delito de aborto, con especial énfasis en niñas y adolescentes.

Al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos

- Garantizar la formación y actualización continua de los y las profesionales que ejercen la defensa pública, con énfasis en las garantías del debido proceso que le asisten a las personas procesadas.
- Mejorar sus estrategias de defensa de personas incriminadas por el delito de aborto a fin de garantizar procesos judiciales justos y el respeto irrestricto de su derecho al debido proceso.
- Dejar de promover acuerdos de terminación anticipada en procesos con vicios en el proceso penal.

Al Poder Judicial

- Inaplicar el artículo 30 de la Ley General de Salud, la cual vulnera el derecho a la confidencialidad de la atención médica y el secreto profesional.
- Impulsar investigaciones a nivel interno que tengan como fin fiscalizar el cumplimiento del control de legalidad de los jueces y juezas en los casos de aborto.
- Fortalecer los esfuerzos en materia de capacitación de jueces penales y de familia sobre las garantías del debido proceso que les asisten a las MPG procesadas, con énfasis en garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia, estereotipos de género, enfoque de niñez y adolescencia a fin de garantizara procesos judiciales justos.
- Incluir en el "Protocolo de administración de justicia con enfoque de género del Poder Judicial" la evaluación de los casos de aborto desde un enfoque de género.
- Publicar en sus portales de transparencia todas las sentencias judiciales -incluyendo las de aborto-, dictámenes fiscales y jurisprudencia sistematizada de fácil acceso por materias, con una sumilla en lenguaje sencillo y amigable, tal como lo establece el artículo 39 de la Ley No. 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Al Ministerio de Educación

- Adoptar programas educativos inclusivos, accesibles y basados en evidencia científica que proporcionen información precisa y objetiva sobre temas relacionados con la sexualidad, la reproducción, la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual y violencia, la identificación de hechos de violencia, así como sobre los derechos sexuales y reproductivos.

Al Congreso de la República

- Despenalizar el aborto voluntario. Ello supone eliminar del ámbito de la competencia penal los abortos voluntarios y otros eventos obstétricos mediante la derogación de los artículos 114 (autoaborto), 115 (aborto consentido), 117 (agravación de la pena por la calidad del sujeto), 119 (aborto terapéutico) y 120 (aborto sentimental y eugenésico).
- Reformar el artículo 30 de la Ley No. 26842, Ley General de Salud a fin de proteger el deber de confidencialidad en la atención de abortos y emergencias obstétricas.

A la Defensoría del Pueblo

- Impulsar acciones de supervisión a EE.SS. públicos a nivel nacional sobre los servicios de atención en casos de aborto.

Al Colegio Médico del Perú

- Emitir directrices claras para garantizar que el personal de salud respete el secreto profesional y la confidencialidad en casos de aborto y emergencias obstétricas, evitando prácticas que vulneren los derechos de las pacientes.

A los donantes

Combatir el estigma frente al aborto

- Fomentar un diálogo abierto y libre en el ámbito público sobre el tema del aborto es crucial para superar la arraigada cultura de la penalización y promover el respeto a la autonomía reproductiva. Este diálogo debe orientarse a fortalecer la solidaridad hacia las mujeres que enfrentan eventos obstétricos, visibilizar la cotidianeidad de estos sucesos, así como los obstáculos que atraviesan. La visibilización de estas realidades puede contribuir a desestigmatizar el tema, fomentar la empatía y el apoyo comunitario hacia las MPG.

Acompañamiento y redes de soporte para personas criminalizadas

- Fortalecer y fomentar los espacios de acompañamiento feminista para personas que atraviesan por situaciones de aborto. Este acompañamiento debe proporcionar un entorno seguro donde las personas puedan recibir apoyo emocional y práctico, involucrando a sus familias y seres queridos en el proceso legal. Además, es crucial promover la creación de redes de apoyo y acompañamiento específicamente diseñadas para personas criminalizadas por aborto, ofreciendo espacios donde puedan compartir sus experiencias y recibir respaldo emocional y legal.

Acceso defensa especializada y feminista

- Se deben fortalecer los servicios que brindan patrocinio legal especializado para la defensa de casos con el fin de garantizar que las personas imputadas reciban apoyo y una representación legal eficaz durante todo el proceso legal.

Generación de evidencia para el diseño de políticas

Realizar investigaciones continuas para monitorear y profundizar en la comprensión del problema y diseñar políticas basadas en evidencia. De manera preliminar, identificamos estos campos que requieren estudios en mayor profundidad:

- Los mecanismos de actuación del sistema de salud y de justicia en el abordaje de eventos obstétricos que son investigados y sentenciados por el delito de infanticidio[95].
- La criminalización del aborto en infancias y adolescencias en el contexto peruano podría explorar cómo las leyes restrictivas afectan a este grupo demográfico específico. Esto incluiría examinar cómo las adolescentes acceden a información sobre salud sexual y reproductiva, cómo perciben el estigma asociado al aborto y cómo la criminalización impacta su acceso a servicios de salud seguros y legales.
- Las consecuencias a largo plazo de la criminalización del aborto en Perú serían cruciales para comprender el impacto social, económico y de salud pública de estas políticas. Esta investigación podría analizar datos longitudinales para examinar cómo la criminalización afecta la salud física y mental de las mujeres, así como su bienestar social y económico a lo largo del tiempo.
- El gasto público de la criminalización del aborto en Perú permitiría evaluar los recursos financieros dedicados a la persecución y enjuiciamiento de casos de aborto en el sistema judicial. Esto incluiría el costo de investigaciones, juicios, encarcelamiento y otros recursos utilizados y cómo estos recursos podrían ser redistribuidos para abordar de manera más efectiva las necesidades de salud sexual, reproductiva y no reproductiva de la población.
- La incidencia de psicopatologías a partir de la criminalización del aborto en Perú exploraría cómo las leyes restrictivas y el estigma social asociado pueden contribuir al desarrollo de cuadros clínicos de salud mental en las mujeres que enfrentan situaciones de aborto. Esto incluiría examinar el estrés psicológico, la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales relacionados con la criminalización del aborto y cómo afectan la calidad de vida de las mujeres.
- Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas en torno al aborto con misoprostol, enfocado en mujeres y personas gestantes, así como identificar las fuentes de información por las que se acceden a dicha información. Se recomienda un enfoque mixto, con un componente cuantitativo que pueda ser representativo de las mujeres peruanas o, al menos, de una región.
- Investigar la experiencia de las usuarias en la atención de eventos obstétricos en Perú proporcionaría información crucial sobre cómo las mujeres enfrentan situaciones de aborto espontáneo o inducido en los servicios públicos y privados de salud. Este estudio podría examinar los

95. Infanticidio. Artículo 110.- La madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, o con prestación de servicio comunitario de cincuentidós a ciento cuatro jornadas.

obstáculos y desafíos que enfrentan las mujeres al buscar atención médica, así como sus experiencias de estigma, discriminación y comprender los puntos de dolor de dicha experiencia.

- Un estudio de caso en fiscalías de distritos fiscales con alto índice de criminalización del aborto en Perú, como Apurímac, permitiría examinar cómo se implementan los procesos penales por aborto. Esto incluiría analizar datos judiciales, entrevistar a fiscales, policías, abogados y demás actores involucrados en la persecución del aborto, y examinar la experiencia de la criminalización en las mujeres acusadas de aborto en dichos distritos fiscales.

Bibliografía

Ariza, S., Bohórquez, V., Brown, J., Chávez, S., Díaz, C.,Morán, J., López, A., Pecheny, M., Petracci, M., Ramón, A., Ramos, S. y Zamberlin, N. (2015). *Investigación sobre aborto en América Latina y El Caribe : una agenda renovada para informar políticas públicas e incidencia* / compilado por Silvina Ramos. - 1a ed . Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Centro de Estudios de Estado y Sociedad-CEDES ; México, DF : Population Council ; Lima : Promsex. https://www.clacaidigital.info/bitstream/handle/123456789/661/investigacion%20sobre%20aborto%20en%20XL.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Ascarza, L., & Torres, F. (2022). Perseguidas por abortar: De la sala de emergencias al juzgado por un aborto. Salud con Lupa. Recuperado de https://saludconlupa.com/series/perseguidas-por-abortar/de-la-sala-de-emergencias-al-juzgado-por-un-aborto/

Bard Wigdor, G., Johnson, M. C., & Vaggione, J. M. (2017). *Prácticas tuteladas: masculinidad y adultocentrismo en la decisión del aborto*. Revista de Ciencias Sociales, 20-44

Bejarano, M. & Acedo, L. (2014). *Cuerpo y violencia: regulación del aborto como dispositivo de control a las mujeres.* Región y sociedad, 26(4), 261-283.

Camila Gianella, Jorge Ruiz-Cabrejos, Pamela Villacorta, Andrea Castro, Gabriel Carrasco-Escobar (2021). *Revertir cinco años de progreso: El impacto de la covid-19 en la mortalidad materna en Perú.* CMI Brief no. 2021:2.

Caparachin, C., Martínez, S. P., Matos, R. C., & Ruiz, R. (2017). Justicia juvenil diferenciada. Hacia una atención con mayores oportunidades para adolescentes en conflicto con la ley penal. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Publicacio%CC%81n%20NU%20FINAL_OK_VIRTUAL_0.pdf

Cuba, L.; Alvarez, B.; Encalada, F; Gallo, M.; Goñez, E. (2023) Voces que rompen estigmas Investigación testimonial sobre mujeres de Ayacucho, Lima y Ucayali que han abortado. Movimiento Manuela Ramos.

Cuba, L.; Gallo, M.; Goñez, E.; Vargas, E.; Vargas. N; Encalada, F. (2022). Nacer con útero: Efectos de la criminalización del aborto en el Perú. Asociación Civil Proyecta Igualdad.

Dador, M. (2012). *El aborto terapéutico en el Perú*. Promsex

Danet, A. (2021). Experiencias emocionales en la interrupción voluntaria del embarazo. Gaceta Sanitaria, 35(4), 361-373. Epub 27 de diciembre de 2021.https://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.02.006

Defensoría del Pueblo. (2018). Policía, Ministerio Público y Poder Judicial deben proteger el derecho de presunción de inocencia. https://www.defensoria.gob.pe/policia-ministerio-publico-y-poder-judicial-estan-obligados-a-proteger-el-derecho-fundamental-a-la-presuncion-de-inocencia/

Despouy, L. (2008). Acceso a la justicia: impacto de la pobreza sobre los derechos humanos. En Defensoría General de la Nación (Ed.), Defensa pública: garantía de acceso a la justicia (pp. 128). Defensoría General de la Nación. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26687.pdf

Escaff, S. E., Estévez, M. I., Feliú, V. M., & Torrealba, H. C. A. (2013). Consecuencias psicosociales de la privación de libertad en imputados inocentes. Revista Criminalidad, 55(3), 296.

El País. (2004). *El Tribunal de Estrasburgo dictamina que un feto no es un ser humano con derecho a la vida.* https://elpais.com/sociedad/2004/07/08/actualidad/1089237602_850215.html

Gianella, G. (2011). El sentido y la importancia del secreto profesional desde la medicina En J. Apolaya (Coord.) *Secreto profesional: Análisis y perspectiva desde la medicina, el periodismo y el derecho* (Primera edición, pp. 65-98).

Hall, S. (2010). *Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales.* Instituto de Estudios Peruanos.

Human Right Watch. (2022). *El acceso al aborto es un derecho humano.* https://www.hrw.org/es/news/2022/06/28/el-acceso-al-aborto-es-un-derecho-humano

IOP - PUCP. (2019). *El aborto en cifras: Encuesta a mujeres en el Perú.* Promsex.

IRCA. (2023). Iniciativa Regional para la Investigación del Impacto de la Criminalización del Aborto y otros Eventos Obstétricos.

Ipsos. (2023). *Miradas globales del aborto: Una encuesta Global Advisor en 29 países*. Recuperado de https://www.ipsos.com/en/global-advisor-abortion-2023

Juárez-Chávez, EVillalobos, J. , Carrasco, R., Guerrero, R. & Chávez, S. (2023). *Exploring the prevalence of abortion and its characteristics in Perú*. Contraception, pp. 1 - 5. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2023.110115

López, A. (2016). *Tensiones entre lo (i) legal y lo (i) legítimo en las prácticas de profesionales de la salud frente a mujeres en situación de aborto.* Salud colectiva, 12, 23-39.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Programa Aurora. (2022). Cartilla estadística Enero - Diciembre 2022: Cifras de Violencia contra las Mujeres. N°. 12, 2022. https://portalestadistico.aurora.gob.pe/wp-content/uploads/2023/01/Cartilla-Estadistica-AURORA-Diciembre-2022.pdf

Nakazaki Servigón, C. A. (2006). La garantía de la defensa procesal: Defensa eficaz y nulidad del proceso penal por indefensión (p. 18).

Ojo Público. (2022). *Lo que dicen sobre el aborto los compromisos internacionales del Perú.* https://ojo-publico.com/ojobionico/explicador-lo-que-dicen-sobre-el-aborto-los-compromisos-del-peru#:~:text=Comit%C3%A9s%20de%20siete%20convenciones%20de,por%20causal%20de%20violaci%C3%B3n%20sexual.

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). Directrices sobre la atención para el aborto: Resumen ejecutivo (p. 11). https://www.who.int/publications/i/item/9789240041583

Peralta, M. (2013). Discusiones inacabas: la maternidad y el aborto, tensiones entre derechos reproductivos. Tesis de Licenciatura.

Salinas, Ramiro (2006). Sobreseimiento en el Código Procesal Penal de 2004.

https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3761_06sobreseimiento.pdf

San Martín Castro, C. (2020). Derecho procesal penal: Lecciones (2ª ed., p. 1149). Gaceta Jurídica.

San Martín, R. (2014). Contra la objetividad. El mito de la neutralidad periodística y las alternativas para repensarlo. Perspectivas de la Comunicación-ISSN 0718-4867, 1(1), 73-80.

UNESCO. (2014). Educación integral de la sexualidad: conceptos, enfoques y competencias. http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/4458/Educaci%c3%b3n%20integral%20de%20la%20sexualidad%20conceptos%2c%20enfoques%20y%20competencias.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vacarezza, N. (2012). Política de los afectos, tecnologías de visualización y usos del terror en los discursos de los grupos contrarios a la legalización del aborto. Papeles de Trabajo 6 (10), 46-61.

Villegas, O. R. T., & Castro, J. L. A. (2018). Modelo del proceso de influencia de los medios de comunicación social en la opinión pública. Educere, 22(71), 179-191.

World Health Organization. (1995). Complications of abortion: Technical and managerial guidelines for prevention and treatment (p. 19). Geneva: World Health Organization.

Zavala, V.; De los Heros, S. (Editor); Niño-Murcia, M. (Editor). (2012). El análisis crítico del discurso. En Fundamentos y modelos del estudio pragmático y sociopragmático del español. (pp. 163 - 186). WASHINGTON D. C. Georgetown University Press

Jurisprudencia nacional

Corte Suprema de Justicia de la República. (2008). Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116. IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial: Nuevos alcances de la conclusión anticipada. Considerando 8, 11 y 14.

Tribunal Constitucional (2003). Sentencia, Expediente N.º 1480-2003-HD/TC(Fundamento jurídico 3). Recuperado de:https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/01480-2003-HD.html

Tribunal Constitucional (2004). Sentencia N.º 0134-2003-HD/TC. Recuperado de: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00134-2003-HD.html

Tribunal Constitucional (2005). Sentencia N.º 7811-2005-PA/TC Recuperado de:https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/07811-2005-AA.pdf

Tribunal Constitucional del Perú (2006a). Sentencia No. 047-2004-AI/TC.Recuperado de https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00047-2004-AI.html#_ftn40

Tribunal Constitucional del Perú (2006b). Sentencia No. 0025-2005-PI/C y 0026-2005-PI/TC. Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-AI%2000026-2005-AI.pdf

Tribunal Constitucional. (2007). Sentencia Nº 1014-2007-PHC/TC. Recuperado de:https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/01014-2007-HC.html

Tribunal Constitucional del Perú. (2014). Sentencia No. 04617-2012-PA/TC. Recuperado de https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/04617-2012-AA.html

Tribunal Constitucional.Sala 2. (2022). Sentencia N.° 05246-2022-HC/TC. Recuperado de: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2023/05246-2022-HC.pdf

Jurisprudencia e instrumentos internacionales

Comité contra la Tortura (21 de enero de 2013). Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Perú, aprobados por el Comité en su 49º período de sesiones (29 de octubre a 23 de noviembre de 2012). CAT/C/PER/CO/5-6. Recuperado de: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FPER%2FCO%2F5-6&Lang=en

Comité contra la Tortura (18 de diciembre de 2018). Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico del Perú. CAT/C/PER/CO/7. Recuperado de: https://www.ohchr.org/es/documents/concluding-observations/concluding-observations-seventh-periodic-report-peru

Comité de Derechos Humanos (22 de noviembre de 2005). Comunicación No. 115/2003. CCPR/C/85/D/1153/2003. Recuperado de: https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhstcNDCvDan1pXU7dsZDBaDUczAnaR4lHcz8a0P%2BoOgLwA8uuhj0x2ZVGxkXprSuJPXZNZEyd3NO7cFEDXd%2BLp0OW66MaPoQ%2B51My3jCsiuxZB8OJS9q5UVp5SI5NqjQ05JiyWEcsqq0ueCXUdDIEDVM%3D

Comité de Derechos Humanos (29 de abril de 2013). Observaciones finales sobre el quinto informe periódico del Perú, aprobadas por el Comité en su 107º período de sesiones (11 a 28 de marzo de 2013). CCPR/C/PER/CO/5. Recuperado de: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/PER/CO/5&Lang=Sp

Comité de los Derechos del Niño (2 de marzo de 2016). Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Perú. CRC/C/PER/CO/4-5. Recuperado de: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/PER/CO/4-5&Lang=Sp

Comité de los Derechos del Niño (13 de junio de 2023). Dictamen aprobado por el Comité en relación con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, respecto de la comunicación núm. 136/2021. CRC/C/93/D/136/2021. Recuperado de: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2F93%2FD%2F136%2F2021&Lang=en

Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (30 de mayo de 2012). Observaciones finales sobre los informes periódicos combinados segundo a cuarto del Perú, aprobadas por el Comité en su 48º período de sesiones (30 de abril a 18 de mayo de 2012). E/C.12/PER/CO/2-4. Recuperado de: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/PER/CO/2-4&Lang=Sp

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (2 de febrero de 2007). Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Perú. CEDAW/C/PER/CO/6. Recuperado de: https://www.ohchr.org/es/documents/concluding-observations/concluding-comments-committee-elimination-discrimination-9

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (25 de noviembre de 2011). Comunicación No. 22/2009. CEDAW/C/50/D/22/2009. Recuperado de: https://www2.ohchr.org/english/law/docs/cedaw-c-50-d-22-2009_sp.pdf

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (24 de julio de 2014). Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados del Perú. CEDAW/C/PER/CO/7-8. Recuperado de: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10923.pdf*

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1 de marzo de 2022). Observaciones finales sobre el noveno informe periódico del Perú. CEDAW/C/PER/CO/9. Recuperado de: https://www.ohchr.org/es/documents/concluding-observations/cedawcperco9-concluding-observations-ninth-periodic-report-peru

Consejo de Derechos Humanos (27 de diciembre de 2012). Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: Perú. A/HRC/22/15. Recuperado de: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g12/190/43/pdf/g1219043.pdf?token=AFDAIjbAEHJK9c4UBl&fe=true

Consejo de Derechos Humanos (27 de diciembre de 2017). Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: Perú. A/HRC/37/8. Recuperado de: https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F37%2F8&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False

Consejo de Derechos Humanos (5 de abril de 2023). Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: Perú. A/HRC/53/8. Recuperado de: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g23/036/20/pdf/g2303620.pdf?token=QZ88AS79CD0bQhmODw&fe=true

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). (2009). Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (párr. 401). Serie C No. 205. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). (2016). Caso I.V. Vs. Bolivia. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (párr. 187). Serie C No. 329. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_329_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). (2021). Caso Manuela y otros Vs. El Salvador. Sentencia de 2 de noviembre de 2021. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (párr. 206). Serie C No. 441. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_441_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). (2022). Caso Brítez Arce y otros. vs. Argentina. Sentencia de 16 de noviembre de 2022. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C Nº 474. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_474_esp.pdf

Anexos

Anexo 1. LISTA DE ACRÓNIMOS

AOE	Anticonceptivo Oral de Emergencia
CPP	Código Procesal Penal
Comité CEDAW	Comité para la Eliminación de la discriminación contra la Mujer
DIDH	Derecho Internacional de los Derechos Humanos
DIRINCRI	Dirección de Investigación Criminal
DIRTIC	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
EE.SS.	Establecimientos de Salud
EsSalud	Seguro Social de Salud del Perú
Guía IVITE	Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119º del Código Penal
INPE	Instituto Nacional Penitenciario
LIO	Ley de Igualdad de Oportunidades
PNIG	Política Nacional de Igualdad de Género
PNP	Policía Nacional del Perú
PRONACEJ	Programa Nacional de Centros Juveniles
MPFN	Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
MPG	Mujeres y Personas Gestantes
MIMP	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

MINJUSDH	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
MINSA	Ministerio de Salud

Anexo 2. Entidades públicas a las cuales se les solicitó información cuantitativa, sentencias y expedientes

2.1. Se solicitó información cuantitativa respecto a delitos de aborto no forzado de los años 2012 a 2022 a las siguientes entidades públicas:

Nro	Entidad
1	Defensoría del Pueblo
2	Ministerio Público/ Fiscalía de la Nación
3	Distrito Fiscal de Amazonas
4	Distrito Fiscal de Ancash
5	Distrito Fiscal de Apurimac
6	Distrito Fiscal de Arequipa
7	Distrito Fiscal de Ayacucho
8	Distrito Fiscal de Cajamarca
9	Distrito Fiscal de Cañete
10	Distrito Fiscal de Callao
11	Distrito Fiscal de Cusco
12	Distrito Fiscal de Huancavelica
13	Distrito Fiscal de Huánuco
14	Distrito Fiscal de Huaura
15	Distrito Fiscal de Ica
16	Distrito Fiscal de Junín
17	Distrito Fiscal de La Libertad
18	Distrito Fiscal de Lambayeque
19	Distrito Fiscal de Lima
20	Distrito Fiscal de Lima Este
21	Distrito Fiscal de Lima Noroeste
22	Distrito Fiscal de Lima Norte
23	Distrito Fiscal de Lima Sur
24	Distrito Fiscal de Loreto
25	Distrito Fiscal de Madre de Dios
26	Distrito Fiscal de Moquegua
27	Distrito Fiscal de Pasco
28	Distrito Fiscal de Piura
29	Distrito Fiscal de Puno
30	Distrito Fiscal de San Martín
31	Distrito Fiscal de Santa
32	Distrito Fiscal de Selva Central

33	Distrito Fiscal de Sullana
34	Distrito Fiscal de Tacna
35	Distrito Fiscal de Tumbes
36	Distrito Fiscal de Ucayali
37	Ministerio de Justicia
38	PRONACEJ - MINJUS
39	Poder Judicial Perú - Central
40	INPE
41	Policía Nacional del Perú
42	DIRINCRI - PNP
43	MIMP
44	MINSA
45	ESSALUD

2.2. Se solicitó información referida a sentencias y expedientes respecto a delitos de aborto no forzado de los años 2012 a 2022 a las siguientes entidades públicas:

Nro.	Entidad
1	Poder Judicial - Central
2	Corte Suprema de la República
3	Distrito Judicial de Amazonas
4	Distrito Judicial de Ancash
5	Distrito Judicial de Apurímac
6	Distrito Judicial de Arequipa
7	Distrito Judicial de Ayacucho
8	Distrito Judicial de Cajamarca
9	Distrito Judicial de Cañete
10	Distrito Judicial de Callao
11	Distrito Judicial de Cusco
12	Distrito Judicial de Huancavelica
13	Distrito Judicial de Huánuco
14	Distrito Judicial de Huaura
15	Distrito Judicial de Ica
16	Distrito Judicial de Junín
17	Distrito Judicial de La Libertad
18	Distrito Judicial de Lambayeque
19	Distrito Judicial de Lima
20	Distrito Judicial de Lima Este
21	Distrito Judicial de Lima Noroeste
22	Distrito Judicial de Lima Norte
23	Distrito Judicial de Lima Sur
24	Distrito Judicial de Loreto
25	Distrito Judicial de Madre de Dios
26	Distrito Judicial de Moquegua

27	Distrito Judicial de Pasco
28	Distrito Judicial de Piura
29	Distrito Judicial de Puno
30	Distrito Judicial de San Martín
31	Distrito Judicial de Santa
32	Distrito Judicial de Selva Central
33	Distrito Judicial de Sullana
34	Distrito Judicial de Tacna
35	Distrito Judicial de Tumbes
36	Distrito Judicial de Ucayali

Anexo 3. Detalle de las guías de entrevistas por perfil

Guías por perfil	Objetivos
1) Guía de entrevista para personas gestantes 2) Guía de entrevista para familiares de personas imputadas 3) Guía de entrevista para proveedores/as de salud 4) Guía de entrevista para acompañantes de personas imputadas	- Comprender las experiencias y decisiones de las mujeres respecto al aborto o evento obstétrico, incluyendo la elección del método de interrupción del embarazo, la información disponible sobre el método y la percepción de seguridad. - Explorar el proceso penal relacionado con el aborto o evento obstétrico que enfrentaron las mujeres, incluyendo la acusación, el entendimiento de las consecuencias, la información proporcionada durante el proceso y las emociones que experimentaron. - Analizar la experiencia de las mujeres con la defensa legal, incluyendo si tuvieron una defensa oficial o particular, el costo de la defensa y cómo financiaron los gastos legales. - Investigar las condiciones de detención que enfrentaron las mujeres, incluyendo el tipo de detención (prisión preventiva o pena efectiva), la duración, el lugar de detención, las visitas recibidas y los posibles problemas de salud durante ese período.
3) Guía de entrevista para proveedores/as de salud	- Explorar la experiencia y percepción de los profesionales de la salud que atienden casos relacionados con el aborto y otros eventos obstétricos, incluyendo la frecuencia con la que atienden a personas en estas situaciones y si han atendido casos de embarazos producto de violencia sexual. - Investigar el estigma asociado a los profesionales de la salud que realizan abortos. Además, se busca indagar sobre la obligación legal de denunciar estos casos y la posible presión que puedan enfrentar para hacerlo, especialmente en el contexto de los sistemas de salud público y privado.
4) Guía de entrevista para acompañantes de personas imputadas	- Investigar la experiencia y percepción de las activistas que brindan apoyo a mujeres, niñas y personas gestantes que atraviesan situaciones de aborto, especialmente en casos de embarazos producto de violencia sexual. Se busca entender la frecuencia con la que acompañan estos casos, el estigma que puedan enfrentar y si han sido denunciados o han sufrido hostigamiento por parte de la policía u otras fuerzas judiciales debido a sus actividades. - Evaluar el impacto de la criminalización del aborto en las personas que optan por la interrupción del embarazo mediante el uso de medicamentos. Se busca indagar sobre la incidencia de complicaciones post-aborto en este contexto y si las personas han enfrentado persecución penal u otros desafíos legales debido a su elección reproductiva.

Guías por perfil	Objetivos
5) Guía de entrevista para abogadas/os y defensores de casos seleccionados 6) Guía de entrevista sobre contexto a funcionarios/as del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscalía de la Nación y de la Policía Nacional del Perú	- Conocer detalles sobre la persona imputada, conocer las circunstancias específicas del caso por el que está siendo imputada, si hubo detención, y si hubo sanciones impuestas tras el proceso penal. - Identificar cómo el proceso penal puede afectar diversos aspectos de la vida de la persona imputada. - Indagar sobre el impacto de movimientos político-sociales relacionados con la despenalización del aborto en la región en las prácticas judiciales y resultados de los casos. - Indagar sobre el impacto de movimientos político-sociales relacionados con la despenalización del aborto en la región en las prácticas judiciales y resultados de los casos.
6) Guía de entrevista sobre contexto a funcionarios/as del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscalía de la Nación y de la Policía Nacional del Perú	- Obtener información sobre si la persona funcionaria ha intervenido en casos relacionados con la criminalización del aborto u otros eventos obstétricos, y si ha enfrentado dificultades o riesgos como resultado de intervenir en estos casos. - Indagar sobre el impacto de movimientos político-sociales relacionados con la despenalización del aborto en la región en las prácticas judiciales y resultados de los casos.
7) Guía de entrevista sobre contexto a personal de salud	- Comprender el papel de los proveedores de salud y hospitales en el proceso de denuncia de casos de aborto u otros eventos obstétricos, indagando sobre la obligación legal de denunciar a las usuarias y la posible presión al personal de salud para hacerlo. - Indagar sobre el impacto de movimientos político-sociales relacionados con la despenalización del aborto en la región en las prácticas judiciales y resultados de los casos.
8) Guía de entrevista sobre contexto a activistas por el derecho a decidir	- Obtener información sobre el contexto y las percepciones relacionadas con el aborto y eventos obstétricos desde la perspectiva de activistas. - Indagar sobre el impacto de movimientos político-sociales relacionados con la despenalización del aborto en la región en las prácticas judiciales y resultados de los casos.

Anexo 4. Mapeo de medios de información

Medios de información revisados

Diario	Dpto / Macro Región	Link
EL CLARÍN	Amazonas	www.clarinmedios.com.pe
CHIMBOTE EN LÍNEA	Áncash	www.chimbotenlinea.com
PRENSA REGIONAL	Áncash	www.prensaregionalancash.com
ANCASH NOTICIAS	Áncash	www.ancashnoticias.com
DIARIO DE CHIMBOTE	Áncash	www.diariodechimbote.com
DIARIO DE	Áncash	PÁGINA NO DISPONIBLE
HUARAZ EN LÍNEA	Áncash	www.huarazenlinea.com
PRENSA HUARAZ	Áncash	www.prensahuaraz.com
CHASKI	Apurímac	www.chaski.pe
EXPRESIÓN	Apurímac	www.diarioexpresion.pe
PREGÓN	Apurímac	www.pregon.com.pe
CHASKI	Arequipa	www.diariochaski.com.pe
SIN FRONTERAS	Arequipa	https://diariosinfronteras.com.pe/
JORNADA	Ayacucho	www.jornada.com.pe
EN VOZ ALTA	Ayacucho	PÁGINA NO DISPONIBLE
TRIBUNA	Ayacucho	PÁGINA NO DISPONIBLE
EL MERCURIO	Cajamarca	www.diarioelmercurio.pe
LA ROTATIVA	Cajamarca	www.larotativa.pe
PANORAMA CAJAMARQUINO	Cajamarca	https://diariopanoramacajamarquino.com/
PASCO LIBRE	Cerro de Pasco	www.pascolibre.com
EL DIARIO DE CUSCO	Cusco	www.diariodelcusco.pe
EL SOL	Cusco	www.diarioelsolcusco.pe
EL SIGLO	Huánuco	https://diarioelsiglo.pe/
TU DIARIO	Huánuco	www.tudiariohuanuco.pe
LA LUPA	Ica	www.lalupa.pe
LA OPINIÓN	Ica	www.diariolaopinion.pe
VERDAD DEL PUEBLO	Ica	www.verdaddelpueblo.com
AHORA	Iquitos - Pucallpa - Tara-poto	www.diarioahora.pe
PRIMICIA	Junín	DIARIO IMPRESO
NUEVO NORTE	La Libertad	DIARIO IMPRESO
TRUJILLO EN LÍNEA	La Libertad	www.trujilloenlinea.pe
ÚLTIMAS NOTICIAS	La Libertad	www.undiario.pe
EL NORTEÑO	Lambayeque	www.elnorteno.pe
LA INDUSTRIA	Lambayeque	www.laindustriadechiclayo....
CARETAS	Lima	www.caretas.pe
EL COMERCIO	Lima	www.elcomercio.pe
EL POPULAR	Lima	www.elpopular.pe
EXITOSA	Lima	www.exitosanoticias.pe
LA REPÚBLICA	Lima	www.larepublica.pe
TROME	Lima	www.trome.pe
WAYKA	Lima	www.wayka.pe
PERÚ 21	Lima	www.peru21.pe
OJO	Lima	www.ojo.pe

CORREO	Lima	www.diariocorreo.pe
DIARIO UNO	Lima	www.diariouno.pe
GESTIÓN	Lima	www.gestion.pe
LA MULA	Lima	www.lamula.pe
LA PRIMERA	Lima	www.laprimera.pe
HUACHO EN LÍNEA	Lima provincia	PÁGINA NO DISPONIBLE
HUARAL EN LÍNEA	Lima provincia	www.huaralenlinea.com
LA REGIÓN	Loreto	www.diariolaregion.com
PRO Y CONTRA	Loreto	www.proycontra.com.pe
DON JAQUE	Madre de Dios	www.donjaque.com.pe
EL REGIONAL PIURA	Piura	www.elregionalpiura.com.pe
LA HORA	Piura	www.lahora.pe
LO DICE LA GENTE	Piura	www.lodicelagente.com
PANORAMA DIGITAL	Piura	www.panoramad.com.pe
WALAC	Piura	www.walac.pe
LOS ANDES	Puno	www.losandes.com.pe
EL ALTIPLANO	Puno	PÁGINA NO DISPONIBLE
HOY	San Martín	www.diariohoy.com.pe
MOYOBAMBA NOTICIAS	San Martín	www.moyobamba.com
VOCES	San Martín	www.diariovoces.com.pe
HECHICERA	Tumbes	www.diariohechicera.com
ÍMPETU	Ucayali	www.impetu.pe

Anexo 5. Proyectos de Ley para la despenalización del aborto

Periodo parlamentario	Proyecto de Ley	Fecha	Sumilla de propuesta	Estado
1995-2000	01344	29/05/1996	Modificando el artículo 120° del Decreto Legislativo N° 635 -no es punible el aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer embarazada, cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera del matrimonio, o inseminación artificial no consentida-.[96]	Actualizado
	01855	16/09/1996	Modificando el artículo 120° del Decreto Legislativo N° 635 -no es punible el aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer embarazada, cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera del matrimonio, o inseminación artificial no consentida-.[97]	Archivado
	04047	25/09/1998	Modifica el artículo 120° del Decreto Legislativo N° 635 "Código Penal" -no es punible el aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere.[98]	Dictamen negativo

96. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey1995.nsf/4ddaa53c5fb-314620525800b007fc25d/a6ffefaf15456c9205256ce10069f442?OpenDocument
97. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey1995.nsf/4ddaa53c5fb-314620525800b007fc25d/77337ee8c68f6ea505256ce10069f637?OpenDocument
98. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey1995.nsf/b53c83abac-

2001-2006	00421	23/08/2001	Propone modificar el artículo 119° del Código Penal, el cual versa sobre Aborto Terapéutico (En concreto, amplía el aborto terapéutico a casos de malformaciones fetales o cualquier patología fetal que sea incompatible con la vida).[99]	En comisión de Justicia
	05439	30/01/2003	Propone modificar el artículo 118° del Código Penal, respecto al aborto preterintencional (En concreto, despenaliza los casos de abortos no intencionales para las mujeres).[100]	En comisión de Justicia
	10957/ 2003-CR	07/07/2004	Propone modificar el artículo 119° del Código Penal, referente a penalizar el aborto sentimental y eugenésico (En concreto, propone despenalizar el aborto sentimental y eugenésico).[101]	En comisión de Justicia
2011-2016	03839/ 2014-IC	26/09/2014	Propone Ley que despenaliza el aborto en los casos de embarazos a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas.[102]	Dictamen Negativo
2016-2021	387/2016-CR	12/10/2016	Propone modificar los artículos 119 y 120 del Código Penal, a fin de que se despenalice, junto con el aborto por razones terapéuticas, el aborto cuando sea el resultado de un acto de violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentidas, y el aborto en caso de malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.[103]	Archivado
	7298/2020-CR	09/03/2021	Propone regular el derecho a la maternidad libremente decidida, la interrupción voluntaria del embarazo y la atención sanitaria pre y post aborto en los servicios del sistema de salud.[104]	Archivado
2021-2026	954/2021-CR	10/12/2021	Propone despenalizar el aborto en casos de embarazos como consecuencia de violación sexual.	En comisión (Salud y Población) (Justicia y Derechos Humanos)
	05462/2022-CR	22/06/2023	Propone modificar el artículo 119 del decreto legislativo 635 Código Penal, con la finalidad de despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo en menores de catorce años de edad.[105]	En comisión (Constitución y Reglamento) (Justicia y Derechos Humanos)

4d7a2105256cdf006c92c9/c76257b53566928905256ce1006a35d0?OpenDocument

99. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2001.nsf/c712c406b6c4531005256cdf006c92c5/4fea17df84bf9bf205256d24007a860c?OpenDocument

100. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/clproley2001.nsf/ee3e4953228bd84705256dcd008385e7/03874ef6805ed73905256d24007aa92d?OpenDocument

101. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/clproley2001.nsf/8fd4dd3b28ba7e3705256cdf006c92c2/190a98889226d73c05256eca0078f6e5?OpenDocument

102. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/f7fff46988ca05b1052578e100829cc7/ac5c663ed6e0d7cd052583850063ae66?OpenDocument

103. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/641842f7e5d631bd052578e20058a231/ddfb9dd5756d81360525804a006032fe?OpenDocument

104. Disponible en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/954

105. Disponible en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/5462

Anexo 6. Proyectos de Ley para la criminalización del aborto o la restricción de su acceso

Periodo parlamentario	Proyecto de Ley	Fecha	Propuesta	Estado
1995-2000	00636	09/11/1995	Modificando el artículo 117º del Código Penal aprobado por Decreto Legislativo Nº 635 -referente al aborto con abuso de ciencia o arte-.[106]	Dictamen negativo
	02263	21/11/1996	Proyecto de Ley General de Salud. Incluye materia sanitaria y reemplaza al Código Sanitario. (En concreto, impone la obligación del personal de salud de reportar casos de "aborto criminal" a las autoridades).[107]	Promulgado (Ley No. 26842)
	02310	27/11/1996	Modificando el artículo 117º del Código Penal aprobado por Decreto Legislativo Nº 635 -el médico, obstetra, farmacéutico cualquier profesional sanitario o practicante de medicina u otra profesión sanitaria, que abuse de su ciencia o arte para causar el aborto, será reprimido con la pena de los artículos 115º y 116º-.[108]	Dictamen negativo

106. Aunque en la página oficial del Congreso de la República no se visualiza el texto del proyecto de ley, se asume que dicha iniciativa legislativa buscaba la penalización de profesionales de la salud tras considerar el alcance similar del Proyecto de Ley 02310. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey1995.nsf/4ddaa53c5fb314620525800b007fc25d/8fa903135112cab905256ce10069f18d?OpenDocument

107. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey1995.nsf/b53c83abac-4d7a2105256cdf006c92c9/87779e6713bbf79e05256ce10069f7c1?OpenDocument

108. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey1995.nsf/b53c83abac-4d7a2105256cdf006c92c9/c925e6508aa559d205256ce1006a2f5d?OpenDocument

2001-2006	00122	27/07/2011	Propone declarar el 25 de marzo de cada año como "Día del Niño por Nacer".[109]	Promulgado (Ley No. 27653)
	00839	28/09/2001	Propone incorporar el artículo 124º-A en el Código Penal, tipificando el delito de Lesiones en el Concebido.[110]	Promulgado (Ley No. 27716)
	01696	01/04/2002	Propone modificar los artículos 114º "Autoaborto"; 115º "Aborto Consentido"; 116º "Aborto no consentido"; 117º "Aborto agravado en función del agente"; 118º "Aborto preterintencional"; 119º "Aborto terapéutico, necesario o impune" (En concreto, incrementa las penas).[111]	Retirado por su autor
	11083/ 2004-CR	04/08/2004	Propone modificar diversos artículos del Código Penal: 114º "autoaborto"; 115º "aborto consentido"; 116º "aborto sin consentimiento"; 117º "agravación de la pena por la calidad del sujeto"; 118º "aborto preterintencional" (En concreto, incrementa las penas).[112]	En comisión de Justicia y Derechos Humanos
2006-2011	02878/ 2008-CR	24/11/2008	Propone modificar los artículos 119º y 120º del Código Penal, que permite el aborto terapéutico y el aborto sentimental o eugenésico (En concreto, reduce el límite gestacional a 60 días y descriminaliza el aborto en casos de anencefalia del feto).[113]	En comisión Constitución y Reglamento – Justicia

109. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2001.nsf/c712c406b6c4531005256cdf006c92c5/7cc8c251c863263b05256d24007a840c?OpenDocument
110. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/clproley2001.nsf/9bba44d13f57c-4320525805d007aba15/9dd9707da5b412ff05256d24007a88ef?OpenDocument
111. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/clproley2001.nsf/4b03dfeac6f44cc-005256d4e00568377/992f80b2ce9e873e05256d24007a8ef9?OpenDocument
112. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/clproley2001.nsf/4b03dfeac6f44cc-005256d4e00568377/4fbfb35c9526644e05256ee6007c84aa?OpenDocument
113. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/1199d6d53176bbb-d052571b600638ce7/8dc747203095eddf0525750c0052aa6c?OpenDocument

2011-2016	03648/ 2013-CR	25/06/2014	Prohíbase la exhibición en lugares o vías públicas de manera directa, indirecta, anuncios en medios de comunicación masiva conteniendo publicidad sugerente, explícita o implícita que promuevan el aborto bajo cualquier modalidad.[114]	En comisión
	03962/2014-CR	07/11/2014	Propone incorporar el delito de aborto culposo y modifica el artículo 124-A del Código Penal.[115]	Presentado (Añadido al texto sustitutorio del Código Penal)
	04101/2014-CR	18/12/2014	Propone modificar los artículos 290, 363, y 364 del Código Penal, referidos a los delitos de ejercicio ilegal de la medicina y ejercicio ilegal de la profesión, para prohibir las prácticas desleales que promueven e incentivan la comisión del aborto, mediante la publicidad en volantes publicitarios, o medios escritos de comunicación masiva prensa o en las redes sociales (internet).[116]	Añadido al texto sustitutorio del Código Penal
2021-2026	00785/2021-CR	18/11/2021	Ley que reconoce derechos al concebido (busca limitar el acceso al aborto terapéutico)[117].	Promulgado (Ley No. 31935)
	00904/2021-CR	07/12/2021	Propone impulsar la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú (En concreto, obstaculiza la Educación Sexual Integral).[118]	Promulgado (Ley No. 31498)
	01520/2021-CR	24/03/2022	Propone promover la protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar.[119]	En agenda del pleno

114. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/f7fff46988ca-05b1052578e100829cc7/388db395913b9ee0052583850063ad3c?OpenDocument
115. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2011.nsf/b82580d36391e-10405257e1f006236ca/9dd5d1b029399d3c052583850063af26
116. Disponible en el siguiente enlace: https://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/clproley2011.nsf/9817cee62a-c9ee0a052578e100829cc4/e6ebc17c2e337b0b052583850063affe?OpenDocument
117. Disponible en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/785
118. Disponible en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/904
119. Disponible en el siguiente enlace: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/1520

Proyecta igualdad
Copyright © 2025 Proyecta igualdad Perú
Todos los derechos reservados.